[REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

FACULTE DE MEDECINE ET DES SCIENCES BIOMEDICALES

DEPARTEMENT DE SANTE PUBLIQUE

CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION DOCTORALE EN SCIENCES DE LA VIE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

UNITE DE RECHERCHE ET DE FORMATION DOCTORALE EN SANTE ET ENVIRONNEMENT

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

FACULTY OF MEDECINE AND BIOMEDICAL SCIENCES

DEPARTEMENT OF PUBLIC HEALTH

RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING CENTER IN LIFE, HEALTH AND ENVIRONNEMENTAL SCIENCES

RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING UNIT IN HEALTH AND ENVIRONMENT

Revue bibliométrique de la production scientifique d'un centre de recherche en Afrique : le site ANRS/MIE Cameroun

Mémoire rédigé en vue de l'obtention du Master en Santé publique par :

MINLO NYANGON Éliane Fernande, *MD, SP3 Santé publique*
Matricule N° : 22E0028

Sous la direction de :

ESSI Marie-José, *PhD*
Anthropologie médicale

VARLOTEAUX Marie, *PhD*
Santé Publique
Chercheur Site ANRS-MIE Cameroun

Année académique 2023-2024

PRELIMINAIRES

SOMMAIRE

PRELIMINAIRES II
SOMMAIRE III
DEDICACE IV
REMERCIEMENTS V
LISTE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANT DE LA FMSB/UYI VI
ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES XVIII
LISTE DES ANNEXES XXII
ABSTRACT XXV
INTRODUCTION 1
PROBLEMATIQUE 4
REVUE DE LA LITTERATURE 7
METHODOLOGIE 23
RESULTATS 29
DISCUSSION 43
CONCLUSION 50
RECOMMANDATIONS 52
REFERENCES 54
ANNEXES 59

DEDICACE

A mes parents,

Feu DR MINLO JOSUE Et

Mme MINLO née OSSELE MARTHE ;

Qui ont œuvré pour ma réussite, de par leur amour, leur soutien, tous les sacrifices consentis et leurs précieux conseils, pour toute leur assistance et leur présence dans ma vie, recevez à travers ce travail aussi modeste soit-il, l'expression de mes sentiments et de mon éternelle gratitude.

REMERCIEMENTS

Je remercie le Seigneur **DIEU** Tout Puissant et Miséricordieux, qui m'a donné la force et la patience d'accomplir ce modeste travail.

J'adresse également ma sincère gratitude :

-Au Professeur **ESSI Marie-José**, qui a bien voulu diriger ce travail. Merci pour sa disponibilité, sa patience, ses conseils. Qu'elle trouve ici l'expression de mon profond respect.

-Au Docteur **VARLOTEAUX Marie**, pour avoir accepté de codiriger ce travail, pour sa disponibilité, ses conseils, sa patience, les enseignements dispensés et les remarques précieuses ayant permis de mener à bon port ce travail de recherche.

- Au Doyen de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, le Professeur **NGO UM Esther Juliette épse MEKA** et à son staff administratif et enseignant, pour leur disponibilité et pour la rigueur dans les enseignements dispensés tout au long de ces années.

- Au Professeur **ZOUNG-KANYI BISSEK Anne-Cécile**, Coordonnateur SUD du site ANRS/MIE Cameroun, pour l'intérêt qu'elle a porté à ce travail de recherche en nous autorisant à le mener au sein du site dont elle a charge ;

-A ma très chère mère, **Madame MINLO Marthe**, pour ses sacrifices, son soutien, sa générosité et sa tendresse. Elle qui était toujours là près de moi, pour me soutenir, m'encourager et me guider avec ses précieux conseils. Aucun mot ne saurait exprimer ma grande reconnaissance, ma gratitude et mon profond amour.

-A mes **frères, sœurs, cousins, cousines, tantes et oncles** pour leur amour et leur encouragement.

-Au papa de mes adorables filles, **Brice ESSOMBA**, pour son soutien et ses encouragements.

-A mes amis : **Danielle Sikati, Dr NGO YAP Ki-Singue, Ariane NGO NDJEBET, Dr Marilyn KOUMBO, Dr TOWA Fally, Dr Ingrid Suzy BALEMAKEN, Dr Fabrice ASSESSA, Dr Vanessa MANGON,** pour tout leur soutien et leur amour.

- A mes promotionnaires du cycle de spécialisation de Santé publique : **Drs EDZAMBA Michel, ABDOUL NASSIR, NGON SANI Bertille, TCHOUKOUAN NYA Miriette, TSAFACK Golda, SADOU Hamadou, SIME DJOMO Sandra ;**

- A mes camarades de l'école doctorale santé et environnement de la Faculté de Médecine et de sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1.

- A tous ceux que je n'ai pas cités et qui de près ou de loin ont contribué à la bonne marche de ma formation et de mon travail de recherche.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

LISTE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANT DE LA FMSB/UYI

1. PERSONNEL ADMINISTRATIF

Doyen : Pr NGO UM Esther Juliette épse MEKA

Vice-Doyen chargé de la programmation et du suivi des activités académiques : Pr NTSAMA ESSOMBA Claudine Mireille

Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération : Pr ZEH Odile Fernande

Vice-Doyen chargé de la Scolarité, des Statistiques et du Suivi des Etudiants : Pr NGANOU Chris Nadège épse GNINDJIO

Chef de la Division des Affaires Académiques, de la Scolarité et de la Recherche : Dr VOUNDI VOUNDI Esther

Chef de la Division Administrative et Financière : Mme ESSONO EFFA Muriel Glawdis

Coordonnateur Général du Cycle de Spécialisation : Pr NJAMNSHI Alfred KONGNYU

Chef de Service Financier : Mme NGAMALI NGOU Mireille Albertine épse WAH

Chef de Service Adjoint Financier: Mme MANDA BANA Marie Madeleine épse ENGUENE

Chef de Service de l'Administration Générale et du Personnel : Pr SAMBA Odette NGANO ép. TCHOUAWOU

Chef de Service des Diplômes, des Programmes d'enseignement et de la Recherche : Mme ASSAKO Anne DOOBA

Chef de Service Adjoint des Diplômes, des Programmes d'enseignement et de la Recherche : Dr NGONO AKAM MARGA Vanina

Chef de Service de la Scolarité et des Statistiques : Mme BIENZA Aline

Chef de Service Adjoint de la Scolarité et des Statistiques : Mme FAGNI MBOUOMBO AMINA épse ONANA

Chef de Service du Matériel et de la Maintenance : Mme HAWA OUMAROU

Chef de Service Adjoint du Matériel et de la Maintenance: Dr MPONO EMENGUELE Pascale épse NDONGO

Bibliothécaire en Chef par intérim : Mme FROUISSOU née MAME Marie-Claire

Comptable Matières : M. MOUMEMIE NJOUNDIYIMOUN MAZOU

2. COORDONNATEURS DES CYCLES ET RESPONSABLES DES FILIERES

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Coordonnateur Filière Médecine Bucco-dentaire : Pr BENGONDO MESSANGA Charles

Coordonnateur de la Filière Pharmacie : Pr NTSAMA ESSOMBA Claudine

Coordonnateur Filière Internat : Pr ONGOLO ZOGO Pierre

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Anatomie Pathologique : Pr SANDO Zacharie

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Anesthésie Réanimation : Pr ZE MINKANDE Jacqueline

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Chirurgie Générale : Pr NGO NONGA Bernadette

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Gynécologie et Obstétrique : Pr DOHBIT Julius SAMA

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Médecine Interne: Pr NGANDEU Madeleine

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Pédiatrie : Pr MAH Evelyn MUNGYEH

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Biologie Clinique : Pr KAMGA FOUAMNO Henri Lucien

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Radiologie et Imagerie Médicale: Pr ONGOLO ZOGO Pierre

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Santé Publique : Pr TAKOUGANG Innocent

Coordonnateur de la formation Continue : Pr KASIA Jean Marie

Point focal projet : Pr NGOUPAYO Joseph

Responsable Pédagogique CESSI : Pr ANKOUANE ANDOULO Firmin

3. DIRECTEURS HONORAIRES DU CUSS

Pr MONEKOSSO Gottlieb (1969-1978)

Pr EBEN MOUSSI Emmanuel (1978-1983)

Pr NGU LIFANJI Jacob (1983-1985)

Pr CARTERET Pierre (1985-1993)

4. DOYENS HONORAIRES DE LA FMSB

Pr SOSSO Maurice Aurélien (1993-1999)

Pr NDUMBE Peter (1999-2006)

Pr TETANYE EKOE Bonaventure (2006-2012)

Pr EBANA MVOGO Côme (2012-2015)

5. PERSONNEL ENSEIGNANT

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

N°	NOMS ET PRENOMS	GRADE	DISCIPLINE
	DEPARTEMENT DE CHIRURGIE ET SPECIALITES		
1	**SOSSO Maurice Aurélien (CD)**	P	Chirurgie Générale
2	DJIENTCHEU Vincent de Paul	P	Neurochirurgie
3	**ESSOMBA Arthur (CD par Intérim)**	P	Chirurgie Générale
4	HANDY EONE Daniel	P	Chirurgie Orthopédique
5	MOUAFO TAMBO Faustin	P	Chirurgie Pédiatrique
6	NGO NONGA Bernadette	P	Chirurgie Générale
7	NGOWE NGOWE Marcellin	P	Chirurgie Générale
8	OWONO ETOUNDI Paul	P	Anesthésie-Réanimation
9	ZE MINKANDE Jacqueline	P	Anesthésie-Réanimation
10	BAHEBECK Jean	MCA	Chirurgie Orthopédique
11	BANG GUY Aristide	MCA	Chirurgie Générale
12	BENGONO BENGONO Roddy Stéphan	MCA	Anesthésie-Réanimation
13	JEMEA Bonaventure	MCA	Anesthésie-Réanimation
14	BEYIHA Gérard	MC	Anesthésie-Réanimation
15	EYENGA Victor Claude	MC	Chirurgie/Neurochirurgie
16	FOUDA Pierre Joseph	MC	Chirurgie/Urologie
17	GUIFO Marc Leroy	MC	Chirurgie Générale
18	NGO YAMBEN Marie Ange	MC	Chirurgie Orthopédique
19	TSIAGADIGI Jean Gustave	MC	Chirurgie Orthopédique
20	AMENGLE Albert Ludovic	MA	Anesthésie-Réanimation
21	BELLO FIGUIM	MA	Neurochirurgie
22	BIWOLE BIWOLE Daniel Claude Patrick	MA	Chirurgie Générale
23	FONKOUE Loïc	MA	Chirurgie Orthopédique
24	KONA NGONDO François Stéphane	MA	Anesthésie-Réanimation
25	MBOUCHE Landry Oriole	MA	Urologie
26	MEKEME MEKEME Junior Barthelemy	MA	Urologie
27	MULUEM Olivier Kennedy	MA	Orthopédie-Traumatologie
28	NWAHA MAKON Axel Stéphane	MA	Urologie
29	SAVOM Eric Patrick	MA	Chirurgie Générale
30	AHANDA ASSIGA	CC	Chirurgie Générale
31	BIKONO ATANGANA Ernestine Renée	CC	Neurochirurgie

32	BWELE Georges	CC	Chirurgie Générale
33	EPOUPA NGALLE Frantz Guy	CC	Urologie
34	FOUDA Jean Cédrick	CC	Urologie
35	IROUME Cristella Raïssa BIFOUNA épse NTYO'O NKOUMOU	CC	Anesthésie-Réanimation
36	MOHAMADOU GUEMSE Emmanuel	CC	Chirurgie Orthopédique
37	NDIKONTAR KWINJI Raymond	CC	Anesthésie-Réanimation
38	NYANIT BOB Dorcas	CC	Chirurgie Pédiatrique
39	OUMAROU HAMAN NASSOUROU	CC	Neurochirurgie
40	ARROYE BETOU Fabrice Stéphane	AS	Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire
41	ELA BELLA Amos Jean-Marie	AS	Chirurgie Thoracique
42	FOLA KOPONG Olivier	AS	Chirurgie
43	FOSSI KAMGA GACELLE	AS	Chirurgie Pédiatrique
44	GOUAG	AS	Anesthésie Réanimation
45	MBELE Richard II	AS	Chirurgie Thoracique
46	MFOUAPON EWANE Hervé Blaise	AS	Neurochirurgie
47	NGOUATNA DJEUMAKOU Serge Rawlings	AS	Anesthésie-Réanimation
48	NYANKOUE MEBOUINZ Ferdinand	AS	Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
	DEPARTEMENT DE MEDECINE INTERNE ET SPECIALITES		
49	**SINGWE Madeleine épse NGANDEU (CD)**	P	Médecine Interne/Rhumatologie
50	ANKOUANE ANDOULO	P	Médecine Interne/ Hépato-Gastro-Entérologie
51	ASHUNTANTANG Gloria Enow	P	Médecine Interne/Néphrologie
52	BISSEK Anne Cécile	P	Médecine Interne/Dermatologie
53	KAZE FOLEFACK François	P	Médecine Interne/Néphrologie
54	KUATE TEGUEU Calixte	P	Médecine Interne/Neurologie
55	KOUOTOU Emmanuel Armand	P	Médecine Interne/Dermatologie
56	MBANYA Jean Claude	P	Médecine Interne/Endocrinologie
57	NDOM Paul	P	Médecine Interne/Oncologie

58	NJAMNSHI Alfred KONGNYU	P	Médecine Interne/Neurologie
59	NJOYA OUDOU	P	Médecine Interne/Gastroentérologie
60	SOBNGWI Eugène	P	Médecine Interne/Endocrinologie
61	PEFURA YONE Eric Walter	P	Médecine Interne/Pneumologie
62	BOOMBHI Jérôme	MCA	Médecine Interne/Cardiologie
63	FOUDA MENYE Hermine Danielle	MCA	Médecine Interne/Néphrologie
64	HAMADOU BA	MCA	Médecine Interne/Cardiologie
65	MENANGA Alain Patrick	MCA	Médecine Interne/Cardiologie
66	NGANOU Chris Nadège	MCA	Médecine Interne/Cardiologie
67	KOWO Mathurin Pierre	MC	Médecine Interne/ Hépato-Gastro-Entérologie
68	KUATE née MFEUKEU KWA Liliane Claudine	MC	Médecine Interne/Cardiologie
69	NDONGO AMOUGOU Sylvie	MC	Médecine Interne/Cardiologie
70	ESSON MAPOKO Berthe Sabine épse PAAMBOG	MA	Médecine Interne/Oncologie Médicale
71	ETOA NDZIE épse ETOGA Martine Claude	MA	Médecine Interne/Endocrinologie
72	MAÏMOUNA MAHAMAT	MA	Médecine Interne/Néphrologie
73	MASSONGO MASSONGO	MA	Médecine Interne/Pneumologie
74	MBONDA CHIMI Paul-Cédric	MA	Médecine Interne/Neurologie
75	NDJITOYAP NDAM Antonin Wilson	MA	Médecine Interne/Gastroentérologie
76	NDOBO épse KOE Juliette Valérie Danielle	MA	Médecine Interne/Cardiologie
77	NGAH KOMO Elisabeth	MA	Médecine Interne/Pneumologie
78	NGARKA Léonard	MA	Médecine Interne/Neurologie
79	NKORO OMBEDE Grâce Anita	MA	Médecine Interne/Dermatologue
80	NTSAMA ESSOMBA Marie Josiane épse EBODE	MA	Médecine Interne/Gériatrie
81	OWONO NGABEDE Amalia Ariane	MA	Médecine Interne/Cardiologie Interventionnelle
82	ATENGUENA OBALEMBA Etienne	CC	Médecine Interne/Cancérologie Médicale
83	DEHAYEM YEFOU Mesmin	CC	Médecine Interne/Endocrinologie

84	FOJO TALONGONG Baudelaire	CC	Médecine Interne/Rhumatologie
85	KAMGA OLEN Jean Pierre Olivier	CC	Médecine Interne/Psychiatrie
86	MENDANE MEKOBE Francine épse EKOBENA	CC	Médecine Interne/Endocrinologie
87	MINTOM MEDJO Pierre Didier	CC	Médecine Interne/Cardiologie
88	NTONE ENYIME Félicien	CC	Médecine Interne/Psychiatrie
89	NZANA Victorine Bandolo épse FORKWA MBAH	CC	Médecine Interne/Néphrologie
90	ANABA MELINGUI Victor Yves	AS	Médecine Interne/Rhumatologie
91	EBENE MANON Guillaume	AS	Médecine Interne/Cardiologie
92	ELIMBY NGANDE Lionel Patrick Joël	AS	Médecine Interne/Néphrologie
93	KUABAN Alain	AS	Médecine Interne/Pneumologie
94	NKECK Jan René	AS	Médecine Interne
95	NSOUNFON ABDOU WOUOLIYOU	AS	Médecine Interne/Pneumologie
96	NTYO'O NKOUMOU Arnaud Laurel	AS	Médecine Interne/Pneumologie
97	TCHOUANKEU KOUNGA Fabiola	AS	Médecine Interne/Psychiatrie
	DEPARTEMENT D'IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE		
98	**ZEH Odile Fernande (CD)**	P	Radiologie/Imagerie Médicale
99	GUEGANG GOUJOU. Emilienne	P	Imagerie Médicale/Neuroradiologie
100	MOIFO Boniface	P	Radiologie/Imagerie Médicale
101	ONGOLO ZOGO Pierre	MCA	Radiologie/Imagerie Médicale
102	SAMBA Odette NGANO	MC	Biophysique/Physique Médicale
103	MBEDE Maggy épse ENDEGUE MANGA	MA	Radiologie/Imagerie Médicale
104	MEKA'H MAPENYA Ruth-Rosine	CC	Radiothérapie
105	NWATSOCK Joseph Francis	CC	Radiologie/Imagerie Médicale Médecine Nucléaire
106	SEME ENGOUMOU Ambroise Merci	CC	Radiologie/Imagerie Médicale
107	ABO'O MELOM Adèle Tatiana	AS	Radiologie et Imagerie Médicale
	DEPARTEMENT DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE		
108	**NGO UM Esther Juliette épse MEKA (CD)**	MCA	Gynécologie-Obstétrique
109	FOUMANE Pascal	P	Gynécologie-Obstétrique
110	KASIA Jean Marie	P	Gynécologie-Obstétrique

111	KEMFANG NGOWA Jean Dupont	P	Gynécologie-Obstétrique
112	MBOUDOU Émile	P	Gynécologie-Obstétrique
113	MBU ENOW Robinson	P	Gynécologie-Obstétrique
114	NKWABONG Elie	P	Gynécologie-Obstétrique
115	TEBEU Pierre Marie	P	Gynécologie-Obstétrique
116	BELINGA Etienne	MCA	Gynécologie-Obstétrique
117	ESSIBEN Félix	MCA	Gynécologie-Obstétrique
118	FOUEDJIO Jeanne Hortence	MCA	Gynécologie-Obstétrique
119	NOA NDOUA Claude Cyrille	MCA	Gynécologie-Obstétrique
120	DOHBIT Julius SAMA	MC	Gynécologie-Obstétrique
121	MVE KOH Valère Salomon	MC	Gynécologie-Obstétrique
122	EBONG Cliford EBONTANE	MA	Gynécologie-Obstétrique
123	MBOUA BATOUM Véronique Sophie	MA	Gynécologie-Obstétrique
124	MENDOUA Michèle Florence épse NKODO	MA	Gynécologie-Obstétrique
125	METOGO NTSAMA Junie Annick	MA	Gynécologie-Obstétrique
126	NSAHLAI Christiane JIVIR FOMU	MA	Gynécologie-Obstétrique
127	NYADA Serge Robert	MA	Gynécologie-Obstétrique
128	TOMPEEN Isidore	CC	Gynécologie-Obstétrique
129	MPONO EMENGUELE Pascale épse NDONGO	AS	Gynécologie-Obstétrique
130	NGONO AKAM Marga Vanina	AS	Gynécologie-Obstétrique
	DEPARTEMENT D'OPHTALMOLOGIE, D'ORL ET DE STOMATOLOGIE		
131	**DJOMOU François (CD)**	P	ORL
132	ÉPÉE Émilienne épse ONGUENE	P	Ophtalmologie
133	KAGMENI Gilles	P	Ophtalmologie
134	NDJOLO Alexis	P	ORL
135	NJOCK Richard	P	ORL
136	OMGBWA EBALE André	P	Ophtalmologie
137	BILLONG Yannick	MCA	Ophtalmologie
138	DOHVOMA Andin Viola	MCA	Ophtalmologie
139	EBANA MVOGO Stève Robert	MCA	Ophtalmologie
140	KOKI Godefroy	MCA	Ophtalmologie

141	MINDJA EKO David	MC	ORL/Chirurgie Maxillo-Faciale
142	NGABA Olive	MC	ORL
143	AKONO ZOUA épse ETEME Marie Evodie	MA	Ophtalmologie
144	ANDJOCK NKOUO Yves Christian	MA	ORL
145	ATANGA Léonel Christophe	MA	ORL-Chirurgie Cervico-Faciale
146	MEVA'A BIOUELE Roger Christian	MA	ORL-Chirurgie Cervico-Faciale
147	MOSSUS Yannick	MA	ORL-Chirurgie Cervico-Faciale
148	MVILONGO TSIMI épse BENGONO Caroline	MA	Ophtalmologie
149	NANFACK NGOUNE Chantal	MA	Ophtalmologie
150	NGO NYEKI Adèle-Rose épse MOUAHA-BELL	MA	ORL-Chirurgie Cervico-Faciale
151	NOMO Arlette Francine	MA	Ophtalmologie
152	ASMAOU BOUBA Dalil	CC	ORL
153	BOLA SIAFA Antoine	CC	ORL
	DEPARTEMENT DE PEDIATRIE		
154	**ONGOTSOYI Angèle épse PONDY (CD)**	P	Pédiatrie
155	KOKI NDOMBO Paul	P	Pédiatre
156	ABENA OBAMA Marie Thérèse	P	Pédiatrie
157	CHIABI Andreas	P	Pédiatrie
158	CHELO David	P	Pédiatrie
159	MAH Evelyn	P	Pédiatrie
160	NGUEFACK Séraphin	P	Pédiatrie
161	NGUEFACK épse DONGMO Félicitée	P	Pédiatrie
162	NGO UM KINJEL Suzanne épse SAP	MCA	Pédiatrie
163	KALLA Ginette Claude épse MBOPI KEOU	MC	Pédiatrie
164	MBASSI AWA Hubert Désiré	MC	Pédiatrie
165	NOUBI Nelly épse KAMGAING MOTING	MC	Pédiatrie
166	EPEE épse NGOUE Jeannette	MA	Pédiatrie
167	KAGO TAGUE Daniel Armand	MA	Pédiatrie
168	MEGUIEZE Claude-Audrey	MA	Pédiatrie
169	MEKONE NKWELE Isabelle	MA	Pédiatre

170	TONY NENGOM Jocelyn	MA	Pédiatrie
	DEPARTEMENT DE MICROBIOLOGIE, PARASITOLOGIE, HEMATOLOGIE ET MALADIES INFECTIEUSES		
171	**MBOPI KEOU François-Xavier (CD)**	P	Bactériologie/Virologie
172	ADIOGO Dieudonné	P	Microbiologie/Virologie
173	GONSU née KAMGA Hortense	P	Bactériologie
174	MBANYA Dora	P	Hématologie
175	OKOMO ASSOUMOU Marie Claire	P	Bactériologie/Virologie
176	TAYOU TAGNY Claude	P	Microbiologie/Hématologie
177	CHETCHA CHEMEGNI Bernard	MC	Microbiologie/Hématologie
178	LYONGA Emilia ENJEMA	MC	Microbiologie médicale
179	TOUKAM Michel	MC	Microbiologie médicale
180	NGANDO Laure épse MOUDOUTE	MA	Parasitologie médicale
181	BEYALA Frédérique	CC	Maladies Infectieuses
182	BOUM II YAP	CC	Microbiologie médicale
183	ESSOMBA Réné Ghislain	CC	Immunologie
184	MEDI SIKE Christiane Ingrid	CC	Maladies infectieuses
185	NGOGANG Marie Paule	CC	Biologie Clinique
186	NDOUMBA NKENGUE Annick épse MINTYA	CC	Hématologie
187	VOUNDI VOUNDI Esther	CC	Virologie médicale
188	ANGANDJI TIPANE Prisca épse ELLA	AS	Biologie Clinique/Hématologie
189	Georges MONDINDE IKOMEY	AS	Immunologie
190	MBOUYAP Pretty Rosereine	AS	Virologie
	DEPARTEMENT DE SANTE PUBLIQUE		
191	**KAMGNO Joseph (CD)**	P	Santé Publique/Epidémiologie
192	ESSI Marie José	P	Santé Publique/Anthropologie Médicale
193	TAKOUGANG Innocent	P	Santé Publique
194	BEDIANG Georges Wylfred	MCA	Informatique Médicale/Santé Publique
195	BILLONG Serges Clotaire	MC	Santé Publique
196	NGUEFACK TSAGUE	MC	Santé Publique/Biostatistiques

197	EYEBE EYEBE Serge Bertrand	CC	Santé Publique/Epidémiologie
198	KEMBE ASSAH Félix	CC	Epidémiologie
199	KWEDI JIPPE Anne Sylvie	CC	Epidémiologie
200	MBA MAADJHOU Berjauline Camille	CC	Santé Publique/Epidémiologie Nutritionnelle
201	MOSSUS Tatiana née ETOUNOU AKONO	CC	Expert en Promotion de la Santé
202	NJOUMEMI ZAKARIAOU	CC	Santé Publique/Economie de la Santé
203	NKENGFACK NEMBONGWE Germaine Sylvie	CC	Nutrition
204	ONDOUA MBENGONO Laura Julienne	CC	Psychologie Clinique
205	ABBA-KABIR Haamit-Mahamat	AS	Economie de la Santé
206	AMANI ADIDJA	AS	Santé Publique
207	ESSO ENDALLE Lovet Linda Augustine Julia	AS	Santé Publique
	DEPARTEMENT DES SCIENCES MORPHOLOGIQUES-ANATOMIE PATHOLOGIQUE		
208	**MENDIMI NKODO Joseph (CD)**	MC	Anatomie Pathologie
209	SANDO Zacharie	P	Anatomie Pathologie
210	BISSOU MAHOP Josué	MC	Médecine de Sport
211	KABEYENE OKONO Angèle Clarisse	MC	Histologie/Embryologie
212	AKABA Désiré	MC	Anatomie Humaine
213	NSEME ETOUCKEY Georges Eric	MC	Médecine Légale
214	NGONGANG Gilbert Frank Olivier	MA	Médecine Légale
215	MENDOUGA MENYE Coralie Reine Bertine épse KOUOTOU	CC	Anatomopathologie
216	ESSAME Eric Fabrice	AS	Anatomopathologie
	DEPARTEMENT DE BIOCHIMIE		
217	**NDONGO EMBOLA épse TORIMIRO Judith (CD)**	P	Biologie Moléculaire
218	PIEME Constant Anatole	P	Biochimie
219	AMA MOOR Vicky Joceline	P	Biologie Clinique/Biochimie
220	EUSTACE BONGHAN BERINYUY	CC	Biochimie

221	GUEWO FOKENG Magellan	CC	Biochimie
222	MBONO SAMBA ELOUMBA Esther Astrid	AS	Biochimie
	DEPARTEMENT DE PHYSIOLOGIE		
223	**ETOUNDI NGOA Laurent Serges (CD)**	P	Physiologie
224	ASSOMO NDEMBA Peguy Brice	MC	Physiologie
225	TSALA Emery David	MC	Physiologie
226	AZABJI KENFACK Marcel	CC	Physiologie
227	DZUDIE TAMDJA Anastase	CC	Physiologie
228	EBELL'A DALLE Ernest Remy Hervé	CC	Physiologie humaine
	DEPARTEMENT DE PHARMACOLOGIE ET DE MEDECINE TRADITIONNELLE		
229	**NGONO MBALLA Rose ABONDO (CD)**	MC	Pharmaco-thérapeutique africaine
230	NDIKUM Valentine	CC	Pharmacologie
231	ONDOUA NGUELE Marc Olivier	AS	Pharmacologie
	DEPARTEMENT DE CHIRURGIE BUCCALE, MAXILLO-FACIALE ET PARODONTOLOGIE		
232	**BENGONDO MESSANGA Charles (CD)**	P	Stomatologie
233	EDOUMA BOHIMBO Jacques Gérard	MA	Stomatologie et Chirurgie
234	LOWE NANTCHOUANG Jacqueline Michèle épse ABISSEGUE	CC	Odontologie Pédiatrique
235	MBEDE NGA MVONDO Rose	CC	Médecine bucco-dentaire
236	MENGONG épse MONEBOULOU Hortense	CC	Odontologie pédiatrique
237	NDJOH NDJOH Jules Julien	CC	Parodontologie/Implantologie
238	NOKAM TAGUEMNE Marie Elvire	CC	Médecine dentaire
239	BITHA BEYIDI Thècle Rose Claire	AS	Chirurgie Maxillo Faciale
240	GAMGNE GUIADEM Catherine M	AS	Chirurgie dentaire
241	KWEDI Karl Guy Grégoire	AS	Chirurgie bucco-dentaire
242	NIBEYE Yannick Carine Brice	AS	Bactériologie
243	NKOLO TOLO Francis Daniel	AS	Chirurgie bucco-dentaire
	DEPARTEMENT DE PHARMACOGNOSIE ET CHIMIE PHARMACEUTIQUE		
244	**NTSAMA ESSOMBA Claudine (CD)**	P	Pharmacognosie /Chimie pharmaceutique

245	NGAMENI Bathélémy	P	Phytochimie/ Chimie organique
246	NGOUPAYO Joseph	P	Phytochimie/Pharmacognosie
247	GUEDJE Nicole Marie	MC	Ethnopharmacologie/Biologie végétale
248	BAYAGA Hervé Narcisse	AS	Pharmacie
	DEPARTEMENT DE PHARMACOTOXICOLOGIE ET PHARMACOCINETIQUE		
249	**ZINGUE Stéphane (CD)**	MC	Physiologie et Pharmacologie
250	FOKUNANG Charles	P	Biologie Moléculaire
251	MPONDO MPONDO Emmanuel	P	Pharmacie
252	TEMBE Estella épse FOKUNANG	MC	Pharmacologie Clinique
253	ANGO Yves Patrick	AS	Chimie des substances naturelles
254	NENE AHIDJO épse NJITUNG TEM	AS	Neuropharmacologie
	DEPARTEMENT DE PHARMACIE GALENIQUE ET LEGISLATION PHARMACEUTIQUE		
255	**NNANGA NGA (CD)**	P	Pharmacie Galénique
256	MBOLE Jeanne Mauricette épse MVONDO MENDIM	CC	Management de la qualité, Contrôle qualité des produits de santé et des aliments
257	NYANGONO NDONGO Martin	CC	Pharmacie
258	SOPPO LOBE Charlotte Vanessa	CC	Contrôle qualité médicaments
259	ABA'A Marthe Dereine	AS	Analyse du Médicament
260	FOUMANE MANIEPI NGOUOPIHO Jacqueline Saurelle	AS	Pharmacologie
261	MINYEM NGOMBI Aude Périne épse AFUH	AS	Réglementation Pharmaceutique

P= Professeur

MCA= Maître de Conférences Agrégé

MC= Maître de Conférences

MA= Maître Assistant

CC = Chargé de Cours

AS = Assistant

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES

ANRS : Agence Nationale de la recherche sur le Sida et les Hépatites virales

ANRS/MIE : Agence Nationale de la recherche sur le Sida et les Hépatites virales/ Maladies infectieuses émergentes

ARV: Anti-retro viral

CERFIG : Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée

CNLS : Comité national de lutte contre le Sida

CNRS : Centre national de la recherche scientifique

CREMER: Centre de recherche sur les maladies émergentes et ré-émergentes

CRSM : Conseillers régionaux en santé mondiale

COCAC : Conseiller de coopération et d'action culturelle

COVID-19: Coronavirus disease 2019

DROS : Division de la recherche opérationnelle en santé

EDS : Enquête démographique et de Santé

ETI: Expert technique international

HAART: Highly active antiretroviral therapy

IBB : Institut Bouisson-Bertrand

IFORD : Institut de formation et de recherche démographique

IMEA: Institute of environmental management and assessment

IMPM : Institut de recherches médicales et d'études des plantes médicinales

INRB : Institut national de recherche biomédicale

INSERM: Institut national de la santé et de la recherche médicale

IRD : Institut de recherche et développement

IRSA: Institut inter régional pour la santé

ISPED : Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement

IST : Infection sexuellement transmissible

MINSANTE : Ministère de la sante publique

MNT : Maladies non transmissibles

MVE : Maladie à Virus Ébola

ODD : Objectifs de Développement durable

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non gouvernementale

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

PACI-CI : Programme d'appui communautaire des instituts- Cote d'ivoire

PEC : Prise en charge

PNLS : Programme National de lutte contre le Sida

PSN: Plan Stratégique national

PVVIH : Personnes vivant avec le VIH

RDC: République Démocratique du Congo

REDS : Réseau sur l'éthique, le droit et le Sida

SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

SNRS : Systèmes de recherche nationaux sur la santé

UE : Union Européenne

VIH : Virus de l'immunodéficience Humaine

VHA : Virus de l'hépatite A

VHB : Virus de l'hépatite B

VHC : Virus de l'Hépatite C

VHE : Virus de l'hépatite E

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Recherche et prise de décision entre 2011 et 2015. 14
Tableau II : Partenaires principaux du site ANRS/MIE Cameroun 34
Tableau III : Investigateurs clés basés sur le nombre de projets coordonnés. 36
Tableau IV : Répartition des projets selon les thèmes et domaines de recherche 37
Tableau V : Répartition des publications scientifiques les plus citées 39
Tableau VI : Caractéristiques générales des participants 40
Tableau VII : Diffusion des résultats issus de la recherche par les chercheurs 41
Tableau VIII : Accès aux recommandations/élaboration des politiques par les décideurs..... 41

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Valoriser et diffuser les résultats de la recherche 10
Figure 2 : Typologie de production scientifique 11
Figure 3 : Prise de décision basée sur les preuves 11
Figure 4 : Logiciel Publish or Perish 26
Figure 5 : Grille d'analyse entretiens chercheurs 27
Figure 6 : Historique du site ANRS|MIE Cameroun 30
Figure 7 : Bureaux du site ANRS/MIE Cameroun 31
Figure 8 : Organisation générale du Site ANRS/MIE Cameroun 32
Figure 9 : Missions du site ANRS/MIE Cameroun 33
Figure 10 : Répartition annuelle du nombre de projets entre 2005 et 2022 35
Figure 11 : Distribution des pays ayant collaboré le plus avec le Cameroun 36
Figure 12 : Répartition des projets selon les types d'études 37
Figure 13 : Nombre d'articles publiés par projets financés depuis 2005 38
Figure 14 : Schéma de recrutement des participants 40
Figure 15: Apport scientifique du site ANRS/MIE Cameroun 42

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Clairance éthique de la FMSB/UY1 60
Annexe 2 : Autorisation de collecte des données du site ANRS/MIE Cameroun 61
Annexe 3 : Note d'information 62
Annexe 4 : Formulaire de consentement éclairé 64
Annexe 5 : Guide d'entretien 65
Annexe 6 : Bibliographie ANRS/MIE 67

RESUME

Contexte : La bibliométrie est une méthode d'analyse quantitative utilisant les publications scientifiques et différents indicateurs pour mesurer la performance de la recherche. Elle est constituée de diverses méthodes mathématiques et statistiques qui permettent d'effectuer des analyses quantitatives des sciences et de mesurer, également, les dimensions sociologiques associées à la diffusion de recherches sous forme de publications. Les systèmes de recherche nationaux sur la santé (SNRS), dont l'objectif premier est de produire des connaissances scientifiques de haute qualité et d'assurer leur utilisation en vue de promouvoir, restaurer et/ou maintenir la santé d'une population, se sont avérés inadéquats et à des degrés divers sur le continent africain. Les capacités de recherche limitées et la faible reconnaissance mondiale des chercheurs africains se traduisent par un faible taux de publications avec une contribution à moins de 0,5% au total des publications mondiales entre 2010 et 2014. Par ailleurs, de plus en plus des institutions de recherche font des analyses bibliométriques car les scientifiques sont désormais réputés performants à la seule condition que leurs travaux soient abondamment cités. Les maladies infectieuses émergeantes ou ré-émergeantes se manifestent de façon périodique, et une partie d'entre elles est la cause d'épidémies ou de pandémies pouvant décimer des populations. Elles constituent un problème majeur de santé publique d'où l'importance de mener cette étude afin d'améliorer l'accès aux connaissances disponibles et l'usage de celles-ci par les décideurs. Au Cameroun le site partenaire ANRS/MIE Cameroun créé en 2005, a participé à deux décennies de recherche ayant conduit à la production d'une importante quantité de travaux de recherche ayant amélioré les recommandations nationales et internationales.

Objectifs : Cette étude avait pour but de mener une revue bibliométrique de la production scientifique du site ANRS/MIE Cameroun et rencontrer/échanger avec certains chercheurs et décideurs dont les projets de recherche ont été financés par l'ANRS/MIE Cameroun. Spécifiquement il était question de décrire le site ANRS/MIE Cameroun, de faire un état des lieux des travaux scientifiques du site ANRS/MIE Cameroun depuis 2005, et de décrire le processus de valorisation des résultats.

Méthodologie : Il s'agissait de mener une étude mixte (analyse bibliométrique et analyse qualitative). La durée de l'étude était d'environ 11 mois (du 1er Septembre 2022 au 31 juillet 2023). La population d'étude était constituée de publications scientifiques du site ANRS/MIE Cameroun, de décideurs institutionnels et de chercheurs Camerounais ayant bénéficié d'un financement de l'ANRS. La sélection s'est faite de manière aléatoire, par tirage au sort pour les chercheurs et les décideurs entre 2005 et maintenant ; Exhaustif pour la revue des projets de

2005 à maintenant. La collecte des données s'est faite à l'aide d'une grille d'entretien pour les chercheurs/décideurs, pré-testée et validée. Les entretiens étaient enregistrés, les audio ont été sauvegardé et anonymisés. Ils ont été ensuite retranscrits en intégralité sur feuille Word. Ces retranscriptions ont été elles-mêmes codés et anonymisés. Le répertoire composé de tous les projets qui ont été menés depuis la création du site ANRS/MIE Cameroun a été nettoyé et enrichi par les informations issues du Logiciel Publish or Perish.

Résultats : Le Site ANRS-Cameroun est un site partenaire de l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales, Maladies infectieuses émergentes (ANRS|MIE) qui s'intègre dans la politique et le système national de santé du Cameroun. Il dispose de ressources humaines à 3 niveaux pour mener à bien ses activités. Sa mission principale étant l'animation scientifique, l'évaluation, la coordination et le financement de la recherche sur le VIH/Sida, les hépatites virales, les IST, la Tuberculose et les maladies infectieuses émergentes. Il a financé au total 90 projets de recherche avec 240 publications depuis 2005. Tous les domaines de recherche étaient retrouvés : les sciences sociales (47%), la virologie (30%), la recherche fondamentale (15%) et la prévention (2%). Les thématiques prioritaires étaient le VIH (79%), les Hépatites (10%), les MIE (8%) et les co-infections VIH/TB (3%). L'analyse des entretiens approfondis conduits auprès de sept informateurs clés a mis en évidence plusieurs défauts à savoir : des difficultés à l'obtention des autorisations, des difficultés à l'obtention de financements, et la faible compétence à la pratique de certains chercheurs. La restitution des travaux de recherche se faisait auprès des autorités, auprès des participants, dans des conférences internationales et nationales, et dans des journaux à comité de lecture. Mais aussi, des restitutions aux associations de malades et l'organisation des rencontres réunissant praticiens, cliniciens, et autres chercheurs étaient fortement demandées. D'après les personnes interrogées il serait important de faire également des délibérations et une note synthétique de ce qui a été trouvé afin d'émettre des recommandations concrètes basées sur les résultats des recherches à la question.

Conclusion : Le site ANRS/MIE Cameroun a produit de nombreuses connaissances, sur des thématiques et des domaines divers. Toutefois, on note que malgré cette production importante d'informations, celles-ci restent sous utilisées lors de l'élaboration des politiques publiques en santé au niveau national. En guise d'explication, nous avons relevé plusieurs défauts de la phase d'élaboration des projets de recherche à la phase de restitution des résultats de ces recherches. A cela pourrait s'ajouter une formation insuffisante des chercheurs à l'échelle nationale et une collaboration insuffisante entre chercheurs et décideurs à l'implémentation des recommandations issues de la recherche.

Mots-clés : Bibliométrie, Recherche, ANRS/MIE Cameroun.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

ABSTRACT

Context: Bibliometrics is a method of quantitative analysis using scientific publications and different indicators to measure research performance. It is made up of various mathematical and statistical methods which make it possible to carry out quantitative analyzes of science and also to measure the sociological dimensions associated with the dissemination of research in the form of publications. National health research systems (NHRS), whose primary objective is to produce high-quality scientific knowledge and ensure its use to promote, restore and/or maintain the health of a population, are have proven to be inadequate and to varying degrees on the African continent. The limited research capacities and the low global recognition of African researchers result in a low publication rate with a contribution of less than 0.5% to total global publications between 2010 and 2014. Furthermore, more and more institutions research companies carry out bibliometric analyzes because scientists are now considered efficient on the sole condition that their work is widely cited. Emerging or re-emerging infectious diseases appear periodically, and some of them are the cause of epidemics or pandemics that can decimate populations. They constitute a major public health problem, hence the importance of carrying out this study in order to improve access to available knowledge and the use of it by decision-makers. In Cameroon, the ANRS/MIE Cameroun partner site, created in 2005, has participated in two decades of research which has led to the production of a significant quantity of research work which has improved national and international recommendations.

Objectives: This study aimed to conduct a bibliometric review of the scientific production of the ANRS/MIE Cameroon site and meet/exchange with certain researchers and decision-makers whose research projects were funded by the ANRS. Specifically, the aim was to describe the ANRS/MIE Cameroon site, to take stock of the scientific work on the ANRS/MIE Cameroon site since 2005, and to describe the process of valorizing the results.

Methodology: This involved conducting a mixed study (bibliometric analysis and qualitative analysis). The duration of the study was approximately 11 months (from September 1, 2022 to July 31, 2023). The study population consisted of scientific publications from the ANRS/MIE Cameroon site, institutional decision-makers and Cameroonian researchers who had received funding from the ANRS. The selection was made randomly, by drawing lots for researchers and decision-makers between 2005 and now; Exhaustive for the review of projects from 2005 to now. Data collection was done using an interview grid for researchers/decision makers, pre-tested and validated. The interviews were recorded, the audio was saved and anonymized. They were then transcribed in full onto a Word sheet. These transcriptions were themselves coded

and anonymized. The directory composed of all the projects that have been carried out since the creation of the ANRS/MIE Cameroon site has been cleaned and enriched with information from the Publish or Perish software.

Results: The ANRS-Cameroon Site is a partner site of the National Agency for Research on AIDS and Viral Hepatitis, Emerging Infectious Diseases (ANRS|MIE) which is integrated into Cameroon's national health policy and system. It has human resources at 3 levels to carry out its activities. Its main mission is the scientific animation, evaluation, coordination and financing of research on HIV/AIDS, viral hepatitis, STIs, Tuberculosis and emerging infectious diseases. It has funded a total of 90 research projects with 240 publications since 2005. All areas of research were covered: social sciences (47%), virology (30%), fundamental research (15%) and prevention (2 %). The priority themes were HIV (79%), Hepatitis (10%), EIDs (8%) and HIV/TB co-infections (3%). The analysis of in-depth interviews conducted with seven key informants highlighted several shortcomings, namely: difficulties in obtaining authorizations, difficulties in obtaining funding, and the low practical skills of certain researchers**.** The research work was reported to the authorities, to participants, in international and national conferences, and in peer-reviewed journals. But also, feedback to patient associations and the organization of meetings bringing together practitioners, clinicians, and other researchers were strongly requested. According to those interviewed, it would be important to also carry out deliberations and a summary of what was found in order to issue concrete recommendations based on the results of the research on the question.

Conclusion: The ANRS/MIE Cameroon site has produced a lot of knowledge, on various themes and fields. However, we note that despite this significant production of information, it remains underused when developing public health policies at the national level. By way of explanation, we noted several defects from the phase of developing research projects to the phase of reporting the results of this research. To this could be added insufficient training of researchers at the national level and insufficient collaboration between researchers and decision-makers in the implementation of recommendations resulting from research.

Keywords: Bibliometrics, Research, ANRS/MIE Cameroon.

INTRODUCTION

Les systèmes de recherche nationaux sur la santé (SNRS), dont l'objectif premier est de produire des connaissances scientifiques de haute qualité et d'assurer leur utilisation en vue de promouvoir, restaurer et/ou maintenir la santé d'une population, se sont avérés inadéquats et à des degrés divers sur le continent africain[1]. Par ailleurs, de plus en plus des institutions de recherche font des analyses bibliométriques car les scientifiques sont désormais réputés performants à la seule condition que leurs travaux soient abondamment cités [2]. Les analyses bibliométriques deviennent donc une priorité, avec le nombre de maladies qui émergent de façon périodique.

Une étude en 2015 a été réalisée sur la productivité de la recherche sur le VIH dans les 27 pays de l'Union européenne (UE), ainsi que les facteurs de niveau structurel associés. Il ressort de cette productivité que la recherche sur le VIH varie sensiblement d'un pays de l'UE à l'autre, et cette variation est associée à des facteurs structurels reconnaissables(indicateurs sociodémographiques, de santé, de prévalence du VIH) [3].En Asie du Sud-Est en février 2022, une autre étude est réalisée pour déterminer les caractéristiques et les tendances de la recherche sur les hépatites virales. Elle a mis en évidence une corrélation entre la collaboration internationale, les dépenses de recherche, le produit intérieur brut, le nombre de chercheurs par million d'habitants et la productivité de la recherche sur les hépatites virales [4]. Afin d'apprécier la visibilité de la recherche française dans les domaines du VIH et des hépatites virales et en particulier la contribution de l'agence nationale de la recherche sur le SIDA et les Hépatites virales (ANRS) au positionnement mondial, une étude a été conduite en 2018 [5]. Elle a montré que la recherche française est toujours en tête de la compétition internationale et est le deuxième pays européen en nombre de publications scientifiques dans le domaine du VIH et le quatrième au niveau mondial pour la part des publications figurant dans le top 1%. Pour les hépatites virales, la France bénéficie d'une excellente reconnaissance internationale puisqu'elle occupe la première place mondiale du classement des pays pour les publications figurant dans les top 1% et top 10% mondiaux [5]. Les capacités de recherche limitées et la faible reconnaissance mondiale des chercheurs africains se traduisent par un faible taux de publications avec une contribution à moins de 0,5% au total des publications mondiales entre 2010 et 2014. Le continent africain regorge de jeunes professionnels désireux de dynamiser la recherche et la motivation en matière des résultats de recherche de qualité susceptible de créer un impact sur la société et les politiques constitue l'un des principaux moteurs [1]. Au Cameroun le site partenaire ANRS/MIE Cameroun a été créé en 2005, régi par un protocole d'accord entre le Ministère de la Recherche et de l'Innovation, du Ministère de la santé Publique

et de l'ANRS[6]. Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, il a participé à deux décennies de recherche ayant conduit à la production d'une importante quantité de travaux de recherche ayant amélioré les recommandations nationales et internationales.

Chapitre I :

PROBLEMATIQUE

I. JUSTIFICATION DU SUJET

Les maladies infectieuses émergeantes ou ré-émergeantes se manifestent de façon périodique, et une partie d'entre elles est la cause d'épidémies ou de pandémies pouvant décimer des populations. Elles constituent un problème majeur de santé publique d'où l'importance de mener cette étude afin d'améliorer l'accès aux connaissances disponibles et l'usage de celles-ci par les décideurs.

II. QUESTION DE RECHERCHE

Quel est l'influence de la recherche scientifique menée au sein du site ANRS/MIE Cameroun dans les politiques de Santé Publique nationale et internationale ?

III. HYPOTHESE DE RECHERCHE

Malgré la production importante des données scientifiques au Cameroun et une pertinence des sujets, le processus de valorisation des résultats inadéquat n'a pas permis que ses conclusions soient intégrées dans les décisions de santé publique.

IV. OBJECTIFS

- **Objectif général**

Mener une revue bibliométrique de la production scientifique du site ANRS/MIE Cameroun et rencontrer/échanger avec certains chercheurs et décideurs dont les projets de recherche ont été financés par l'ANRS.

- **Objectifs spécifiques**

1. Décrire le site ANRS/MIE Cameroun ;
2. Faire un état des lieux des travaux scientifiques du site ANRS/MIE Cameroun depuis 2005 ;
3. Décrire le processus de valorisation des résultats ;

V. LISTE DES VARIABLES

- **Description Site ANRS/MIE Cameroun** : Définition ; Circonstances de création ; Lieu ; Cadre ; Organisation générale ; Fonctionnement ; Expertise/formations ; Collaborations ; Activités
- **Productivité scientifique** : Investigateurs clés ; Pays collaborateurs ; Publications ; Virologie ; Recherche fondamentale ; Sciences sociales ; Études analytiques ; Essais cliniques ; Études évaluatives ;
- **Valorisation des résultats :** Restitutions aux autorités/ personnes vivant avec le VIH ; Publications dans les journaux à comité de lecture ; Conférences internationales ; Articles

scientifiques ; Travaux scientifiques ; Stratégies de lutte contre les maladies ; Nouveaux partenariats internationaux ; Formation des chercheurs

VI. DEFINITIONS OPERATIONNELLES

- **Revue :** Action d'examiner avec soin et de façon méthodique un ensemble d'éléments ;
- **Bibliométrie :** méthode d'analyse quantitative utilisant les publications scientifiques et différents indicateurs pour mesurer, évaluer la performance de la recherche et plus particulièrement, la production scientifique (la quantité de résultats scientifiques produits) et l'impact scientifique (l'influence des résultats scientifiques sur la progression de la science) ;
- **Production scientifique :** terme générique qui décrit ce qui est produit à l'issue d'un travail de recherche scientifique ;
- **Impact :** effet produit ;
- **Valorisation de la recherche :** ensemble des activités qui consiste à augmenter la valeur des résultats de la recherche et, plus généralement, de mettre en valeur les connaissances ;
- **Restitution des résultats de recherche :** rendre compte des résultats de la recherche à ceux qui l'ont accueillie ;
- **Processus décisionnel :** ensemble formé par la succession des étapes à franchir pour arriver à une décision.

VII. CADRE THEORIQUE

En promotion de santé, l'élaboration des politiques publiques saines inscrit la santé à l'ordre du jour des responsables politiques. Ainsi donc, la prise de décision fondée sur des données probantes en santé publique se fait sur la base de données pertinentes et disponibles issues de la recherche.

VIII. INTERET DE LA RECHERCHE

L'intérêt de ce travail réside non seulement dans l'évaluation de la recherche en termes de publications scientifiques, mais aussi et surtout, contribue au processus décisionnel pour l'amélioration des conditions de vie des populations.

Chapitre II :

REVUE DE LA LITTERATURE

I. BIBLIOMETRIE ET RECHERCHE DOCUMENTAIRE

1. Bibliométrie

Historiquement, la bibliométrie est issue des études de bibliographies initiées à la fin du XIXe siècle. Le premier nom qu'elle a reçu, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bibliométrie, a été la Bibliographie statistique, qui a été appliquée pour la première fois en 1923,en fonction de la nécessité de recenser les publications existantes qui commençaient à être inabordables pour chercheurs en raison du volume important qu'ils atteignaient[7]. Elle est constituée de diverses méthodes mathématiques et statistiques qui permettent d'effectuer des analyses quantitatives des sciences et de mesurer, également, les dimensions sociologiques associées à la diffusion de recherches sous forme de publications. L'analyse bibliométrique est utilisable selon trois échelles différentes : (i) au niveau micro elle s'applique aux individus ; (ii) au niveau méso, elle sert à décrire la production scientifique des institutions et groupes de recherche ; (iii) et au niveau macro, elle vise à mesurer la production nationale par pays, province, ou même par ville. Pour ce faire, elle utilise plusieurs indicateurs bibliométriques à savoir : nombre de documents, nombre de citations, H-index, facteur d'impact, taux de citation…Ces indicateurs sont calculés à partir d'une base de données bibliométriques. Le nombre de publications et de citations constituent les indicateurs les plus utilisés car ils mesurent le volume et l'impact de la recherche à divers niveaux d'agrégation et ils permettent d'identifier des tendances[8].

Les analyses bibliométriques ont différents buts qui sont : (i) Évaluation de la recherche : lorsqu'elle est utilisée par les organismes finançant la recherche comme outil d'évaluation et aide à la décision des politiques de recherche ; (ii) Gouvernance de l'enseignement supérieur : lorsqu'elle est utilisée par les universités ou les gouvernements pour déterminer leurs forces et faiblesses dans le domaine de la recherche et orienter leurs actions ;(iii) Classements d'universités, basés sur un ou plusieurs indicateurs. Il s'agit de l'application la plus visible de la bibliométrie ; (iv) Sociologie des sciences : lorsqu'elle est utilisée par les sociologues des sciences pour étudier l'activité des scientifiques, l'apparition et l'autonomisation de disciplines, ou encore les liens que différentes disciplines tissent entre elles ;(v) Évaluation individuelle des chercheurs : cet usage reste très controversé compte tenu de l'imperfection des indicateurs et des enjeux d'un tel exercice. L'Académie des Sciences française a émis un certain nombre de recommandations à cet effet, parmi lesquelles : (vi) L'évaluation doit porter sur les articles et non sur les revues ; (vii) La bibliométrie ne peut pas se résumer à des nombres, mais doit être accompagnée d'un examen approfondi des données bibliométriques et bibliographiques, et si

possible des articles eux-mêmes ; (viii) Lorsque cela est possible, tenir compte de la place et de la contribution de l'auteur dans l'article considéré ; (ix) L'évaluation bibliométrique doit avoir pour objectif prioritaire d'améliorer la valeur de la recherche[9].

2. Recherche documentaire

La qualité d'une publication médicale repose autant sur le document de recherche que sur la recherche bibliographique préalable à l'écriture en vue d'une publication. L'art de la recherche documentaire et son importance pour les différentes étapes de la rédaction scientifique ont été soulignés[10]. La recherche documentaire est l'ensemble de techniques et modalités permettant de sélectionner l'information dans un fonds documentaire structuré en fonction de critères de recherches propres au chercheur. Elle participe au besoin fondamental de recherche. La recherche de l'information est la mise en œuvre d'un processus intellectuel qui amènera à trouver les documents et les références appropriés pour répondre à la question posée, pour démarrer et pour bien poursuivre l'étude. En dehors de la quête de connaissances, elle a pour objectif de contribuer à la résolution de problèmes par la synthèse des informations à travers une analyse profonde de la documentation et une interprétation des documents en rapport avec une question donnée[9]. Dans un contexte de surabondance d'informations et de diversité de ses supports, les processus de recherche documentaire et de validation de l'information requièrent la mise en application d'une méthodologie efficace. Il existe différentes méthodes permettant de définir une bonne stratégie de recherche documentaire[11].

Savoir se documenter, c'est savoir où et comment trouver l'information, savoir poser les bonnes questions, savoir de quelle information on a besoin, savoir la lire, la comprendre, la critiquer, évaluer si elle répond à ses besoins, savoir la gérer et l'utiliser pour sa propre formation. Rédigé sur un ton clair et didactique, sans être simplificateur.

3. Recherche en Afrique

Les États-Unis dans leur rapport mondial de 2016, ont mentionné que la recherche se poursuit dans quelques pays africains. Certaines institutions dominent, par exemple en Afrique du Sud, l'Université du Cap, l'Université de Stellenbosch, l'Université de KwaZulu Natal, l'Université de Pretoria et l'Université de Witwatersrand représentent l'essentiel des activités de recherche[1]. Au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, la plupart des activités de recherche ont lieu dans moins de trois institutions de chacun de ces pays. La capacité de recherche nationale et institutionnelle est donc largement limitée. L'analyse du type de recherche menée a montré que la recherche opérationnelle compte beaucoup plus que la recherche fondamentale et que la recherche fondamentale est principalement axée sur les trois principales maladies infectieuses,

notamment le VIH, la tuberculose et le paludisme, avec peu de travaux sur les maladies tropicales négligées et les maladies non contagieuses[1]. Cette préférence accordée aux domaines de recherche et aux maladies ciblées compromet la capacité des pays africains à faire face au fardeau des maladies tropicales négligées et au nouveau défi des maladies non transmissibles comme le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. En outre, un nombre limité d'États membres investissent le pourcentage requis de leur PIB dans la recherche en matière de santé[1].

4. Valorisation de la recherche

Au-delà d'accroître les connaissances, il est nécessaire de partager la culture scientifique que cela soit : (i)au sein de la communauté, via les publications scientifiques, colloques, autres publications ; (ii) auprès de populations du domaine, dont les étudiants, via notamment l'organisation de formations résultantes, (iii) auprès du grand public. Il permet un progrès plus rapide de la recherche et de la connaissance scientifique (débats, nouvelles réflexions, nouvelles recherches, etc.) via une circulation rapide des résultats au sein de la communauté. Valoriser les résultats de la recherche au service de la société : (i) développement de l'innovation, (ii) contrats de recherche avec des entreprises ; (iii) concours scientifiques de chercheurs auprès d'entreprises ; (iv) expertise et appui aux associations, fondations reconnues d'utilité publique et aux politiques publiques. La stratégie de « diffusion » impacte l'ensemble des processus de ce domaine.

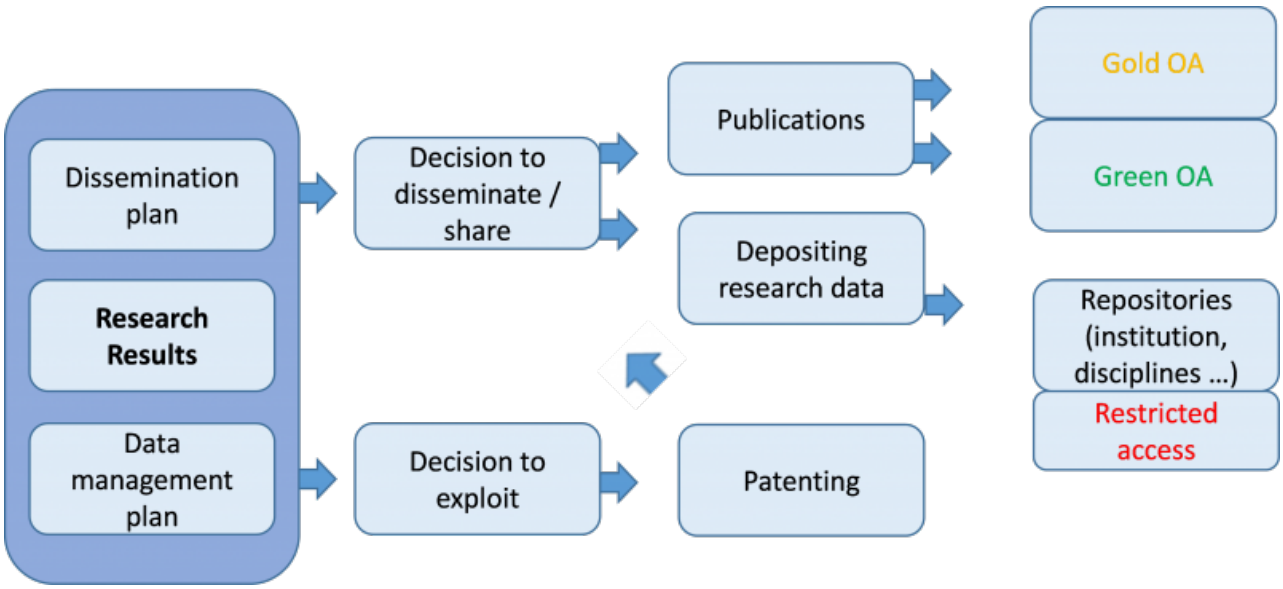


Figure 1 : Valoriser et diffuser les résultats de la recherche [10].

Les typologies de production scientifique sont variées et reflètent la diversité des activités de recherche. Bien que centrées autour de la production et de la diffusion de nouvelles

connaissances, elles prennent en compte aussi des activités d'expertise, de formation, de contribution à la culture scientifique.

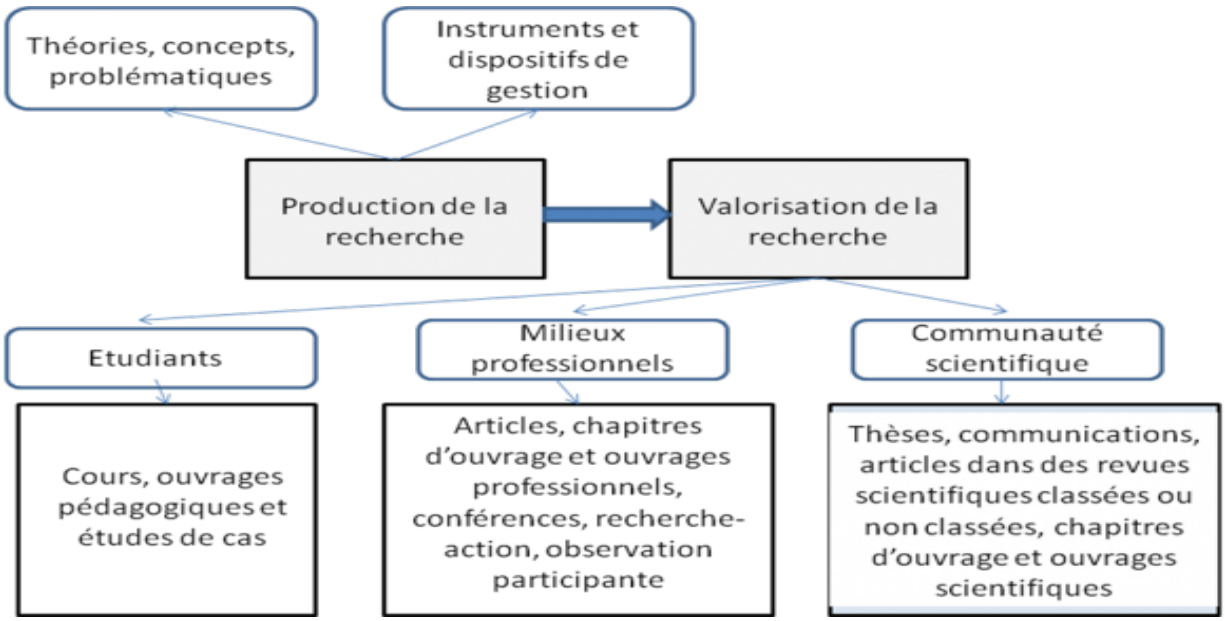


Figure 2 : Typologie de production scientifique [10].

Prendre une décision en se basant sur des données probantes exige d'intégrer à sa pratique quatre éléments clés : les données internes, les données scientifiques, l'expertise en gestion et les parties prenantes.



Figure 3 : Prise de décision basée sur les preuves [10].

II. MALADIES ÉMERGENTES ET RÉ-ÉMERGENTES :

1. Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

a. Épidémiologie

Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour le sida (ONUSIDA), le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans le monde en 2020 était estimé à 37,7 millions de personnes, faisant de cette pandémie un problème majeur de santé publique dans le monde. L'Afrique subsaharienne abrite 25,6 millions de personnes vivants avec le VIH et reste la région la plus touchée dans le monde. Au Cameroun sa prévalence était estimée en 2020 à 2,7% dans la population générale [12].

b. Lutte contre VIH au Cameroun

Elle a démarré au Cameroun en 1986 avec la création du Programme National de Lutte contre le sida (PNLS) et du Comité National de Lutte contre le sida (CNLS) en 1998, placés sous tutelle du Ministre de la Santé Publique (MINSANTE). Le CNLS a élaboré et mis en œuvre dès l'an 2000, des Plans Stratégiques Nationaux (PSN), afin de renforcer la riposte à l'épidémie[2].

Politiques de lutte contre le sida au Cameroun

Elles décrivent ici le processus de prise de décision en matière de lutte contre le sida au Cameroun, en termes de définition des objectifs et des domaines prioritaires de lutte dans les PSN mis en œuvre par le CNLS[2].

Plan Stratégique National 2000-2005

Il a été lancé le 12 Septembre 2000 par le Premier Ministre Chef du Gouvernement en poste. Il représentait une ouverture réelle aux autres partenaires du CNLS, notamment aux ministères autres que celui de la santé, au secteur privé et aux ONG. Il a été élaboré pour servir de guide à l'élaboration des plans sectoriels de tous les secteurs impliqués, par la prise en compte de domaines prioritaires identifiés pour les années 2000 à 2005[2].

Plan Stratégique National 2006-2010

Il avait pour cadre de référence : (i) La 3ème enquête démographique et de santé du Cameroun (EDS-III) conduite en 2004, donnant une vue d'ensemble de l'épidémie du sida au terme du PSN 2000-2005 ; (ii) L'analyse des rapports d'activités du PNLS et l'état situationnel de la lutte contre l'infection à VIH et le sida au terme du PSN 2000-2005, présentant ce qui a été fait, les progrès réalisés, les facteurs favorisant ou limitant, et ce qui restait à faire (éventuellement, une réorientation de la réponse nationale à l'épidémie)[2].

Plan Stratégique National 2011-2015

Il s'est fait sur la base des plans précédents et des orientations et engagements internationaux et sous régionaux auxquels le Cameroun a souscrit. Il a été noté comme principale avancée, une

amélioration de la multisectorialité avec l'implication active de tous les acteurs de la lutte au cours des différentes étapes du processus d'élaboration.

Plan Stratégique National 2014-2017

Il avait pour principal objectif de faire le point sur les avancées du PSN 2011-2015, de dégager les principaux obstacles à l'atteinte des objectifs fixés et de proposer des solutions de réajustement. Il repose donc essentiellement sur une analyse des résultats du plan précédent. Ce plan met l'accent sur le rôle joué par la prise en charge et notamment le traitement, sur la prévention de nouvelles infections[2].

Plan Stratégique National 2018-2022

Ce plan trouve son ancrage dans la Stratégie Sectorielle de la Santé (SSS) 2016-2027 et est orienté vers la consolidation des acquis, la vision globale pour la fin de l'épidémie du VIH à l'horizon 2030 et la contribution à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). Il a été élaboré sur la base des leçons apprises de la mise en œuvre du précédent plan, des orientations et engagements internationaux, sous régionaux auxquels le Cameroun a souscrit[13].

Plan Stratégique National 2024-2030

Pour les trois prochaines années, le PSN 2024-2030, envisage de réduire l'incidence du VIH, la morbidité et la mortalité liées au VIH et d'atténuer le fardeau socio-économique de la maladie sur le développement du pays. La mise en œuvre de ce plan nécessite l'implication de tous les acteurs de la société camerounaise (secteurs public et privé, société civile, confessions religieuses et les communautés à la base).

Les principales recommandations des recherches menées entre 2006 et 2010, et portant sur le VIH et le sida au Cameroun ont été comparées avec les prises de décision de la période 2011-2015.

Tableau I : Recherche et prise de décision entre 2011 et 2015[9].

Domaines de recherche	Principales recommandations
Groupes cibles	-Mener des études comportementales et des études sérologiques -Identifier et lutter contre les nouvelles portes de transmission
Jeunes	-Développer un programme national de lutte contre l'exploitation commerciale des filles mineures -Identifier et comprendre les facteurs prédictifs de l'abstinence et la réduction du nombre de partenaires
Prevention	-Promouvoir la circoncision masculine -Éducation, sensibilisation et counseling -Promouvoir le conseil et dépistage du VIH -Renforcer l'accès au traitement et aux soins du VIH -Lutter contre les facteurs pouvant favoriser l'infection à VIH (abus d'alcool, IST)
Recherche fondamentale	-Surveiller les formes émergentes recombinantes pour le développement de vaccins contre le VIH -Étudier les possibles transferts de zoonoses additionnelles en provenance d'autres primates -Surveiller les groupes rares de VIH-1
Traitement et Prise en charge	-Gérer et réduire les effets secondaires liés aux ARV et impliquer les spécialistes concernés -Étudier et surveiller les résistances de certaines souches du VIH aux IN -Introduire une stratégie HAART de deuxième ligne -Surveiller et promouvoir l'adhérence et la compliance au traitement -Mettre en œuvre des stratégies pour une meilleure initiation de la PEC et du suivi des patients -Promouvoir les stratégies visant un meilleur accès et une plus grande utilisation des services de PEC -Prendre en compte les droits des PVVIH dans la prise en charge
Coordination de la lutte	-Mettre en place une approche globale et intégrée combinant structures, communautés et individus -Redéfinir les rôles et renforcer les procédures de délégation des tâches -Promouvoir l'implication des secteurs apparentés -Former les décideurs aux processus d'élaboration des politiques

Plusieurs de ces recommandations ont été prises en compte dans l'élaboration de stratégies. Notamment celles qui visaient la promotion de la recherche avec l'identification de thèmes précis parmi lesquels la conduite d'études comportementales et d'études sérologiques, et l'identification et la compréhension des facteurs prédictifs de l'abstinence. Une autre recommandation prise en compte a été l'utilisation de la recherche pour informer la conception des interventions. Les stratégies élaborées au cours de cette période prévoyaient également tel que recommandé par la recherche, le développement d'un programme national de lutte contre l'exploitation commerciale des filles mineures, la promotion de l'accessibilité au ténofovir et aux traitements contre les infections à VHB et à VHC, et l'introduction d'une stratégie HAART de deuxième ligne[9].

Malgré la place importante qu'occupe la promotion de la recherche, aussi la mise à disposition d'une information stratégique devant orienter la prise de décision, ses objectifs visent la production de données épidémiologiques fiables, ainsi que la promotion et l'application des résultats de la recherche dans la lutte contre le VIH et le Sida.

2. Hépatites virales

a. Épidémiologie

En 2019 seulement, on estime que 78 000 décès sont survenus dans le monde en raison de complications d'infections aiguës par les virus des hépatites A à E. Les efforts mondiaux donnent la priorité à l'élimination des hépatites B, C et D. Ces 3 infections provoquent une hépatite chronique qui dure plusieurs décennies et se solde par plus d'un million de décès par an dus à la cirrhose ou au cancer du foie. Elles sont responsables de plus de 95 % des décès par hépatite. Le Cameroun est un pays à forte endémicité, avec une distribution aussi importante en zone rurale (13,3%) qu´en zone urbaine (10,7%)[14].

b. Lutte contre les hépatites virales

Depuis 2011, l'Organisation Mondiale de la Santé organise le 28 juillet de chaque année des campagnes journalières mondiales contre les hépatites. En 2016, 194 pays ont adopté la première Stratégie mondiale du secteur de la santé contre l'hépatite virale, 2016-2021. Celle-ci couvre les six premières années du plan d'action pour la santé de l'après-2015, qui ambitionne d'éliminer l'hépatite virale en tant que problème de santé publique d'ici à 2030[15]. Pour mener à bien ce programme, il convient d'agir dans cinq domaines ou « orientations stratégiques ». À chaque orientation stratégique correspond un ensemble de mesures particulières que les pays, l'OMS et les partenaires devraient mettre en œuvre. Les mesures proposées sont destinées à orienter l'action des pays, qui choisiront et appliqueront les mesures les mieux adaptées à leurs

épidémies, à leurs priorités nationales et au contexte qui leur est propre, en tenant compte des politiques nationales[16]. Chaque orientation stratégique répond à un ensemble particulier de questions : (i)Quel est l'état des lieux ? (ii)Quels services fournir ?; (iii)Comment dispenser ces services ?; (iv)Comment financer les coûts associés de la fourniture de cet ensemble de service ?; (v)Comment modifier la trajectoire de la riposte ?

3. Maladies infectieuses émergentes

Depuis 2009, nous avons assisté à trois épidémies majeures. L'une d'entre elles due au virus Ébola en Afrique de l'Ouest, Chikungunya et Zika en Amérique centrale et du Sud, et aux Caraïbes ; et deux autres, l'une due au virus de la grippe H1N1 et l'autre à un coronavirus, le severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), responsable de la COVID-19 (coronavirus disease 2019)[17].

a. La maladie à virus Ébola (MVE) :

Le taux moyen de létalité des cas de maladie à virus Ébola est d'environ 50 %[18]. En date du 16 décembre 2021 ,la RDC a annoncé la fin de la 13e épidémie de MVE déclarée le 8 octobre 2021 dans la province de Nord-Kivu, soit une létalité de 82 % [19].

b. Arboviroses : Dengue, Chikungunya, Zika

Chikungunya : La maladie sévit en Afrique et en Asie, bien que des cas importés aient été enregistrés dans la Région européenne de l'OMS et la Région des Amériques. Plus de 2 millions de cas ont été signalés depuis 2005[20].

Dengue : Environ 100 à 400 millions d'infections ont lieu chaque année. Le nombre de cas de dengue notifiés à l'OMS a été multiplié par plus de huit au cours des deux dernières décennies, passant de 505 430 cas en 2000 à plus de 2,4 millions de cas en 2010 et 5,2 millions de cas en 2019. Le nombre de décès signalés entre 2000 et 2015 est passé de 960 à 4032, les tranches d'âge jeunes étant généralement les plus touchées[21].

Zika : À ce jour, 86 pays et territoires au total ont signalé des preuves d'infection à Zika transmise par les moustiques. En Afrique, ceux avec des preuves de transmission avant l'épidémie de 2015 comprennent le Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Gabon, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, et Ouganda. Néanmoins, les informations sur l'incidence et les tendances de transmission du Zika dans la Région africaine restent limitées[22].

c. La maladie à Coronavirus (COVID19)

Depuis fin 2019, une épidémie en cours d'un nouveau type de pneumonie inexpliquée causée par un nouveau coronavirus, le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère

(SRAS-CoV-2), a été identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine. Jusqu'en août 2020, plus de 25 millions de cas d'infection par le SRAS-CoV-2 avaient été confirmés dans le monde, causant plus de 800 000 décès. Cette maladie a été désignée par l'Organisation mondiale de la santé sous le nom de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)[23]. Le 30 janvier 2020, la maladie est déclarée urgence de Santé Publique de Portée Internationale (USPPI). Le Cameroun confirme 02 cas positifs de Covid-19 le 06 mars 2020, entrainant l'activation du Système de Gestion des Incidents[24]. A la date du 12 juillet 2021, il a été rapporté un total de 4,359,925 cas de Covid-19 dont 102,687décès, soit une létalité de 2,36%[25]. Au 4 juillet 2022, un total de 546 114 042 cas de COVID-19 et 6 335 599 décès (ratio de létalité [TDL] : 1,2%) ont été signalés à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) par 232 pays et territoires. [26].

Au cours de ces évènements, le constat a été le même : faiblesse dans la capacité de détection précoce, absence de moyens thérapeutiques disponibles, difficulté à développer et mettre en place des mesures préventives, tout cela traduisant un manque d'anticipation et de préparation. Nous sommes là dans l'un des rôles majeurs de la communauté scientifique : celui de prévenir et d'anticiper l'arrivée de nouvelles épidémies ou pandémies, pour en limiter l'impact sanitaire, économique et social. Il s'agit de se projeter au-delà de la réponse apportée à la crise lorsque celle-ci survient, qui allie surveillance, compréhension et recherche scientifique, préparation, et mobilisation coordonnée du monde académique et des décideurs publics[17].

d. Variole Simienne

Après 1970, des cas de variole simienne ont émergé de manière sporadique en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, ainsi qu'en Afrique de l'Ouest. En 2003, une flambée s'est déclenchée aux États-Unis, en lien avec des animaux sauvages importés. Depuis 2005, on signale chaque année des milliers de cas présumés en République démocratique du Congo. En 2017, la variole simienne est réapparue au Nigeria et continue de se propager parmi les habitants du pays et de contaminer des voyageurs vers d'autres destinations. En mai 2022, une flambée de variole simienne s'est déclenchée soudainement et s'est rapidement propagée en Europe, dans les Amériques, ainsi que dans les six Régions de l'OMS : on a recensé dans 110 pays quelque 87 000 cas et 112 décès. La flambée mondiale a touché en premier lieu (mais pas uniquement) les personnes homosexuelles et bisexuelles, notamment les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, et s'est propagée entre les individus par le biais de réseaux sexuels. La flambée mondiale de variole simienne est considérée comme une urgence de santé publique de portée internationale depuis le 23 juillet 2022. L'OMS a publié un plan stratégique de préparation et de riposte à la variole simienne, ainsi qu'un ensemble de directives. La

surveillance, les diagnostics, la communication sur les risques et la participation communautaire sont autant d'éléments essentiels pour stopper la flambée et éliminer la transmission entre humains de la variole simienne dans tous les contextes [27].

e. Maladie à virus Marburg

Le virus Marburg et le virus Ravn, proche parent du virus Marburg, sont les agents responsables de cette maladie, dont le taux de létalité peut atteindre 88 %. La maladie à virus Marburg a été détectée pour la première fois en 1967, à la suite de flambées survenues simultanément à Marburg et Francfort (Allemagne) et à Belgrade (Serbie). On considère que Rousettus aegypticus, une roussette, est l'hôte naturel du virus Marburg, qu'elle transmet à l'être humain. C'est la première fois que la Guinée équatoriale signale une flambée de maladie à virus Marburg. La dernière flambée de maladie à virus Marburg était survenue au Ghana en 2022 (avec trois cas confirmés). Auparavant, d'autres flambées épidémiques de la maladie avaient été signalées en Guinée (2021), en Ouganda (2017, 2014, 2012, 2007), en Angola (2004-2005), en République démocratique du Congo (1998 et 2000), au Kenya (1990, 1987, 1980) et en Afrique du Sud (1975) [28].

Depuis le 25 février 2023, date de publication du premier bulletin d'information relatif à cette flambée épidémique, la Guinée équatoriale a notifié huit cas supplémentaires confirmés en laboratoire de maladie à virus Marburg, ce qui porte à neuf le nombre total de cas confirmés en laboratoire et à 20 le nombre de cas probables depuis que l'épidémie a été déclarée en février 2023. On compte sept décès parmi les cas confirmés en laboratoire, et tous les cas probables sont décédés .

III. VALORISATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

La quantité d'études bibliométriques dans divers domaines a augmenté de façon significative.

Une revue systématique réalisée en 2019 avait pour but de créer un inventaire analytique des résultats de la recherche mondiale sur la stigmatisation et la discrimination liées au sida. SciVerse Scopus a été utilisé pendant la période d'étude de 1980 à 2017 pour récupérer la littérature sur la stigmatisation et la discrimination liées au sida. Les résultats ont été présentés sous forme de tableaux bibliométriques et de cartes. Au total, 2509 documents ont été récupérés. Environ 40 % (n = 990) des documents récupérés ont été publiés au cours des 5 dernières années (2013-2017). Les documents récupérés ont reçu une moyenne de 19,8 citations par article et avaient une moyenne de 3,2 auteurs par article. L'indice Hirsh des documents récupérés était de 94. Les sujets les plus fréquemment rencontrés étaient la santé mentale, l'observance, les adolescents, les femmes, la divulgation et l'Afrique. Les États-Unis ont contribué à 1 226 (48,9

%) documents tandis que la région Afrique a contribué à 531 (21,2 %) documents. La collaboration en matière de recherche entre la plupart des pays actifs était relativement faible. Les auteurs et les institutions des États-Unis ont dominé ce domaine. AIDS Care a été la revue la plus active dans la publication de documents dans ce domaine avec 307 (13,4%) documents tandis que les documents publiés dans la revue Social Medicine ont reçu les citations les plus élevées. La recherche sur la stigmatisation et la discrimination liées au sida a connu une augmentation notable au cours de la dernière décennie, mais le nombre total de publications était considéré comme insignifiant par rapport à l'ampleur du problème et au nombre mondial de personnes infectées. Il y avait une sous-représentation relative de la littérature de la région africaine malgré le fait que plus des deux tiers des personnes infectées par le VIH dans le monde vivent en Afrique[29].

Une analyse bibliométrique rétrospective complète a été réalisée sur la littérature sur le VIH/SIDA en Ouganda publiée de 1982 à 2020 et a été récupérée à l'aide de Publish or Perish de Harzing. Au total, 446 publications ont été sélectionnées et utilisées. Les résultats ont indiqué que le taux de croissance relatif (RGR) avait augmenté de 0,29 (1996) à 3,40 (2020) avec quelques fluctuations entre les années, avec une tendance à la baisse de 2,39 (1996) à 0,20 (2020) avec de légères fluctuations entre les années. La majorité des publications (60,3 %) ont été écrites par un seul auteur, le reste (15,2 %) étant écrit en collaboration par deux auteurs. Plus de la moitié (59,64 %) des publications ont été citées au moins une fois. En Ouganda, la recherche sur le VIH/SIDA est principalement publiée par des éditeurs de revues internationales plutôt que par des éditeurs de revues africaines. Les revues de titres liés à la médecine ont le plus d'articles publiés sur la recherche sur le VIH/SIDA en Ouganda, tandis que les revues liées au genre en ont le moins. Selon les résultats, en Ouganda, les chercheurs sur le VIH/SIDA collaboraient généralement mal et les chercheurs avaient tendance à publier davantage avec Francis et Taylor, Springer, Elsevier et Wiley qu'avec d'autres éditeurs. Cependant, il y a eu une croissance relative de la recherche sur le VIH/sida au fil du temps[30].

En 2021, un travail de recherche avait pour objectif d'étudier la production scientifique réalisée au sein de la Caraïbe afin de se projeter sur des perspectives de coopération favorisant la recherche sur des problématiques de Santé publique propres aux pays caribéens. Ces travaux ont nécessité la réalisation d'études bibliométriques permettant de décrire les thématiques de recherche principales des pays d'intérêt ainsi que leurs collaborations internationales existantes. A l'exemple de celle effectuée sur la production scientifique de la République dominicaine, de la Guadeloupe et de la Martinique et ayant fait l'objet d'une publication qui a évoqué des

perspectives de collaboration dans le domaine des maladies infectieuses et plus spécifiquement sur les arboviroses. La publication a donc porté sur les arboviroses à l'échelle de tous les pays caribéens permettant une analyse des pays les plus productifs et des pays les plus réactifs face aux arboviroses émergentes (Zika et Chikungunya). Les perspectives restent nombreuses afin de poursuivre ce travail avec le développement d'outils bibliométriques sur d'autres thématiques de recherche très impactantes sur les pays Caribéens[31]. Au cours de la même année, une analyse bibliométrique a été menée pour construire une vue globale de l'état de la recherche sur le virus de l'hépatite A (VHA) afin d'aider les chercheurs, les professionnels de la santé et les décideurs à comprendre les caractéristiques des résultats de la recherche dans ce domaine particulier. De 1985 à 2019, un total de 5 950 études sur le VHA a été publiées, avec un indice h global de 105 et 90 350 citations au total. L'article le plus cité sur le VHA était "Classification of chronic viral hepatitis: a need for reassessment" rédigé par Scheuer dans le Journal of Hepatology avec un total de 1 121 citations. L'article le plus cité sur le vaccin contre le VHA était « Un essai contrôlé d'un vaccin contre l'hépatite A inactivé au formol chez des enfants en bonne santé » par Werzberger et al. dans le New England Journal of Medicine avec 401 citations. L'année de publication la plus fréquente était 2019 (n = 250). Le plus grand nombre d'études ont été financées par le Département américain des services sociaux de la santé (n = 199). L'organisation avec le plus grand nombre de publications était les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (n = 228). Les États-Unis d'Amérique (n = 1 500) étaient le pays avec le plus de publications. 'Vaccine' était la revue leader avec 299 publications. En conclusion, il a été démontré que le plus grand nombre d'études a été publié dans les pays développés et qu'il existe un besoin évident d'approches de recherche interdisciplinaires pour évaluer et intervenir dans les zones d'endémie du VHA. La présente étude bibliométrique a montré une plus grande production de recherche dans les pays à revenu élevé. Une tendance limitée à la collaboration avec les pays en développement manifestée par les pays technologiquement avancés et développés et une faible productivité dans les pays en développement dans la recherche sur le VHA étaient le reflet de l'état des lieux dans d'autres domaines de recherche[32].

En 2020, une étude bibliométrique faite en Chine visait à discuter de l'épidémiologie, du diagnostic, des vaccins disponibles contre le VHE et donne un aperçu des 100 études les plus citées sur le VHE. La recherche a mis en évidence un total de 3 235 publications, citées 95 858 fois avec un h-index de 129. La principale conclusion pour les 100 articles les plus cités sur le VHE a montré : nombre d'auteurs allant de 1 à 23, références citées allant de 4 à 304, le score

de citations par an varie de 6,61 à 175, et le score global de citations varie de 148 à 791. Sur les 100 études les plus citées, les auteurs qui ont publié le plus d'articles sont Purcell (n = 18), Meng (n = 17) et Emerson (n = 15). La plupart La plus grande part des articles sur le VHE a été fournie par les États-Unis d'Amérique (n = 49) avec 12 795 citations. L'Institut national des allergies et des maladies infectieuses était le principal institut avec le plus grand nombre de publications (n = 16), cité 3 950 fois. Les études menées sur le VHE se sont multipliées au fil du temps. Les informations présentées seraient très utiles dans la prise de décision pour les décideurs politiques fournissant des soins de santé et pour les universitaires en fournissant un point de référence pour les recherches futures. Des recherches de qualité pourraient être menées dans des pays à revenu faible ou intermédiaire au niveau local, mais elles ne sont jamais publiées dans des revues internationales faute de fonds et ne sont pas diffusées à un public plus large. Cette étude a fourni non seulement un point de référence pour des recherches potentielles, mais a aidé également à la planification et à l'élaboration de politiques concernant la prévention et le contrôle du VHE. [33]. Très peu d'études bibliométriques sur les publications en sciences médicales ont été réalisées en Afrique.

Au Sénégal une étude réalisée en 2018, visait à présenter un panorama de la production scientifique sénégalaise sur les Maladies non transmissibles (MNT) de 1960 à 2018. Via une approche bibliométrique, les indicateurs recherchés étaient la production annuelle depuis les indépendances (1960), l'indice de collaboration nationale et internationale mesurée à partir des co-publications institutionnelles, et l'indicateur d'impact scientifique obtenu à partir du nombre de citations et du H-Index des revues. Aussi, la proportion des publications en libre accès a été évaluée et analysée comparativement à celle en accès payant sous l'angle de l'impact scientifique. Les résultats obtenus montraient que sur la période indiquée, la production sénégalaise sur les MNT était très faible avec seulement 808 publications parues dans 305 revues. Deux raisons essentielles à savoir, l'insuffisance de financement et la jeunesse des programmes de formation dans le domaine justifiaient cet état des faits. Toutefois, au cours de ces dix dernières années avec une nette progression d'environ 60 publications annuelles contre moins de 20 avant, le Sénégal demeure le leader scientifique dans le domaine des MNT en Afrique de l'Ouest francophone. En outre, au niveau de la collaboration, l'étude a fait ressortir qu'elle est plus orientée internationale que nationale. Pour la collaboration nationale, elle était plus forte entre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et les CHU de la capitale. La collaboration internationale était quant à elle pour des raisons historiques dominée par la France. Par ailleurs, la production sénégalaise était d'une insignifiante influence scientifique

avec 5957 citations, soit un ratio d'environ 8 citations par articles. L'explication tenait à l'index-h relativement faible des revues dans lesquelles les chercheurs sénégalais ont publié. Enfin, la proportion de publications dans des revues en libre accès pour ces dix dernières années était très faible avec seulement environ 10% des articles (soit 34/353)[34].

En 2017, une étude a été menée avec pour objectif de faire une analyse de la production, du transfert et de l'utilisation des connaissances issues de la recherche dans la prise de décision et le changement de paradigmes décisionnels en matière de lutte contre le sida au Cameroun. Cette évaluation à l'échelle macro de la recherche a été réalisée en utilisant des outils bibliométriques. Globalement, il en est ressorti que la recherche sur le sida au Cameroun présentait une forte production, en termes de nombre de publications dans des revues scientifiques et des domaines de recherche abordés. Tous les domaines prioritaires de la lutte contre le sida étaient abordés, et la recherche fondamentale occupait la part la plus importante, visant à mieux comprendre l'épidémiologie et à mettre en place de nouvelles stratégies (prévention, diagnostic, traitement et vaccins). L'analyse de l'impact de la recherche sur la prise de décision en matière de lutte contre le sida a révélé que la prise en compte des connaissances issues de la recherche avait évolué au fil du temps, mais que beaucoup de résultats restaient non exploités. En justification, les données disponibles n'étaient pas suffisamment synthétisées, ce qui pouvait limiter l'accès aux connaissances par les décideurs. De même, on observait très peu d'études d'interventions, limitant de ce fait le niveau de preuve des connaissances produites. Ces résultats ont été confortés par les responsables impliqués dans la prise de décision, qui ont déclaré qu'ils faisaient plus appel aux recherches auxquelles ils étaient associés, et aux études visant à résoudre des problèmes prioritaires[9].

L'analyse des données bibliométriques était une approche puissante pour révéler les efforts de recherche visant à éclairer les politiques et les pratiques ainsi que pour soutenir les décisions visant à renforcer les capacités de recherche, en particulier dans les États à revenu faible et intermédiaire[30], à l'instar du Cameroun. L'utilisation des connaissances issues de la recherche, dans les pratiques professionnelles et la prise de décisions, est un enjeu majeur de santé publique mais il existe des obstacles à cette utilisation.[35].

Chapitre III :

METHODOLOGIE

I. TYPE D'ÉTUDE

Il s'agissait de mener une étude mixte : analyse bibliométrique et analyse qualitative.

II. SITE

Elle s'est déroulée au sein du site ARNS/MIE Cameroun.

III. POPULATION D'ETUDE

1. Population source :

La population était constituée de publications scientifiques du site ANRS/MIE Cameroun, de décideurs institutionnels et de chercheurs Camerounais ayant bénéficié d'un financement de l'ANRS/MIE Cameroun.

2. Critères d'inclusion :

- Toute personne pouvant intervenir dans la prise de décision dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes.
- Toutes les publications parues depuis l'an 2005 et dont le site d'étude était l'ANRS/MIE Cameroun
- Tout chercheur ayant eu un projet de recherche financé par le site ANRS/MIE Cameroun

3. Critères d'exclusion :

- Tout participant ayant décidé de se retirer de l'étude

4. Échantillonnage :

Aléatoire, tirage au sort pour les chercheurs et les décideurs entre 2005 et maintenant. Exhaustif pour la revue des projets de 2005 à maintenant.

IV. OUTILS DE COLLECTE

- **Guide d'entretien :** Une grille d'entretien pour les chercheurs composé de 7 questions ouvertes ; Une grille d'entretien pour les décideurs composés de 9 questions ouvertes. Il a été conçu dans le cadre de l'étude, pré-testé et validé. Ce guide comportait les différents points à aborder, répartis en deux principales sections, à savoir : une partie regroupant des questions à l'attention des décideurs et une autre à l'attention des chercheurs.
- **Base de données des projets menés au Site entre 2005 et maintenant :** Le site ANRS MIE Cameroun, possède un répertoire de tous les projets qui ont été menés depuis sa création. Ce répertoire se compose des titres du projet, des noms des principaux investigateurs (PI) de l'année et du numéro attribué par l'ANRS (ANRS XXX). Les projets allant de 2005 à maintenant ont été sélectionnées, copiés dans une feuille Excel et ont servi pour constituer notre base de données. Celle-ci fut complété par les données générées par le logiciel Publish or Perish.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

V. PROCEDURE DE COLLECTE

- Entretien face à face pour les chercheurs et décideurs : Les chercheurs et les décideurs ont été contactés par courriels, les informant qu'ils avaient été sélectionnés pour participer à une enquête sur les recherches qu'ils avaient menés à l'aide d'un financement de l'ANRS. Que nous souhaitions nous entretenir avec eux. S'ils ne répondaient pas au bout de 8 jours une relance par courriels était faite. Le jour de l'entretien, nous rappelions le but de l'étude aux personnes sollicitées tout en leur donnant de brèves explications, celles qui ont accepté de participer ont reçu des explications détaillées sur l'étude et sur les modalités de leur participation. Des réponses ont été données à leurs questions et préoccupations. Il leur a été expliqué le caractère libre et volontaire de la participation, la durée approximative de l'entretien et l'utilisation des informations recueillies. Il leur était ensuite remis un formulaire de consentement éclairé comportant une note d'information sur l'étude. Après signature de ce formulaire, l'entretien a été réalisé, soit directement, soit sur rendez-vous. Les entretiens ont été conduits dans des lieux garantissant la confidentialité et une minimisation des perturbations extérieures. Les entretiens ont été enregistrés sur dictaphone, en respectant l'anonymat ; A la fin, l'interviewé était remercié.
- Données bibliométriques/projet

Les publications ont été identifiées grâce à une recherche automatisée via le logiciel Publish or Perish des articles scientifiques parus depuis 2005. Les recherches dans la base ont été effectuées en utilisant le moteur de recherche Google scholar et qui ont servi à constituer le corpus de références bibliographiques. Afin de lancer la recherche automatisée, nous avons commencé par établir des mots clés : « ANRS », « Numéro du projet », et « Auteurs ».

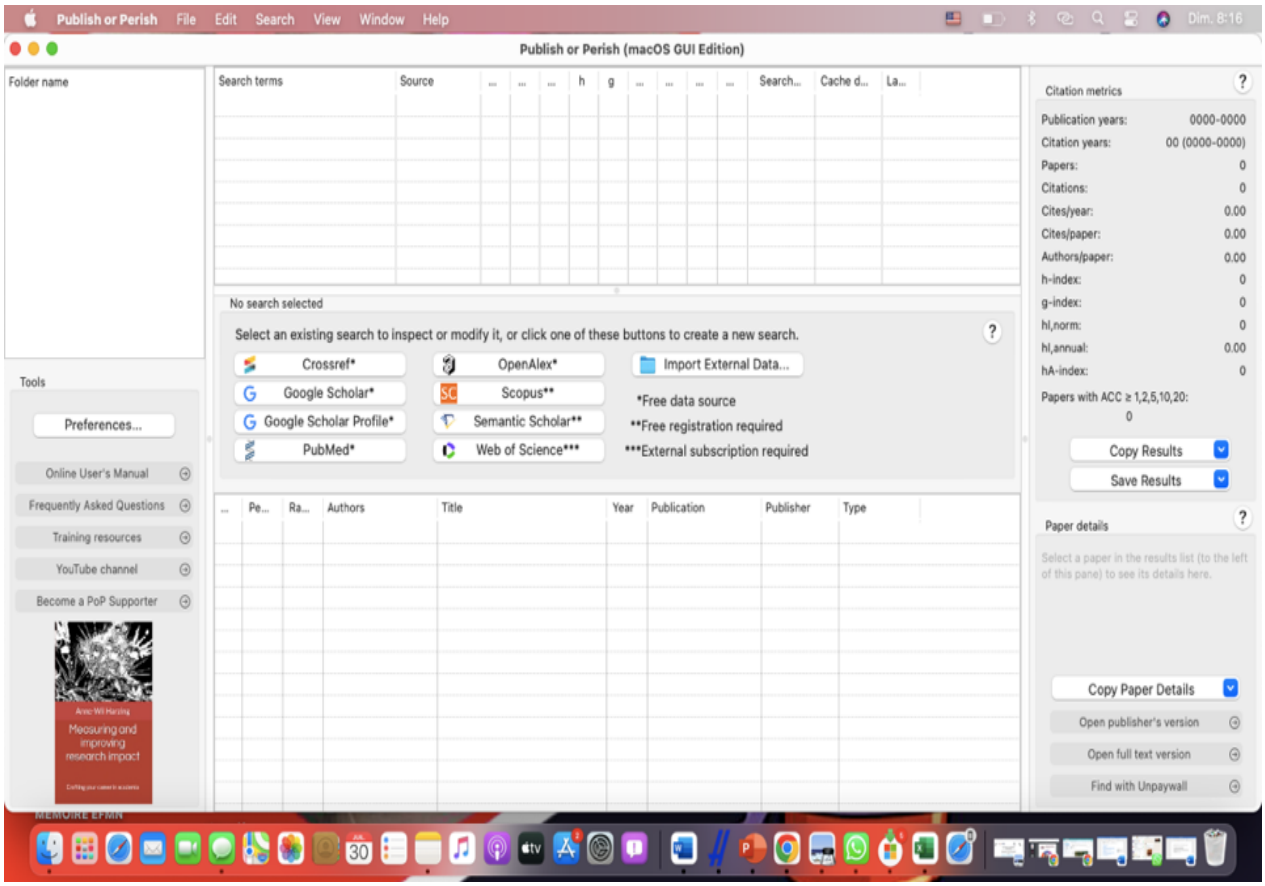


Figure 4 : Logiciel Publish or Perish

VI. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES

- Traitement des données issues des entretiens en face à face :

Les entretiens étaient enregistrés, les audio ont été sauvegardé et anonymisés. Ils ont été ensuite retranscrits en intégralité sur feuille Word. Ces retranscriptions ont été elles-mêmes codés et anonymisés.

- Traitement des données issus du répertoire :

Le répertoire a été nettoyé et enrichi par les informations issues du Logiciel Publish or Perish. L'analyse du corpus de référence récupéré à partir des bases de données s'est faite à l'aide du logiciel Publish or Perish qui a généré les indicateurs bibliométriques.

- Analyses des données issues des entretiens en face à face :

Deux tableaux (un chercheur et un décideur) ont été créés, permettant de regrouper selon les items (questions)

GRILLE D'ANALYSE CHERCHEURS

	C1	C2	C3	C4
1. Présentation de l'interlocuteur : structure/ domaine d'intervention/ affiliations	Donc je suis M.C1, Professeur associé…Maitre de conférences à l'université de Dschang, Faculté de médecine de l'université de Dschang, chef de service à l'hôpital du jour de l'hôpital central de Yaoundé, et coordonnateur technique et scientifique du centre de recherche pour les maladies émergentes et re émergentes CREMER lié à l'IMPM. Donc je travaille sur le VIH, prise en charge des patients vivant avec le VIH et mon	Ok. Moi je suis Mme C2, Docteur en médecine, spécialisée en maladies tropicales, voire en HIV, c'est dans ça que j'ai fait toute ma vie, et je suis au Cameroun depuis beaucoup, beaucoup de temps mais disons dans le cadre de la recherche depuis 2009 avec un essai clinique par l'ANRS. Donc c'est ça qui a commencé un peu mon expérience de recherche au Cameroun, c'était un essai clinique sur les deuxièmes lignes, stratégies de deuxième	Alors bonjour, je suis C3, je suis directeur recherche à l'IRD, l'institut de recherche pour le développement à Montpellier, et j'ai aussi des responsabilités ici au CREMER, puisque je suis responsable de l'unité sur les émergences virales de la faune sauvage ici au CREMER. Alors, je travaille…enfin je suis chercheur depuis toujours, et j'ai passé ma thèse il y'a 31 ans maintenant, des sciences, en 1992, et depuis je ne fais que de la recherche, que ce soit en France ou ici au	ok, je suis M.SC, je suis le chargé de programme éthique de soins et de la recherche au REDS. Le REDS c'est le réseau sur l'éthique et le droit et le Sida. C'est une organisation de la société civile Camerounaise qui établit lutte contre le Sida, mais dans les activités du REDS y'a un volet qui porte sur la veille éthique, sur les projets de recherche mis en œuvre au Cameroun,, Nous avons sollicité pour participer comme membre du comité scientifique de plusieurs études mises en route au Cameroun. Mais également,

Figure 5 : Grille d'analyse entretiens chercheurs

Les verbatims ont été codifiés, puis une analyse écrite a été faite sous forme de paragraphes organisés et restituée par les signes +/-.

VII. CONSIDERATIONS ETHIQUES

- Formalités administratives : Avant la collecte des données nous avons effectué les démarches nécessaires à l'obtention des différentes autorisations indispensables au bon déroulement de l'étude.
- Une clairance éthique a été obtenue auprès du comité institutionnel d'éthique de la

Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de Yaoundé. Nous avons veillé à ce que la confidentialité et l'anonymat des informations recueillies soient respectés et leur exploitation ne s'est limitée qu'au cadre de la recherche.

VIII. CHRONOGRAMME

Activités	Période	Responsable
Rédaction protocole	Septembre 2022	MINLO Éliane
Validation protocole	1er - 31 Oct 2022	Pr ESSI Marie-José /VARLOTEAUX Marie
Correction protocole	23 - 31 Oct 2022	MINLO Éliane
Obtention des autorisations	Mars – Mai 2023	MINLO Éliane
Collecte des données	1er – 30 Juin 2023	MINLO Éliane
Analyse des données	1er - 15 juillet 2023	MINLO Éliane
Rédaction du mémoire	16 - 31 Juilllet 2023	MINLO Éliane
Production Draft 0 du mémoire	1er - 15 Aout 2023	MINLO Éliane
Correction du mémoire	16- 31 Aout 2023	Pr ESSI Marie-José /VARLOTEAUX Marie
Dépôt du mémoire final	Août 2024	MINLO Éliane
Soutenance du mémoire	Septembre 2024	MINLO Éliane
Correction du mémoire soutenu	Septembre-Octobre 2024	MINLO Éliane

IX. BUDGET

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (FCFA)	PRIX TOTAL (FCFA)
Achat articles*	10	50000	500000
Imprimeries	/	/	175000
Communication	11	20000	220000
Fournitures bureautique*	/	/	50000
Imprévus	/	/	100000
TOTAL(FCFA)			**1045000**
Sources de financement : fonds propres 50% ; financement ANRS 50% (*)			

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Chapitre IV :

RESULTATS

Ce chapitre illustre les résultats de la collecte des données sous forme de tableaux, d'histogrammes et de diagrammes. Il débute par la description du Site partenaire ANRS-MIE Cameroun, suivi de la productivité scientifique du site et de la valorisation de ces travaux.

I. DESCRIPTION DU SITE ANRS/MIE CAMEROUN :

Le Site partenaire ANRS-Cameroun est un site partenaire de l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales, Maladies infectieuses émergentes (ANRS|MIE) qui s'intègre dans la politique et le système national de santé du Cameroun.

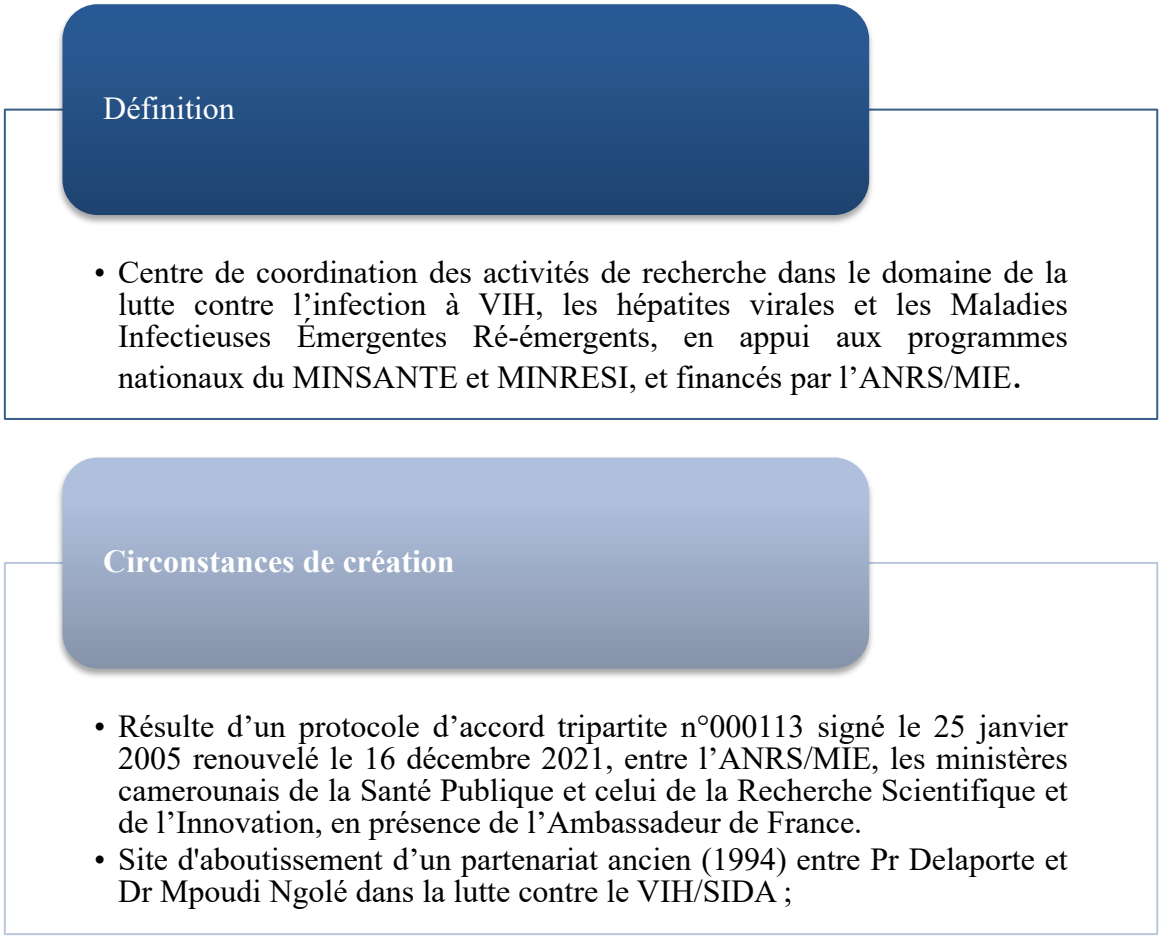


Figure 6 : Historique du site ANRS|MIE Cameroun

Il est situé à l'Hôpital Central de Yaoundé et favorise les échanges entre chercheurs et accueille des étudiants, des chercheurs, des enseignants, des professionnels de la santé, des associations de personnes vivant avec le VIH en offrant certaines facilités (salle de réunion, connexion internet, bibliothèque) pour leurs travaux. Il est logé dans un bâtiment à deux niveaux.

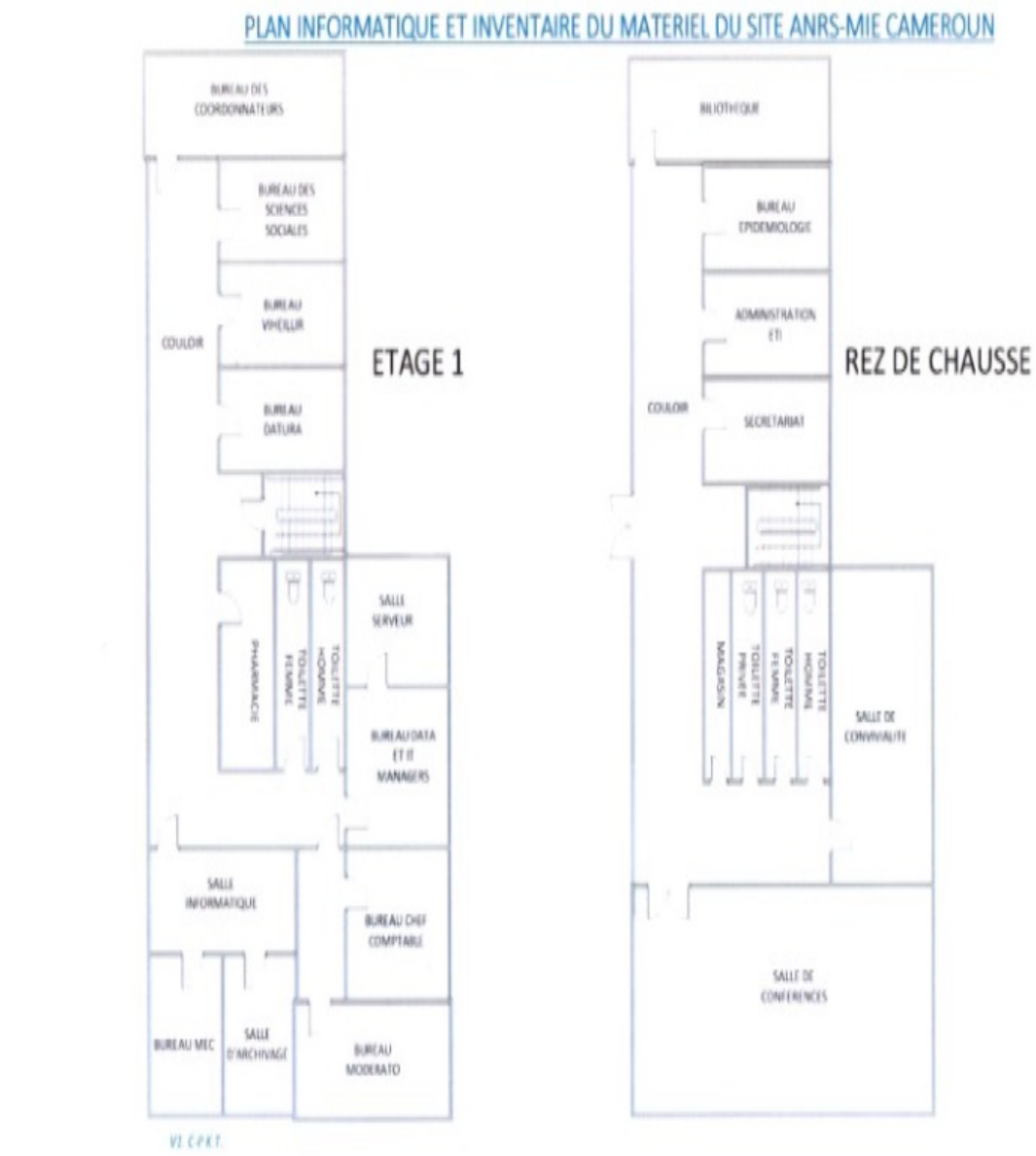


Figure 7 : Bureaux du site ANRS/MIE Cameroun

Au rez de chaussée on retrouve 10 pièces (Un bureau administration ETI, un secrétariat, un bureau épidémiologie, une bibliothèque, une salle de conférence, une salle de convivialité, un magasin et 3 toilettes). A l'étage on retrouve 14 pièces (un bureau des coordonnateurs, un bureau des sciences sociales, 3 bureaux pour les projets VIHEILLIR, DATURA et MODERATO, une pharmacie, 2 toilettes, un bureau Data et IT managers, une salle serveur, une salle informatique, un bureau Monitrice d'Étude Clinique (MEC), une salle d'archivage, un bureau chef comptable.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Le Site ANRS-Cameroun dispose d'un organigramme de ressources humaines à 3 niveaux pour mener à bien ses activités. Il est placé sous la responsabilité conjointe d'un Coordonnateur Sud, et un Coordonnateur Nord avec le soutien d'une Conseillère scientifique et d'une Experte Technique International (ETI). Le rôle de l'experte technique est de s'assurer du bon fonctionnement du site et de la mise en œuvre des projets.

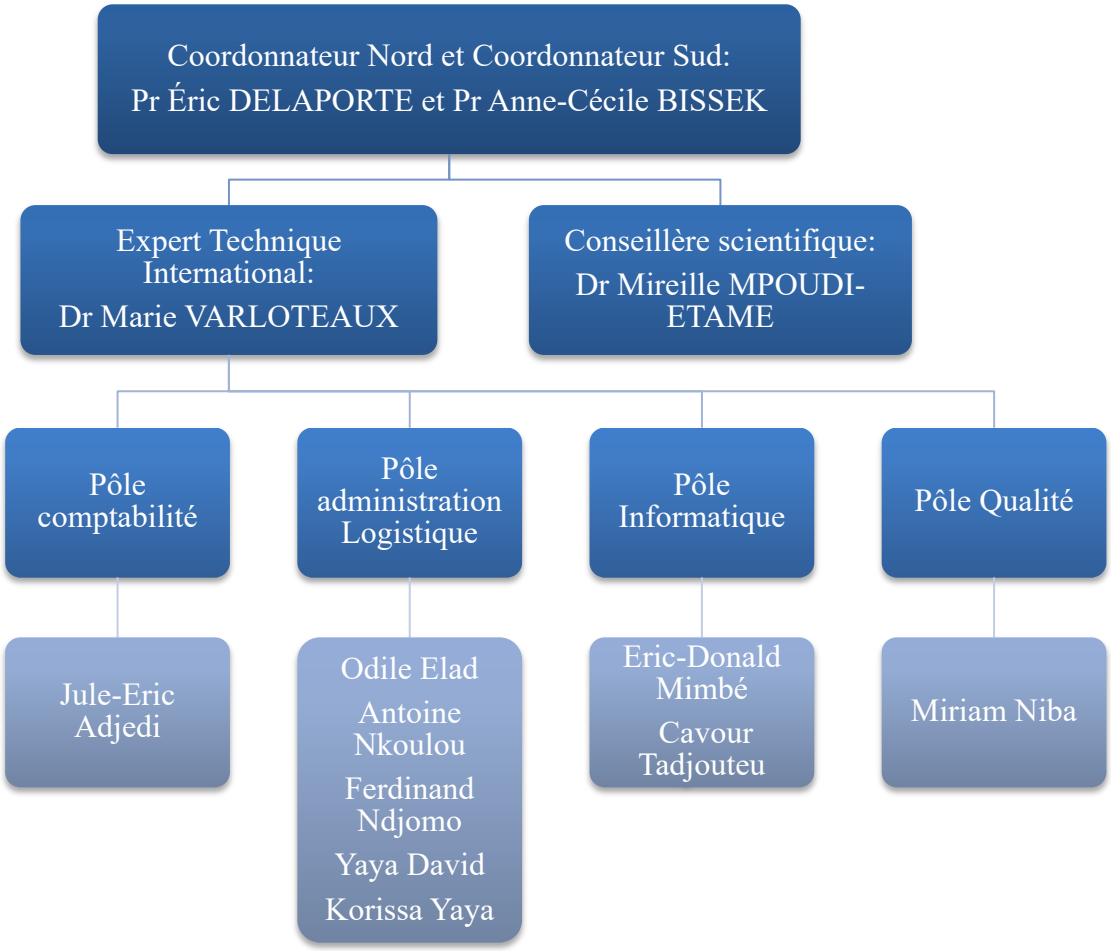


Figure 8 : Organisation générale du Site ANRS/MIE Cameroun

L'organisation interne du site est ordonnée en quatre (4) pôles : pôle comptabilité, le pôle Administratif et Logistique, le pôle informatique et le pôle qualité.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

L'ensemble de ce personnel est financé par le budget Site qui est un véritable lieu d'animation scientifique et de formation. La mission principale l'animation scientifique, l'évaluation, la coordination et le financement de la recherche sur le VIH/Sida, les hépatites virales, les IST, la Tuberculose et les maladies infectieuses émergentes telle que mentionnée dans la figure ci-dessous.

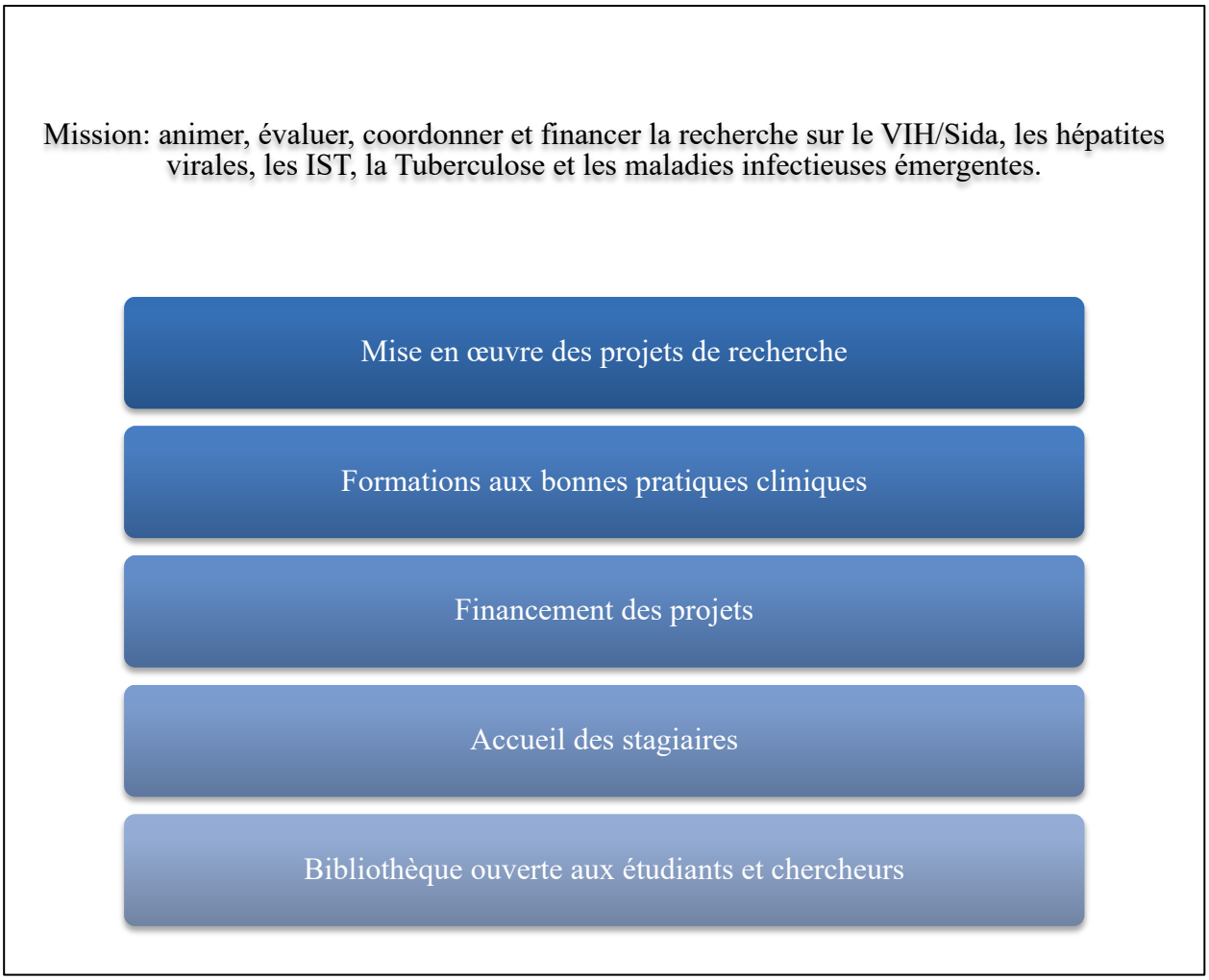


Figure 9 : Missions du site ANRS/MIE Cameroun

Ce site partenaire étant l'un des sites au cœur des projets que l'agence finance dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) bénéficie de soutiens permanents pour la formation, les équipements et infrastructures, le développement de réseaux et l'accompagnement des jeunes chercheurs. Il établit régulièrement des partenariats avec des organismes internationaux, Institutions, fondations privées, associations, que ce soit dans le cadre d'accords interinstitutionnels ou limités à des projets de recherche.

Tableau II : Partenaires principaux du site ANRS/MIE Cameroun

	Partenaires
Institutions camerounaises	Université de Yaoundé 1
	Université Catholique d'Afrique Centrale
	Université de Ngaoundéré
	MINSANTE
Équipes Camerounaises	Laboratoire mixte IMPM/CREMER/IRD
	IFORD
	IRSA
	Division de la Recherche Opérationnelle en Santé (DROS)
	FMSB
	Centre Pasteur du Cameroun (CPC)
	Hôpital Général de Douala
	Hôpital Central de Yaoundé
	Hôpital Militaire Yaoundé 1
	Hôpital de District de la Cité Verte
	Hôpital Laquintinie de Douala
	Hôpital Jamot de Yaoundé
	Centre Mère et Enfant de la Fondation Chantal Biya (CME-FCB)
	Centre Hospitalier d'Essos, Yaoundé
	Clinique de la Cathédrale, Yaoundé
	Fondation Paul Ango Ela, Yaoundé
Institutions françaises	IRD
	Institut pasteur
	INSERM
	CNRS
	ISPED
	IBB
	IMEA CHU, Montpellier
	CHU Necker, Paris
	CHU Robert Debré, Paris
	CHU Rouen
	CHU Angers
Autres équipes Sud	CHU de Fann, Dakar, Sénégal
	CHU Le Dantec, Dakar,
	Université Cheikh Anta Diop, Dakar Sénégal
	CHU Sanou Soro Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso
	Centre Muraz, Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso
	PACI-CI, Abidjan, Côte d'Ivoire
	CERFIG, Guinée
	INRB, Kinshasa, RDC

Les partenaires principaux du site (CREMER, IRD, Université de Yaoundé 1) ont réalisé plusieurs acticités avec le site ANRS/MIE Cameroun, comme la réalisation conjointe de programmes de recherche, l'encadrement de master de Santé Publique, et l'animation de conférences, la mise en œuvre de projets de recherche.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

II. ETAT DES LIEUX DES TRAVAUX DU SITE ANRS/MIE CAMEROUN DEPUIS 2005

Au total, 90 projets de recherche ont été financés par l'ANRS entre 2005 et 2022. La tendance du nombre de projets financés par an était croissante, atteignant sa valeur maximale en 2020.

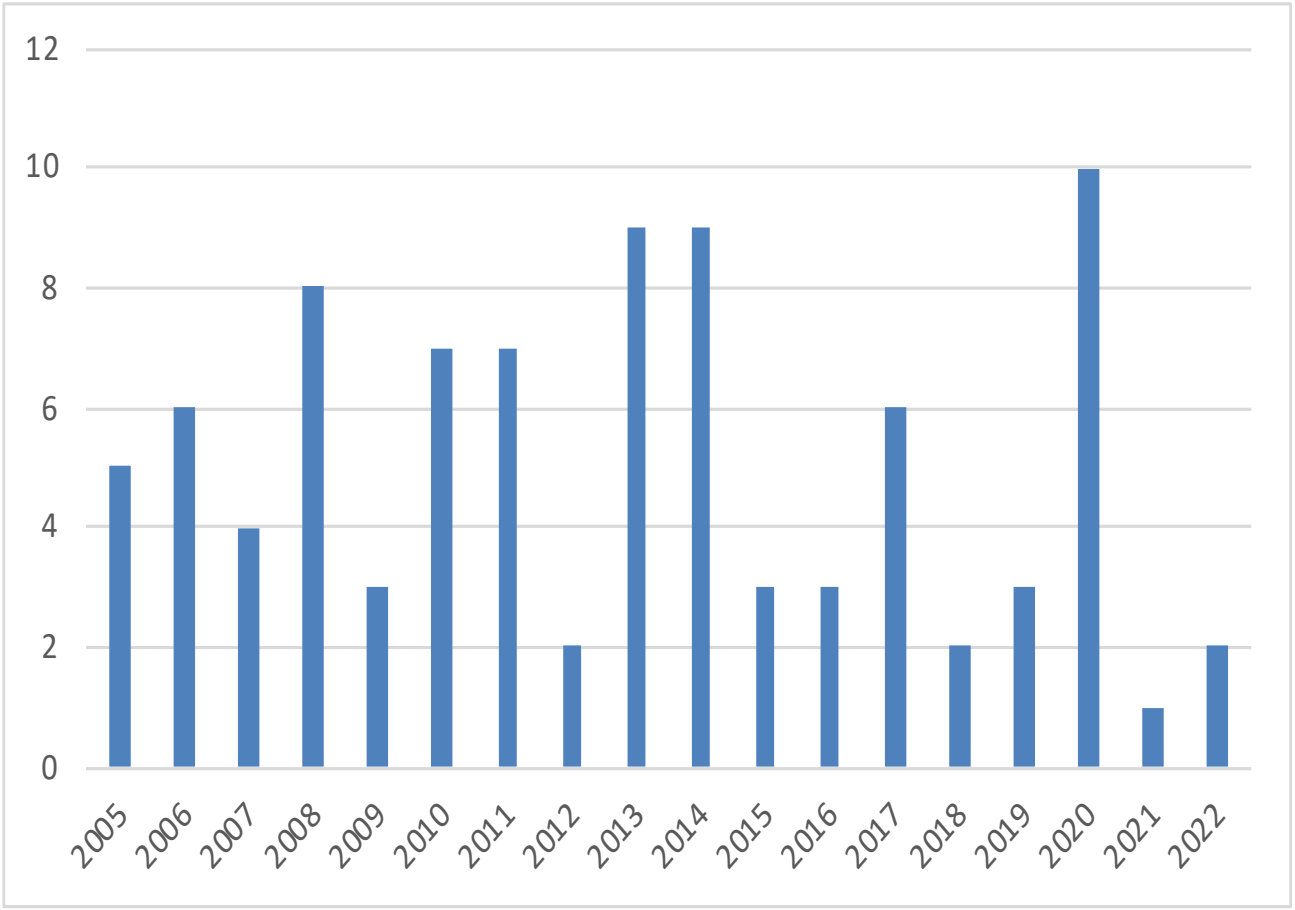


Figure 10 : Répartition annuelle du nombre de projets entre 2005 et 2022

Le pic observé en 2020 peut s'expliquer par le fait que suite à la survenue de l'infection au SRAS-COV2 en décembre 2019 et de son impact en santé publique, en Avril 2020 l'ANRS lance un appel flash spécial COVID-19 et reçoit plusieurs projets de recherche. Leurs états d'avancement est hétérogène, certains ont déjà reçu les autorisations éthique et administrative et d'autres sont en cours de demande.

La réalisation de ces projets a impliqué une collaboration entre le Nord et le Sud. Au total 98 Investigateurs ont participé à la coordination des différents projets entre 2005 et 2022, soit 51(52%) coordinations Nord et 47(48%) coordinations Sud. A travers ces coordinations, nous avons pu établir le top18 des investigateurs clés ayant coordonné plus d'un projet durant cette période.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Tableau III : Investigateurs clés basés sur le nombre de projets coordonnés.

Rang	Investigateurs	Nombre de projets
1	Charles KOUANFACK	7
2	Martine PEETERS	7
3	Mathurin Cyrille TEJIOKEM	5
4	Richard NJOUOM	5
5	Eitel MPOUDI-NGOLE	4
6	Fred EBOKO	4
7	Avelin AGHOKENG FOBANG	4
8	Laurent VIDAL	3
9	Christopher KUABAN	3
10	Jean-Christophe PLANTIER	3
11	Sinata KOULLA SHIRO	3
12	Laura CIAFFI	3
13	Jean-Paul MOATTI	2
14	Eric DELAPORTE	2
15	Benjamin CORIAT	2
16	Ahidjo AYOUBA	2
17	Maurice ENGUELEGUELE	2
18	Olivier LORTHOLARY	2

De même la distribution géographique des projets a révélé une prédominance des collaborations en provenance des pays du Sud. En somme 25 pays ont collaboré avec le Cameroun dans la réalisation des projets depuis 2005. Le Burkina Faso 20(22%) et le Sénégal 19(21%) représentaient les pays qui collaboraient le plus avec le Cameroun suivi de la Côte d'Ivoire 15(17%).

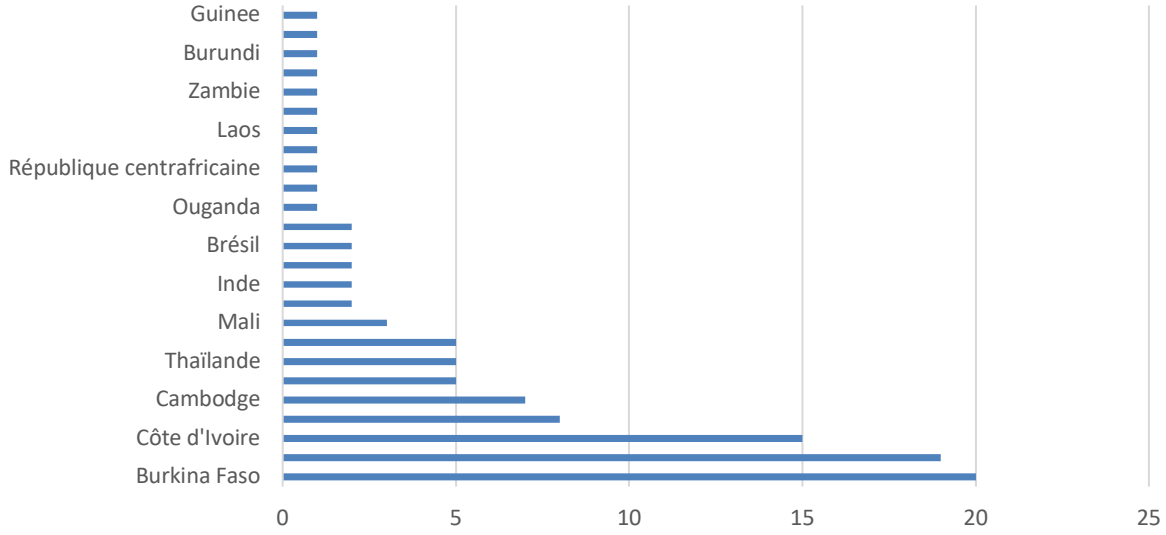


Figure 11 : Distribution des pays ayant collaboré le plus avec le Cameroun

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Ces résultats témoignent de l'importance d'une collaboration internationale inclusive pour aborder de manière exhaustive les défis posés par les maladies infectieuses émergentes et ré émergentes. Cette répartition géographique des projets suggère un besoin potentiel de renforcer la recherche dans les régions sous-représentées.

Tableau IV : Répartition des projets selon les thèmes et domaines de recherche (n=90)

	Variables	Effectif	Fréquence (%)
Thématiques	VIH	71	79
	Hépatite	9	10
	MIE	7	8
	VIH/TB	3	3
	Sciences humaines et sociales	42	47
Domaines	Virologie	27	30
	Recherche Fondamentale	14	15
	Économie de Santé	5	6
	Prevention	2	2

Tous les domaines de recherche au Cameroun étaient représentés (recherche fondamentale, virologie, sciences humaines et sociales). L'objectif étant d'améliorer la prévention, la prise en charge et l'accès aux traitements efficaces. Les essais cliniques étaient les plus représentés 37(41%) suivies des études diagnostiques 28(31%).

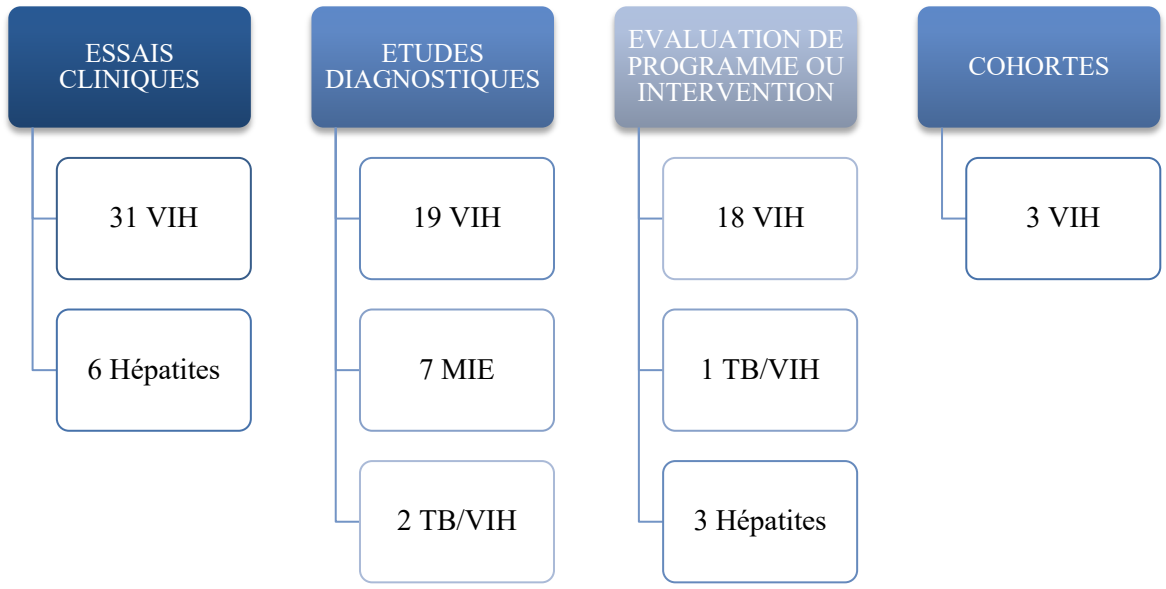


Figure 12 : Répartition des projets selon les types d'études

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

L'objectif poursuivi par le centre de recherche est de mieux comprendre, prévenir et contrôler les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes en privilégiant la pluridisciplinarité afin de promouvoir l'innovation en matière de diagnostics et de traitements.

Afin de permettre à la communauté scientifique d'être informée, plusieurs travaux issus des projets financés depuis 2005 ont fait l'objet de publications. Au total 240 articles ont été publiés au cours de ces 17 dernières années.

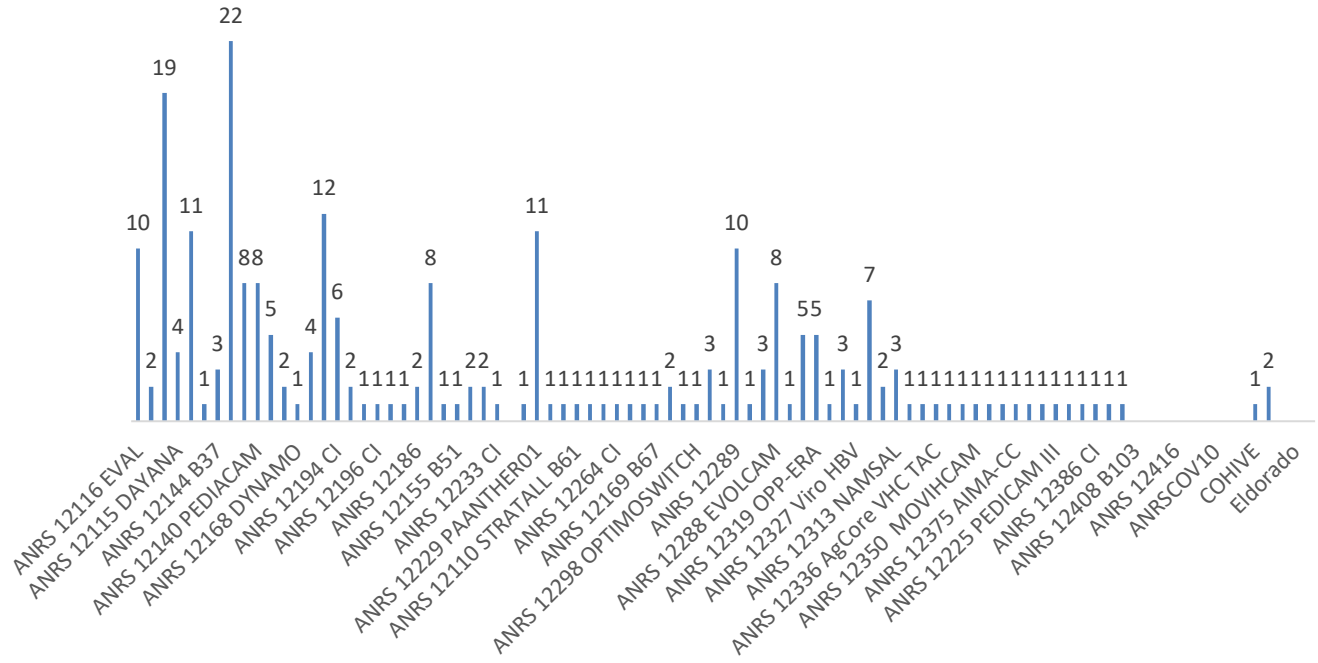


Figure 13 : Nombre d'articles publiés par projets financés depuis 2005

Les études les plus récentes sont toujours en cours et n'ont pas encore été publiées car il y a un temps entre la mise en place des projets de recherche (financement), l'exécution de la recherche, la collecte des données, leurs analyses et la rédaction de l'article. Quelques publications ont marqué leur importance et leur influence dans la communauté scientifique.

Tableau V : Répartition des publications scientifiques les plus citées

Année	Publications	Citations
2005 et 2008	Décentralisation de l'accès au traitement antirétroviral en Afrique : étude coût-efficacité de la prise en charge des patients sous antirétroviraux selon une approche de suivi allégé dans des hôpitaux de district (ANRS 12110 STRATALL)	516
2012	Essai de phase III randomisé et contrôlé sur la méningite à cryptocoque associée au VIH : fluconazole oral / flucytosine ou traitement à base d'amphotéricine B d'une semaine vs traitement à base d'amphotéricine b de deux semaines. (ACTA ANRS 12275)	399
2006 et 2010	Devenir à 5 ans des enfants infectés par le VIH traités précocement par HAART au Cameroun (ANRS 12140-12225 PEDIACAM)	371
2014	Essai de phase III multicentrique randomisé, ouvert, visant à évaluer le dolutégravir versus 400 mg d'éfavirenz, tous deux associés à Fumarate + Emtricitabine + ténofovir disoproxil ou à la lamivudine pour la prise en charge initiale d'adultes infectés par le VIH dans des environnements dotés de ressources limitées (NAMSAL ANRS 12313)	280
2007	Suivi des patients participant à l'étude de phase III multicentrique, randomisée, ouverte, non infériorité comparant la réponse virologique (ARN plasmatique du VIH <50 copies / ml) à 48 semaines de trois schémas thérapeutiques antirétroviraux chez des patients infectés par le VIH-1 échec thérapeutique après traitement antirétroviral de première ligne au Cameroun, au Sénégal et au Burkina Faso. (ANRS 12169 2-LADY)	120

Ces travaux de recherche ont eu des impacts non négligeables en termes de politique de santé publique en apportant de nouvelles données permettant d'actualiser les recommandations nationales et internationales. Ils ont également impliqué plusieurs auteurs par publication.

Le site partenaire ANRS/MIE Cameroun dans l'accompagnement des chercheurs, participe également à la transposition des résultats de recherche en politiques publiques.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

III. VALORISATION DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES

Durant la période d'étude, 11 personnes ont été contactées et 7 ont répondu favorablement.

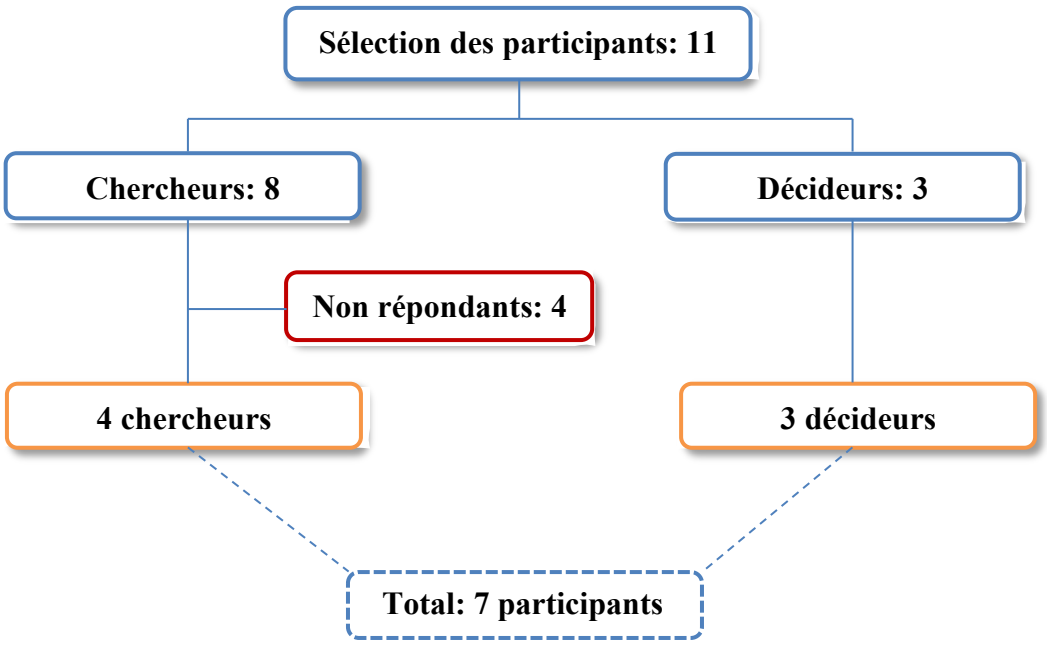


Figure 14 : Schéma de recrutement des participants

L'échantillon était constitué de sept (7) personnes dont quatre (4) chercheurs et trois (3) décideurs. On notait une prédominance des sujets de sexe masculin avec un Sex ratio H/F de 1,3.

Tableau VI : Caractéristiques générales des participants (n=7)

Variables	Modalités	Effectif	Fréquence (%)
Sexe	Homme	4	57,1
	Femme	3	42,9
Profession	Professeur en Médecine/HCY	1	14,3
	Médecin spécialisé en médecine tropicales /VIH	1	14,3
	Directeur de recherche/IRD	1	14,3
	Chargé de programme éthique de soins et de la recherche/IRD/CREMER	1	14,3
	Ancien Secrétaire permanant adjoint /GTC-CNLS	1	14,3
	Chef-DROS	1	14,3
	Ancien Secrétaire General MINSANTE	1	14,3

Au total, sept (7) entretiens semi-directifs ont été conduits, auprès des professionnels qui présentaient une ancienneté dans le domaine de la recherche en santé humaine allant de 14 à 31 ans.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

L'analyse des verbatims issus de ces entretiens a permis de faire ressortir différents points en ce qui concerne le processus de valorisation des résultats des travaux de recherche. La diffusion est la première étape de la valorisation des résultats d'une recherche allant de la mise en place du projet à la publication. En ce qui concerne la mise en œuvre des projets, la première difficulté évoquée par les interviewés était l'obtention des autorisations. Les autres obstacles rencontrés étaient la difficulté à obtenir un financement, et pour finir la faible compétence de certains chercheurs à la pratique.

Tableau VII : Diffusion des résultats issus de la recherche par les chercheurs

	Variables	Performance
Difficultés	Difficulté d'obtention des autorisations	++++
	Difficulté d'obtention des financements	++++
	Faible compétence à la pratique	++/--
Stratégies	Publications dans les journaux à comité de lecture	+++/-
	Restitution aux participants	++++
	Restitution aux associations de malades	+/---

Les interviewés estimaient que la restitution des résultats de leurs recherches aux participants était effective et proposaient également la restitution auprès des associations des malades, ou des associations qui travaillaient sur le sujet. Ils ont tous affirmé que les recommandations nationales étaient conduites sur la base des évidences scientifiques internationales et les directives des institutions internationales et qu'ils avaient accès à ces recommandations en lisant des revues ou articles scientifiques et en participant à des conférences nationales ou internationales.

Tableau VIII : Accès aux recommandations/élaboration des politiques par les décideurs

	Variables	Performance
Accès aux recommandation issues de la recherche	Participation aux conférences internationales et nationales	+++
	Lecture de revues/articles scientifiques	+++
	Participation à des restitutions de travaux scientifiques	+++
Mécanismes d'élaboration des politiques	Organisation de rencontres entre praticiens, cliniciens, et autres chercheurs	+/--
	Organisation des restitutions de travaux scientifiques	+/--
	Notes synthétiques pour améliorer ou élaborer les directives	+/--

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Toutes les personnes interrogées estimaient avoir eu recours à certains outils de transfert de connaissances mais avec beaucoup de difficultés. Ils proposaient en plus des restitutions aux participants, l'organisation des rencontres réunissant des praticiens, des cliniciens, d'autre chercheurs. Ils ont également abordé la question de ressortir les points saillants à travers des notes de synthèse pour améliorer ou élaborer des directives. Il est à noter que les comptes rendus d'une réunion de restitution ne donnaient pas de propositions exactes, tandis qu'un résumé des délibérations, permettrait une lecture rapide des décideurs.

Les résultats de ces entretiens ont permis de mettre en évidence plusieurs points constituant des obstacles au processus de valorisation des résultats de recherche du site ANRS|MIE Cameroun.

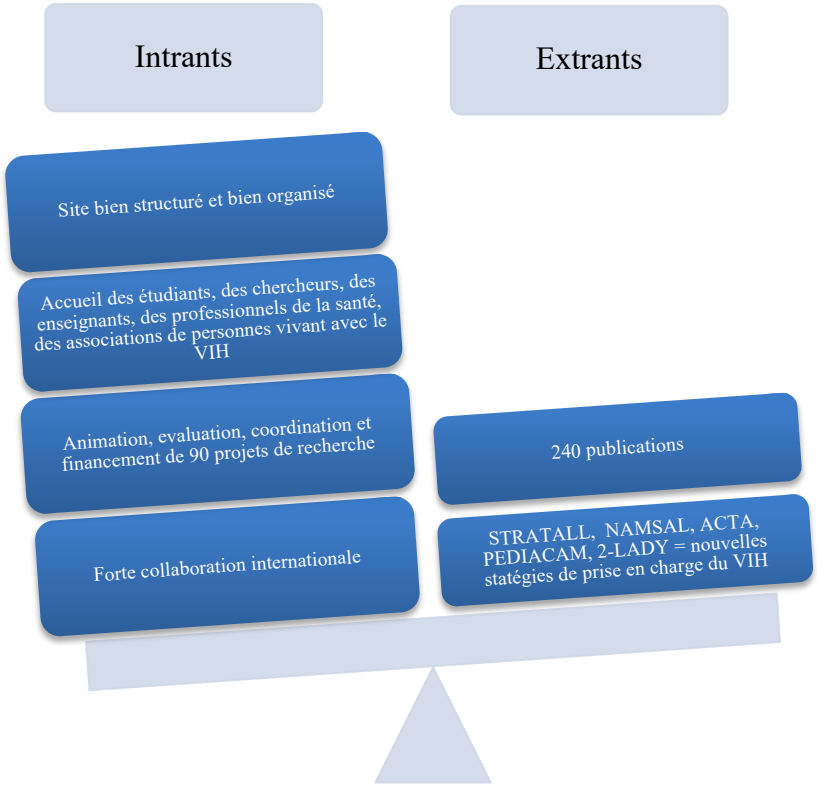


Figure 15: Apport scientifique du site ANRS/MIE Cameroun

D'une manière générale, les personnes interrogées ont démontré beaucoup d'insuffisances dans la valorisation de leurs travaux de recherche et ont porté un grand intérêt à être bien outillés sur le transfert des connaissances en proposant des délibérations, mais aussi des notes politiques indispensables à la prise de décision.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

CHAPITRE V :

DISCUSSION

Limite de l'étude :

Il s'agissait d'une recherche déclarative qui impliquait des individus par conséquent une difficulté d'accès à l'information.

I. PRODUCTIVITE SCIENTIFIQUE

Cette étude a démontré que la recherche sur les maladies émergentes est en progression au site ANRS Cameroun. A partir de 2005 la tendance du nombre de projets financés par an était croissante, atteignant sa valeur maximale en 2020. La recherche sur le VIH couvre plusieurs domaines dont : la recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche vaccinale, la recherche en santé publique, les sciences sociales [9]. Dans cette étude, les domaines de recherche recensés portaient sur les sciences humaines et sociales (47%), La virologie (30%), la recherche fondamentale (15%) et la prévention (2%). Les sciences sociales occupaient la première place, par contre la prévention était le domaine le moins représenté. Ces résultats vont en l'encontre de ceux présentés par Mossus en 2017 qui indiquaient que les domaines prioritaires de la recherche sur le sida au Cameroun étaient par ordre d'importance : La recherche fondamentale (20,06%) ; Les co-infections et maladies opportunistes (19,63%) ; La prise en charge (19,63%) et La prévention (13,70%)[9]. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que nous sommes manifestement depuis une quinzaine d'année, dans un changement de paradigme avec le concept One Health et santé mondiale. Ce nouveau régime appelle de nouvelles réponses, à hauteur des défis à relever dans l'urgence des crises épidémiques ainsi que pour mieux répondre aux enjeux de gestion de crises. La recherche est un pilier essentiel dans la réponse à ces épidémies avec un double enjeu : d'une part améliorer les connaissances sur la maladie, sa prévention, son traitement, son diagnostic, l'impact sur la société et d'autre part préparer et comprendre les émergences futures, voire anticiper. Les principaux sujets d'études étaient le VIH (79%), les Hépatites (10%), les MIE (8%) et les co-infections VIH/TB (3%). La recherche sur le VIH vise à mieux comprendre, prévenir et soigner cette épidémie, dont les conséquences en termes de santé publique et d'équilibre social et politique des États, justifient un engagement majeur constant. Les Essais cliniques étaient les plus représentées (41%) suivies des études diagnostiques (31%). Ces résultats sont en accord avec ceux de Le Bihan et al qui a montré que les essais cliniques étaient les plus retrouvés en Afrique mais peu nombreux par rapport à la population. Les 63 essais interventionnels pour lesquels la France était promoteur en Afrique ne concernaient que les maladies infectieuses et l'épidémiologie [36]. L'étude a relevé au total 240 publications par projets financés entre 2005 et 2022 avec une absence de publications durant les dernières années ceci pouvant s'expliquer par le fait qu'il existe un

temps entre la mise en place des projets de recherche (allant de la rédaction au financement), la demande au comité éthique, l'exécution de cette recherche, la collecte des données, leurs analyses et la rédaction de l'article. Il est bien connu que la temporalité de la recherche s'inscrit dans un temps long. Identifier un sujet d'intérêt, concevoir les modalités de la recherche, élaborer les méthodologies les plus appropriées, recueillir les données, les analyser et les interpréter, rédiger et parvenir à la publication de l'article nécessitent du temps de réflexion, d'ajustement, de confrontation d'idées [37]. Ces résultats se rapprochent de ceux retrouvés par Kouakou et al en 2018, qui montraient que sur une période allant de 1960 à 2018, la production sénégalaise sur les MNT était très faible avec seulement 808 publications parues dans 305 revues. Les raisons essentielles évoquées étaient l'insuffisance de financement et la jeunesse des programmes de formation dans le domaine justifiant cet état des faits [34].

II. RESTITUTION DES RESULTATS

Les entretiens ont constitué une occasion pour les intervenants de relever les difficultés qu'ils rencontraient dans la mise en œuvre des projets, pouvant être des obstacles au processus de valorisation des résultats de recherche dans notre contexte. Il s'agissait principalement, des difficultés à obtenir les autorisations éthiques, des financements pour leurs recherches et l'insuffisance de certains chercheurs sur les plans éthique et pratique. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que d'une part les échanges avec les comités éthiques pour avoir les autorisations éthiques soient assez longs et qu'il y'ait beaucoup d'incompréhensions au moment des appels d'offre internationaux, qui sont supposés avoir eux aussi la clairance éthique du pays promoteur. Ceux-ci demandent de nombreux justificatifs tout ceci avant que les contrats de collaboration avec transferts de crédits soient réalisés. Et d'autre part le fait que certains centres de recherche n'aient pas d'expérience en recherche. Une étude menée par Drepez et al en 2007 corroborait nos résultats. Cette dernière a montré que lorsqu'un chercheur travaillant en sciences humaines conçoit un projet de recherche en vue de répondre à quelques questions qu'il considère comme pertinentes, il doit réadapter ce projet initial parce que sa recherche concerne des êtres humains [38]. Dans cette même lancée, au Cameroun, la loi N 2022/008 du 27 Avril 2022 relative à la recherche médicale impliquant la personne humaine, a déclaré que tout projet de recherche médicale conduit au Cameroun doit, au cours de sa conception et de sa mise en œuvre, être soumis aux normes éthiques qui promeuvent et assurent le respect de tous les êtres humains et qui protègent leur santé et leurs droits. La recherche médicale impliquant des personnes humaines doit être conduite uniquement par des personnes ayant acquis une

éducation, une formation et des qualifications appropriées en éthique et en sciences, notamment les médecins de toutes spécialités confondues, les pharmaciens et médecins bucco-dentaires.

Au cours de nos entretiens avec les chercheurs tous ont déclaré restituer les résultats de leurs travaux de recherche dans des formats adaptés, à savoir : la restitution aux autorités, la participation conférences internationales et nationales, la publication dans les journaux à comité de lecture et la restitution aux participants. En effet selon la littérature, rendre compte des résultats de sa recherche à ceux qui l'ont accueillie ne mérite à priori guère de justification, tant cette démarche semble acquise. On la qualifiera d'éthique, de déontologique, de responsable voire de méthodologique voulant exprimer une seule et même nécessité. La démarche des chercheurs serait inachevée si ces derniers ne prenaient pas le temps de partager leurs analyses avec les personnes qui ont rendu possible l'étude[39].

Néanmoins, ce n'était pas suffisant car certains chercheurs ont proposé que des restitutions soient également faites aux associations de malades, ou des associations qui travaillent sur le sujet et d'organiser des rencontres réunissant des praticiens, des cliniciens, et d'autres chercheurs. Et même de faire des take home messages ou des courtes vidéos, qui présenteraient les résultats plus parlants. Nous pouvons assimiler ce résultat à un défaut de formation des chercheurs sur le transfert des connaissances.

III. RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA RECHERCHE

Une recherche, notamment dans l'espace de la santé, ne peut se priver des informations révélées lors d'une restitution. Il y aurait là, en plus d'une erreur éthique, une insuffisance méthodologique [39]. Elle est indispensable à la prise décision en mettant à la disposition des décideurs des données valides et pertinentes. Au cours de nos entretiens, les décideurs ont tous montré un intérêt pour la recherche. D'une part que, la recherche apporte des réponses à certaines questions et informe les décideurs de ce qui est disponible et puis surtout influence les politiques. D'autre part, qu'elle participe à créer de nouvelles connaissances ou à renforcer des connaissances déjà connues afin de pouvoir prendre des décisions pour améliorer la santé des populations, dans le cadre de la santé. Tout en prenant appui sur les évidences scientifiques internationales et les directives des institutions internationales pour mettre à jour les recommandations nationales. De nombreux projets de recherche qui se sont déroulés au Cameroun depuis la création du Site ANRS-Cameroun ont eu des impacts non négligeables en termes de politique de santé publique nationale et internationale. Nous avons par tout d'abord, le projet STRATALL entre 2005 et 2008, qui a démonté l'efficacité d'une prise en charge décentralisée de qualité. En 2007, le Président de la République annonçait la gratuité de la prise

en charge de l'infection à VIH au Cameroun. En 2008, les nouvelles recommandations de prise en charge de l'infection à VIH, émanant de l'étude STRATALL étaient appliquées au Cameroun. Entre 2006 et 2010 l'étude PEDIACAM, a mis en évidence tout l'intérêt d'une mise sous traitement précoce des enfants en mettant en place une cohorte. Il s'agissait de l'étude PEDIACAM 12140-12225, qui avait pour intérêt de mieux comprendre les problèmes d'observance des traitements pris précocement, les risques de toxicité, les éventuelles atteintes cognitives, motrices et sensorielles chez l'enfant né de mère séropositive. Cette cohorte a apporté de nouvelles données permettant d'actualiser les recommandations internationales sur la prise en charge des nouveaux nés. Toujours dans l'intérêt du patient et dans l'optique d'améliorer la qualité de sa prise en charge. De nouvelles questions de recherche émergeaient au fils du temps. Certains patients en première ligne se sont retrouvés en échec thérapeutique. Une nouvelle étude a proposé d'évaluer des stratégies de traitements de 2° ligne à partir de 2007. Il s'agissait de l'étude 2-LADY, celle-ci donnera de nouvelles recommandations à l'OMS. En 2012, Outre l'accès aux antirétroviraux, de nombreuses pathologies dites opportunistes augmentent le risque de mortalité des personnes infectées par le VIH. La cryptococcose en faisait partie. L'essai international ACTA ANRS12275 évaluait différentes approches pour réduire la mortalité précoce très élevée liée à la cryptococcose, une des infections opportunistes les plus fréquentes dont le traitement est particulièrement complexe dans les pays du sud. Elle a permis de mettre à jour les recommandations OMS. Enfin, l'essai NAMSAL ANRS 12313 en 2014, qui comparait au Cameroun, l'efficacité de deux régimes thérapeutiques de première ligne innovants, le Dolutegravir (DTG) et l'Éfavirenz 400mg (EFV 400mg). Les premiers résultats de cette étude ont été publiés dans le The New England Journal of Medecine, où l'OMS recommandait le DTG comme option à privilégier contre le VIH dans toutes les populations. Ils ont permis de changer les recommandations de l'OMS et celle du Cameroun en 2019. Ces résultats se rapprochent de Kacem et al en 2018, qui a montré que certes le nombre de publications tunisiennes était réduit, mais leur efficience et leur impact sur le changement de la stratégie nationale était capital [40].

IV. ELABORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Selon nos résultats, en plus d'assister à des restitutions, certains décideurs en organisaient également quand ils étaient directement concernés par la recherche. Néanmoins les formats de restitution n'étaient pas toujours adaptés. Ceci peut s'expliquer par le fait que la communauté scientifique dans notre contexte ne soit pas réellement formée sur les outils de transfert de connaissances. Il a été proposé par la suite de ressortir les points saillants, et en faire des

propositions au Ministre de la Santé publique, pour améliorer ou élaborer des directives. Car le compte rendu d'une réunion de restitution ne donnait pas de propositions exactes, tandis qu'un résumé des délibérations, où ressortent les éléments saillants, recensés et documentés dans une espèce de brief note, permettrait une lecture rapide des décideurs. Ces résultats sont en accord avec une étude réalisée en France en 2020 par Christian Dagenais et al. qui a montré qu'il existe encore relativement peu de données probantes sur l'efficacité des notes de politiques en tant qu'outil de transfert de connaissances. Néanmoins, des études ont montré que les décideurs considèrent les notes de politiques comme un précieux outil de communication et qu'ils les utilisent pour la prise de décision ; que les hauts fonctionnaires ont une préférence pour les résultats prédigérés et que les décideurs préfèrent les sources d'informations à message unique, concises, accessibles et sommatives [41]. Par ailleurs, Une récente revue systématique a repéré trois études montrant que les notes de politiques qui présentaient des opinions d'experts « peuvent influencer les intentions d'agir au niveau des politiques de santé publique ». L'une de ces études, basée sur un essai contrôlé randomisé, montrait notamment que l'inclusion des opinions d'experts dans les notes, par exemple, celles de ceux qui ont réalisé l'étude, aide à renforcer certains messages qui découlent de l'étude. Les études que nous avons menées sur l'efficacité des notes de politiques dans le cadre d'ateliers de restitution de la recherche montrent également que les notes sont peu utiles si elles ne sont pas envoyées à l'avance aux participants et que, lorsqu'elles le sont, elles favorisent l'utilisation des résultats qu'elles présentent [41]. D'une manière générale, le courtage de connaissances est une notion pas encore connue dans notre contexte, mais la plupart a pensé qu'au lieu effectivement de faire des restitutions, de faire des délibérations, mais aussi une note synthétique de ce qui a été trouvé et émettre des recommandations concrètes basées sur les résultats des recherches à la question. La délibération étant un échange entre plusieurs personnes dont l'objectif est de faire émerger des décisions acceptables pour tous et où chaque participant écoute le point de vue des autres et contribue à accroître la compréhension des intérêts et des valeurs en jeu pour déterminer les meilleures actions à entreprendre dans un contexte précis. Grâce à cette conversation, les participants parviendraient à un consensus sur une recommandation, une décision, une intervention ou une politique [42]. Une autre étude menée par David Scott Jervis-Jalabeles et al, a montré que les décideurs étaient soumis à une pression croissante pour garantir que leurs décisions étaient fondées sur des preuves, ce qui impliquait de surmonter des obstacles majeurs, notamment le manque d'outils permettant de faire un choix technique parmi plusieurs options présentant un poids de preuve similaire. Il existe un intérêt croissant pour l'utilisation des

techniques d'aide à la décision dans la formulation des politiques de santé publique en tant que domaine d'étude et des preuves d'une augmentation significative du nombre d'articles sur le sujet étudié au cours de la période d'étude[43]. Deux conceptions de l'utilité des méthodes délibératives coexistent en matière de soutien à la prise de décision en santé publique. Des outils de gouvernance démocratique où la délibération favorise l'atteinte d'un consensus chez des parties prenantes concernées par une politique publique ou un enjeu de santé et les outils de synthèse pour comités d'experts ou groupes de travail à travers lequel la délibération permet de synthétiser de l'information provenant de connaissances complexes et de différentes natures pour élaborer des recommandations, ou des conclusions en soutien à la prise d'une décision [42].

En somme, une délibération favorise la concertation et le partage de connaissances, de valeurs, de préoccupations, de préférences et d'expériences sur un enjeu d'intérêt entre plusieurs acteurs de différents horizons. Ce croisement des savoirs permet l'atteinte d'un consensus et favorise une prise de décision plus juste et éclairée [42].

CONCLUSION

La présente étude avait pour objectif de mener une revue bibliométrique de la production scientifique du site ANRS/MIE Cameroun et rencontrer/échanger avec certains chercheurs et décideurs dont les projets de recherche ont été financés par l'ANRS ;

Le site ANRS/MIE Cameroun a produit de nombreuses connaissances, sur des thématiques et des domaines divers. Toutefois, on note que malgré cette production importante d'informations, celles-ci restent sous utilisées lors de l'élaboration des politiques publiques en santé au niveau national.

En guise d'explication, plusieurs défauts ont été relevés de la phase d'élaboration des projets de recherche à la phase de restitution des résultats. A cela s'ajoutaient une formation insuffisante des chercheurs à l'échelle nationale et une collaboration insuffisante entre chercheurs et décideurs à l'implémentation des recommandations issues de la recherche.

RECOMMANDATIONS

1. Au Ministère de la Santé publique

- S'assurer que les restitutions des travaux ayant reçu une autorisation éthique soient faites aux autorités administratives, à la communauté scientifique et aux personnes ayant participé à la recherche
- Mettre en place des réseaux d'échange entre chercheurs et décideurs

2. A l' ANRS|MIE Cameroun

- Exiger la restitution des résultats de chaque projet de recherche à travers des forums délibératifs
- Organiser des formations en courtage de connaissances

3. Aux institutions de recherche

- Proposer des formations en courtage aux chercheurs

4. Aux chercheurs

- Restituer obligatoirement les résultats de recherche

5. A la Faculté de médecine et des sciences biomédicales

- Promouvoir le courtage des connaissances auprès des enseignants et des étudiants

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

REFERENCES

1. African Union Development Agency (NEPAD). Stratégie 2018-2030 en matière de recherche et d'innovation dans le secteur de la santé en afrique (HRISA)-2018-2030. Midrand: NEPAD; 2019.

2. Mossus-Etounou T, Essi M-J, Isseini A, Souore-Sanda J, Pan'na-Elemzo SB, Boyomo-Assala LC, et al. Evolution des programmes nationaux de lutte contre l'infection à VIH et le Sida au Cameroun, de 2000 à 2015. Health Sci Dis. 2016; 17(1).

3. Uusküla A, Toompere K, Laisaar KT, Rosenthal M, Pürjer ML, Knellwolf A, et al. HIV research productivity and structural factors associated with HIV research output in European Union countries: A bibliometric analysis. BMJ Open. 2015; 5(2): 1-7.

4. Ornos EDB, Tantengco OAG. Research Trends, Gaps, and Prospects for Viral Hepatitis in Southeast Asia: A Bibliometric Analysis. Sci Technol Libr. 2022; 1-13.

5. ANRS/MIE. Agence de recherche ANRS (France Recherche Nord & Sud Sida-HIV Hépatites) [En ligne]. 2022 [Consulté le 7 mars 2022]. Consultable à l'URL: https://fundit.fr/fr/institutions/agence-recherche-anrs-france-recherche-nord-sud-sida-hiv-hepatites

6. Ministère de la Santé publique. ANRS-Cameroun-Un nouveau coordonnateur aux commandes [En ligne]. 2022 [Consulté le 7mars 2022]. Consultable à l'URL: https://www.minsante.cm/site/?q=en/node/3878

7. Sanz Valero J. Bibliometría: origen y evolución. Hosp a Domic. 2022; 6: 105–7.

8. Lemqeddem H, Barha M. Analyse bibliométrique sur l'ERP et la Performance. Rev Française d'Economie Gest. 2022; 3: 457–67.

9. Mossus T. Communication pour le développement (C4D) et changement de paradigmes dans la lutte contre le sida au Cameroun : analyse de l'impact bibliométrique en « evidence-based policy-making ». Hal sci. 2017.

10. Solagberu BA. Literature search in medical publications. West Afr J Med. 2002; 21: 329–31.

11. Pochet B. Méthodologie documentaire. Rechercher, consulter, rédiger à l'heure d'Internet. Bruxelles: De Boeck Université; 2005.

12. Organisation des Nations Unies pour le sida (ONUSIDA). Fiche d'information-Dernières statistiques sur l'état de l'épidémie de sida [En ligne]. 2022 [Consulté le 11 mars 2022]. Consultable à l'URL: https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet

13. Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS). Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH, le Sida et les IST 2018-2022. Yaoundé: CNLS; 2017.

14. Mawouma ARN, Djoulatou AH, Komnang EO, Kimessoukie EO. Facteurs associés à l'infection de l'hépatite B chez les femmes enceintes dans les formations sanitaires du district de santé de Mokolo/Région de l'Extrême-Nord Cameroun. Pan Afr Med J. 2022;

41: 61.

15. Carniel PE. Lutte contre les hépatites virales au Centre Pasteur du Cameroun. Communiqué de presse. Yaoundé; 2020 Juillet 28.

16. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Stratégie mondiale du secteur de la santé contre l'Hepatite virale 2016-2021. Genève: OMS; 2016.

17. Raoul H, Yazdanpanah Y. Répondre aux maladies infectieuses : un défi toujours renouvelé. Med sci. 2022 Avril; 38(4): 335–6.

18. World Health Organization (WHO). Ebola virus disease [En ligne]. 2022 [Consulté le 8 Octobre 2022]. Consultable à l'URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease Ebola virus disease

19. Ministère de la Santé et des Services sociaux. Maladie à virus Ebola (MVE) [En ligne]. 2022 [Consulté le 9 Octobre 2022]. Consultable à l'URL:https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/ebola/

20. WHO. Chikungunya [En ligne]. 2022 [Consulté le 9 Octobre 2022]. Consultable à l'URL: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya

21. WHO. Dengue et dengue sévère [En ligne]. 2022 [Consulté le 9 Octobre 2022]. Consultable à l'URL:https://www.who.int/fr/news-room/fact sheets/detail/dengue-and-severe-dengue

22. WHO. Zika epidemiology update [En ligne]. 2019 [Consulté le 9 Octobre 2022]. Consultable à l'URL: https://www.who.int/publications/m/item/zika-epidemiology-update

23. Shu Y, He H, Shi X, Lei Y; Li J. Coronavirus disease-2019 (Review). World Acad Sci J. 2021; 3: 1-7.

24. WHO. COVID-19 infos [En ligne]. 2020 [Consulté le 9 Octobre 2022]. Consultable à l'URL: //www.who.int/fr/news-room

25. WHO. Semaine du 05 au 11 juillet 2021 [En ligne]. 2021 [Consulté le 9 Octobre 2022]. Consultable à l'URL:https://covid19.who.int/

26. OMS, Union Africaine (UA). Bulletin d'information N° 129: sur la pandémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19). Yaoundé: OMS; 2022.

27. WHO. Principaux repères sur l'orthopoxvirose simienne [En ligne] . 2023 [Consulté le 3 Septembre 2023]. Consultable à l'URL: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox

28. WHO. Maladie à virus Marburg – Guinée équatoriale [En ligne]. 2023 [Consulté le 3 Septembre 2023]. Consultable à l'URL: https://www.who.int/fr/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON449

29. Sweileh WM. Bibliometric analysis of literature in AIDS-related stigma and discrimination. Transl Behav Med. 2019; 9: 617-28.

30. Kutyamukama AG, Mohammed A, Okello-Obura C. Bibliometric Analysis of HIV/AIDS Research Publication Trends in Uganda from 1982 to 2020. Syst Lit Rev Meta-Analysis J. 2022; 3: 9–19.

31. Contaret C, Césaire R, Drame M. Développement de la coopération sanitaire et de la recherche clinique en Martinique : un enjeu de santé publique pour la réduction des disparités dans la Caraïbe [Thèse de Doctorat]. Université des Antilles; 2021.

32. Ahmad T, Murad MA, Nasir S, Hui J, Musa TH, Baig M. Trends in hepatitis A research indexed in the Web of Science: a bibliometric analysis over the period from 1985 to 2019. Hum Vaccin Immunother. 2021; 17: 3221–9.

33. Ahmad T, Nasir S, Musa TH, Airyalat SA, Khan M, Hui J. Epidemiology, diagnosis, vaccines, and bibliometric analysis of the 100 top-cited studies on Hepatitis E virus. Hum Vaccin Immunother. 2020; 17: 857–71.

34. Kouakou S, Diakhate D. Etude bibliométrique des publications sénégalaises sur les maladies non transmissibles: libre accès vs accès payant. Inf Commun Sci. 2018; 1: 266–92.

35. Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. Le Transfert de Connaissances en promotion de la santé [En ligne]. 2021 [Consulté le 16 Octobre 2022]. Consultable à l'URL:https://www.promotion-sante-normandie.org/publications

36. Le Bihan E, Debré P, Migus A, Akiki V, Devos P. Analyse des limites du partenariat France–Afrique en recherche biomédicale à travers les données de la bibliométrie et des essais cliniques. Jour and B. 2023; 208(3) :326-37.

37. Jovic L, Lecordier D, Cartron E. Prédiction, temps long : les temporalités de la recherche et de la décision. Rech Soins Infirm. 2020; 142: 5–6.

38. Deprez M. Chercheur cherche sujets : la recherche sur le terrain, l'éthique et la scientificité. Hors serie. 2007; 1-12.

39. Vidal L. Rendre compte. La restitution comme lieu de refondation des sciences sociales en contexte de développement. Open Edi J. 2011; 51: 591–607.

40. Kacem M, Dhouib W, Bennasrallah C, Zemni I, Abroug H, Fredj MN et al. Expanded program of immunization in the Maghreb. Case study of Tunisia.Systematic review of the literature. Tun Med. 2018; 96: 10-11.

41. Dagenais C, Ridde V. La note de politique comme outil de transfert de connaissances: pour avoir un impact votre note doit d'abord être lue. HAL open sci. 2020.

42. Institut National de Santé publique du Quebec (INSPQ). La délibération pour soutenir la

prise de décision en santé publique. Quebec: INSPQ; Juillet 2024

43. Jervis-jalabe DS, Olivares-Cerpa FDJ, Jervis-Pinzon CA, Arteta-Olivares NX. Decision support techniques in public health policy formulation: bibliometric analysis. Epub ahead of print. 2023.

ANNEXES

Annexe 1 : Clairance éthique de la FMSB/UY1

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES BIOMÉDICALES
COMITÉ INSTITUTIONNEL D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
Tel/ fax : 22 31-05-86 22 311224
Email: decanatfmsb@hotmail.com

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
FACULTY OF MEDICINE AND BIOMEDICAL SCIENCES
INSTITUTIONAL ETHICAL REVIEW BOARD

Ref. : N° 0269 /UY1/FMSB/VDRC/DAASR/CSD

12 MAI 2023

CLAIRANCE ÉTHIQUE

Le COMITÉ INSTITUTIONNEL D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CIER) de la FMSB a examiné

La demande de la clairance éthique soumise par :

M.Mme : MINLO NYANGON Eliane Fernande **Matricule: 22E0028**

Travaillant sous la direction de :

- **Pr Essi Marie José**
- **Dr Varloteaux Marie**

Concernant le projet de recherche intitulé : **Analyse bibliométrique de la production scientifique d'un centre de recherche en Afrique : le site ANRS/MIE Cameroun**

Les principales observations sont les suivantes

Evaluation scientifique	
Evaluation de la convenance institutionnelle/valeur sociale	
Equilibre des risques et des bénéfices	
Respect du consentement libre et éclairé	
Respect de la vie privée et des renseignements personnels (confidentialité) :	
Respect de la justice dans le choix des sujets	
Respect des personnes vulnérables :	
Réduction des inconvénients/optimalisation des avantages	
Gestion des compensations financières des sujets	
Gestion des conflits d'intérêt impliquant le chercheur	

Pour toutes ces raisons, le **CIER** émet un avis **favorable** sous réserve des modifications recommandées dans la grille d'évaluation scientifique.

L'équipe de recherche est responsable du respect du protocole approuvé et ne devra pas y apporter d'amendement sans avis favorable du **CIER**. Elle devra collaborer avec le **CIER** lorsque nécessaire, pour le suivi de la mise en œuvre dudit protocole.

La clairance éthique peut être retirée en cas de non - respect de la réglementation ou des recommandations sus évoquées.

En foi de quoi la présente clairance éthique est délivrée pour servir et valoir ce que de droit

LE PRESIDENT DU COMITE ETHIQUE

UNIVERSITE DE YAOUNDE I • FACULTE DE MEDECINE ET DES SCIENCES BIOMEDICALES

PROFESSEUR

A. Obama

Scanned with CamScanner

Annexe 2 : Autorisation de collecte des données du site ANRS/MIE Cameroun

Site ANRS Cameroun | anrs

N/Réf : 619 /L/SAMC/23/ressoe

Yaoundé, le 22 MARS 2023

Coordination

Coordonnateur Nord :
Pr. Eric DELAPORTE

Coordonnateur Sud :
Pr. Anne Cécile ZOUNG-KANYI BISSEK

Expert Technique International
Dr Marie VARLOTEAUX

Centre de coordination
Hôpital Central de Yaoundé
BP 16 237, Yaoundé – CAMEROUN

Téléphone : (+237) 655 23 44 70

E-mail : anrscameroun@yahoo.fr

Site web: www.anrs-cameroun.org

AUTORISATION DE RECHERCHE

Je soussignée, Coordonnateur Sud du Site ANRS|MIE-Cameroun, autorise Madame MINLO NYANGON Eliane Fernande, Médecin Résident en Santé Publique, inscrite en Master à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I, sous le matricule 22E0028, à effectuer un travail de recherche au Site ANRS|MIE-Cameroun dans le cadre de son mémoire intitulé « Analyse bibliométrique de la production scientifique d'un centre de recherche en Afrique : le Site ANRS | MIE-Cameroun ».

Ce travail est dirigé par Pr ESSI Marie-Josée et Dr VARLOTEAUX Marie.

SITE ANRS | MIE-CAMEROUN * LE COORDONNATEUR SUD * REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Pr. Anne Cécile Zoung-Kanyi Bissek

NIU : M010500046153K

Scanned with CamScanner

Annexe 3 : Note d'information

Titre : Analyse bibliométrique de la production scientifique d'un centre de recherche en Afrique : le site ANRS/MIE Cameroun

- **Investigateur principal :** MINLO NYANGON Eliane Fernande, MD, SP2 Santé Publique
- **Directeur :** Pr ESSI Marie-José, *PhD*, Anthropologie Médicale
- **Co-directeur :** Dr VARLOTEAUX Marie, *PhD,* Santé Publique, Chercheur site ANRS-MIE Cameroun
- **But de l'étude**

Au travers d'une analyse bibliométrique de la production scientifique du site ANRS/MIE Cameroun et d'entretiens avec des chercheurs et décideurs, il est question d'évaluer l'impact de la recherche sur les politiques publiques en santé au niveau national.

- **Justification**

Les maladies infectieuses émergeantes ou ré-émergeantes se manifestent de façon périodique, et une partie d'entre elles est la cause d'épidémies ou de pandémies pouvant décimer des populations. Elles constituent un problème majeur de santé publique d'où l'importance de mener cette étude afin d'améliorer l'accès aux connaissances disponibles et l'usage de celles-ci par les décideurs. L'intérêt de ce travail réside non seulement dans l'évaluation de la recherche en termes de publications scientifiques, mais aussi et surtout, contribue au processus décisionnel pour l'amélioration des conditions de vie des populations. En promotion de santé, l'élaboration des politiques publiques saines inscrit la santé à l'ordre du jour des responsables politiques. Ainsi donc, la prise de décision fondée sur des données probantes en santé publique se fait sur la base de données pertinentes et disponibles issues de la recherche.

- **Procédure**

Il s'agit de mener une étude mixte (analyse bibliométrique et analyse qualitative). Notre population est constituée de publications scientifiques du site ANRS/MIE Cameroun, de décideurs institutionnels et de chercheurs. Les publications scientifiques sont identifiées grâce à une recherche sur internet à travers des bases de données qui vont servir à constituer le corpus de références bibliographiques à analyser, et leur exploitation ne se limitera qu'au cadre de la recherche. Par ailleurs, un entretien est conduit avec les personnes cibles sollicitées. Après de brèves explications, celles qui accepteront de participer recevront des explications détaillées sur l'étude et sur les modalités de leur participation. Après signature du formulaire de consentement éclairé, l'entretien se fera, soit directement, soit sur rendez-vous. Les entretiens

seront conduits dans des lieux garantissant la confidentialité et seront enregistrés sur dictaphone, en respectant l'anonymat.

- **Avantages**

Cette étude pourra améliorer le processus décisionnel des politiques publiques en santé.

- **Inconvénients**

Cette étude ne présente pas de risques potentiels pour les participants.

- **Confidentialité**

Les informations seront confidentielles et utilisées pour notre étude et seulement à cet effet.

- **Clairance éthique**

Une clairance éthique (N° 0269 du 12 mai 2023) a été obtenue du comité d'éthique de la faculté de médecine et des Sciences biomédicales de Yaoundé. De même une autorisation de recherche (N° 619 du 22 mars 2023) préalable a été obtenue de la coordonnatrice Sud du site ANRS-MIE Cameroun. Nous déclarons que la participation est volontaire et que le refus n'entraine aucune conséquence ou perte d'avantages auxquels le participant a droit ; et que le participant peut suspendre à tout moment sa participation à l'étude sans que cela puisse lui poser un préjudice quelconque.

- **Personnes à contacter**

Minlo Nyangon Eliane Fernande, MD, SP2 Santé publique. Tel : 695 02 02 33. Email : elianeminlo27@gmail.com

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Annexe 4 : Formulaire de consentement éclairé

<u>TITRE :</u> ANALYSE BIBLIOMETRIQUE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE D'UN CENTRE DE RECHERCHE EN AFRIQUE : LE SITE ANRS/MIE CAMEROUN

Investigateur principal : MINLO NYANGON Eliane Fernande, MD, SP2 Santé publique

Directeur :

- Pr ESSI Marie-José, *PhD*, Anthropologie Médicale

Co-directeur :

- Dr VARLOTEAUX Marie, *PhD,* Santé Publique, Chercheur site ANRS-MIE Cameroun

Je soussigné M./Mme/Mlle : …… :

Il m'a été proposé de participer à cette étude dans le cadre des travaux de recherche de Master en Santé Publique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB)-Université de Yaoundé I. Je confirme avoir lu, compris la fiche d'information et j'ai eu l'opportunité d'en discuter avec l'investigateur.

J'affirme avoir compris les objectifs, les étapes, et les bénéfices de l'étude.

Je donne mon accord pour participer à cette étude qui devra conserver dans l'anonymat les informations personnelles et résultats obtenus dans les règles de l'éthique.

Yaoundé, le ____/____/20___

Signature du participant **Signature de l'investigateur**

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Annexe 5 : Guide d'entretien

Collecte de données rentrant dans le cadre des travaux de recherche de Master en Santé Publique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) - Université de Yaoundé I.

Thème : Analyse bibliométrique de la production scientifique d'un centre de recherche en Afrique : le site ANRS/MIE Cameroun

Par : MINLO NYANGON Eliane Fernande, MD, SP2 Santé Publique

Téléphone : 695 02 02 33 Email : eliane.minlo@fmsb-uy1.cm

À l'attention des décideurs :

1. Présentation de l'interlocuteur : structure et poste occupé
2. Quel est l'intérêt de la recherche pour vous en tant que décideurs ?
3. Lisez-vous des revues ou articles scientifiques ?
4. Participez-vous à des conférences nationales ou internationales ? Si Oui, la plus récente ?
5. Sur quoi vous appuyez-vous pour changer les recommandations nationales ?
6. Participez-vous aux restitutions des résultats de recherche ici au Cameroun ?
7. Pensez-vous que le format des restitutions est adapté pour vous ? Si non, avez-vous des propositions sur le type de formats ?
8. Avez-vous des suggestions pour ces restitutions ?
9. Avez-vous déjà entendu parler du courtage des connaissances ? Si oui, utilisez-vous le courtage des connaissances ? Pouvez-vous donner des exemples ?

Je vous remercie.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Collecte de données rentrant dans le cadre des travaux de recherche de Master en Santé Publique à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) - Université de Yaoundé I.

Thème : Analyse bibliométrique de la production scientifique d'un centre de recherche en Afrique : le site ANRS/MIE Cameroun

Par : MINLO NYANGON Eliane Fernande, MD, SP2 Santé Publique

Téléphone : 695 02 02 33 Email : eliane.minlo@fmsb-uy1.cm

À l'attention des chercheurs :

1. Présentation de l'interlocuteur : structure/ domaine d'intervention/ affiliations
   -Depuis combien de temps faites-vous de la recherche ?

   -Quels sont vos projets de recherche les plus récents ?
2. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la mise en œuvre de vos projets de recherche ? (Décrire ces difficultés, donner des exemples).
3. Valorisez-vous les résultats de vos recherches ? Si oui, comment le faites-vous (Rapports, réunions…etc.) ?
4. Avez-vous des suggestions pour améliorer ces restitutions ?
5. Dans la rédaction de vos protocoles de recherche, la restitution est-elle budgétisée ?
6. Avez-vous déjà entendu parler du courtage de connaissances ? Si oui, donnez des exemples.
7. A votre avis la restitution des résultats fait-elle partie de l'éthique de la recherche ?

Je vous remercie.

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Annexe 6 : Projets du site ANRS/MIE Cameroun

ANNEE	Numéro ANRS	NOM DE L'ETUDE	Investigateurs Coordonnateurs Nord et Sud	PAYS	TYPE D'ETUDE
2005	ANRS 12116 EVAL	Évaluation du programme camerounais d'accès aux ARV : impact sur la prise en charge et les conditions de vie de la population infectée par le VIH	Jean-Paul MOATTI Séverin Cécile ABEGA	Cameroun	Évaluation multidisciplinaire de programmes d'intervention et de prévention VIH
2005	ANRS 12114	Mesure et ajustements des estimations des prévalences nationales du VIH en Afrique Sub-Saharienne	Benoît FERRY Nicolas MEDA	Burkina Faso Cameroun Sénégal	Modélisation VIH
2005	ANRS 12110 STRATALL	Décentralisation de l'accès au traitement antirétroviral en Afrique : étude coût-efficacité de la prise en charge des patients sous antirétroviraux selon une approche de suivi allégé dans des hôpitaux de district	Jean-Paul MOATTI Charles KOUANFACK	Cameroun	évaluation multidisciplinaire de programmes d'intervention et de prévention
2005	ANRS 12110 STRATALL	Décentralisation de l'accès au traitement antirétroviral en Afrique : évaluation clinique de la prise en charge des patients sous antirétroviraux dans des hôpitaux de district selon une approche de suivi allégé	Christian LAURENT Charles KOUANFACK	Cameroun	Evaluation d'intervention thérapeutique VIH
2005	ANRS 12115 DAYANA	Evaluation des nouveaux traitements antirétroviraux chez des patients sénégalais et camerounais non traités auparavant	Roland LANDMAN Papa Salif SOW	Cameroun Sénégal	Essai clinique VIH
2006	ANRS 12125	Identifier et caractériser les virus de l'immunodéficience simienne (SIV) circulants chez les primates non-humains au Cameroun et évaluer de potentielles nouvelles transmissions inter-espèces de SIV du	Martine PEETERS Cheik MPOUDI-NGOLE	Cameroun	Étude fondamentale VIH

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

		singe à l'homme au Cameroun			
2006	ANRS 12120 POLART	La problématique de l'accès aux médicaments contre le sida au Cameroun. Enjeux, avancées, limites et perspectives de la décentralisation d'une offre de soins	Fred EBOKO Luc SINDJOUN	Cameroun	Evaluation multidisciplinaire de programmes d'intervention et de prévention VIH
2006	ANRS 12144 B37	"Épuisement professionnel" et prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida au Cameroun	Josiane TANTCHOU YAKAM	Cameroun	Étude de sciences sociales et santé publique VIH/TB
2006	*ANRS 12127* PENAHTEST	L'impact en santé publique d'une intervention de conseil prénatal du VIH orienté vers le couple dans les pays à faible et moyenne prévalence du VIH	François DABIS Patrice TCHENDJOU	Cameroun Géorgie Inde République Dominicaine	Evaluation d'interventions en santé publique VIH
2006	ANRS 12134 RESPRIM	Évaluation de la fréquence du virus VIH-1 résistant aux antirétroviraux chez des patients naïfs de traitement au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal	Martine PEETERS Et le groupe Résistance AC12	Burkina Faso Cambodge Cameroun Côte d'Ivoire Sénégal Thaïlande Vietnam	Épidémiologie moléculaire descriptive VIH
2006	ANRS 12140 PEDIACAM	Impact des associations d'antirétroviraux et du Programme élargi de vaccination (PEV) sur l'évolution et la gestion des nourrissons infectés par le VIH-1 au Cameroun	Albert FAYE Mathurin Cyrille TEJIOKEM	Cameroun	Étude clinique VIH
2007	ANRS 12172	Les discours institutionnels sur la prévention du SIDA et leur impact sur la population cible Nord Cameroun	Henry TOURNEUX Léonie METANGMO-TATOU	Cameroun	Étude de sciences sociales et santé publique VIH
2007	ANRS 12155	Les prises en charges croisées du VIH et de la tuberculose au Cameroun et au Sénégal : processus	Laurent VIDAL Christopher KUABAN	Cameroun Sénégal	Étude de sciences sociales et santé publique VIH

		historiques et contraintes sociales			
2007	ANRS 12168 DYNAMO	Diversité moléculaire des souches du groupe O VIH-1 et gestion thérapeutique au Cameroun.	Jean-Christophe PLANTIER Charles KOUANFACK	Cameroun	Essai clinique VIH
2007	ANRS 12169 2-LADY	Suivi des patients participant à l'étude de phase III multicentrique, randomisée, ouverte, non infériorité comparant la réponse virologique (ARN plasmatique du VIH <50 copies / ml) à 48 semaines de trois schémas thérapeutiques antirétroviraux chez des patients infectés par le VIH-1 échec thérapeutique après traitement antirétroviral de première ligne au Cameroun, au Sénégal et au Burkina Faso.	Éric DELAPORTE Sinata KOULLA SHIRO	Burkina Faso Cameroun Sénégal	Essai clinique VIH
2008	ANRS 12182	Identifier et caractériser les SIV circulants chez les grands singes (chimpanzés et gorilles) et évaluer de potentielles nouvelles transmissions inter-espèces de SIVcpz et SIVgor à l'homme en Afrique Centrale	Martine PEETERS Cheik MPOUDI-NGOLE	Cameroun	Étude fondamentale VIH
2008	ANRS 12194 CI	Diagnostic de la tuberculose chez l'enfant infecté par le VIH. Étude de faisabilité d'une étude multicentrique (Afrique Asie) au Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Vietnam. Mise en place d'un réseau de cliniciens, choix des méthodes diagnostiques, évaluation des capacités de recrutement, qualité des laboratoires	Stéphane BLANCHE Olivier MARCY	Burkina Faso Cambodge Cameroun Vietnam	Étude diagnostique VIH

2008	ANRS 12108	Passage à l'échelle et approvisionnement en médicaments et outils de suivi biologique. Le cas du Cameroun et du Brésil : analyse et enseignement pour d'autres pays	Benjamin CORIAT Marie-José ESSI	Brésil Cameroun	Evaluation multidisciplinaire de programmes d'intervention et de prévention VIH
2008	ANRS 12185 B46	Trajectoires homosexuelles et migration trans-nationale au temps du Sida: configuration des risques du Cameroun à la France	Simon Patrick AWONDO	Cameroun	Étude de sciences sociales et santé publique VIH
2008	ANRS 12196 CI	Approches historiques et anthropologiques de la sécurité transfusionnelle en Afrique. Dons, (més) usages médicaux, politiques publiques et formes d'organisation au Cameroun et en Ouganda	Guillaume LACHENAL Dora MBANYA	Cameroun Ouganda	Étude de sciences sociales et santé publique VIH
2008	ANRS 12189	Recherche-action pour la prévention du VIH-SIDA à Madagascar, au Burkina Faso et au Cameroun: étude de l'impact en population du programme MFPF "réduction des risques sexuels en direction des femmes" basé sur la formation de formateurs, l'abord global de la sexualité et une approche de santé communautaire	François FAVIER Abdramane BERTHE	Burkina Faso Cameroun Madagascar	Étude de sciences sociales et santé publique VIH
2008	ANRS 12177	Étude socio anthropologique du suivi des nourrissons infectés par le VIH-1, sous traitement antirétroviral précoce au Cameroun	Fred EBOKO Claude ABE	Cameroun	Étude de sciences sociales et santé publique VIH

2008	ANRS 12186	Résultats virologiques et résistance aux médicaments chez les patients recevant un traitement antirétroviral dans le cadre de programmes nationaux de traitements antirétroviraux au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Thaïlande, au Togo et au Vietnam.	Ahidjo AYOUBA Avelin AGHOKENG FOBANG	Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Sénégal Vietnam Thaïlande Togo Vietnam	Épidémiologie moléculaire descriptive VIH
2009	ANRS 12207	Analyse de la réponse cellulaire au vaccin rougeole chez les nouveau-nés infectés par le VIH	Michèle FEVRIER Anfumbom Jude KFUTWAH	Cameroun	Étude fondamentale VIH
2009	ANRS 12217 VEDIAG CI	Co-infection à VIH-1 et à CMV chez des enfants de moins de 18 mois, nés de mères VIH positive au Cambodge, Vietnam, Cameroun et République Centrafricaine : Faisabilité du codiagnostic sur Dried Blood Spot (DBS) et développements possibles	Marianne LERUEZ-VILLE Éric NERRIENET	Cambodge Cameroun République centrafricaine Vietnam	Étude diagnostique VIH
2009	ANRS 12155 B51	L'observance à l'heure de la thérapie conjointe ARV/antituberculeux au Cameroun. Anthropologie d'un nouvel enjeu de santé publique	Josiane Elvire MBALLA	Cameroun	Étude de sciences sociales et santé publique VIH
2010	ANRS 12222	Analyses poolées des incidences spécifiques de morbidité/mortalité par niveau de CD4 chez les personnes infectées par le VIH dans les pays à ressources limitées	Charlotte LEWDEN Xavier ANGLARET Et le Morbidity/Mortality study group	Bénin Burkina Faso Cambodge Cameroun Côte d'Ivoire Laos Sénégal	Epidémiologie clinique VIH

2010	ANRS 12235	Le sang total séché sur papier filtre, DBS (dried blood spot), est-il utilisable pour le suivi virologique en routine des patients VIH+ traités et suivis dans les programmes nationaux : étude multicentrique en Afrique en Asie du Sud-Est.	Ahidjo AYOUBA Avelin AGHOKENG FOBANG	Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Sénégal Thaïlande Togo Vietnam	Etude diagnotique VIH
2010	ANRS 12233 CI	Evaluation du programme camerounais d'accés aux ARV et prise en charge de la coinfection VIH/TB	Laurent VIDAL Christopher KUABAN	Cameroun	Etude de sciences sociales et santé publique VIH/TB
2010	ANRS 12127 PENAHTEST (suite)	L'impact en santé publique d'une intervention de conseil prénatal du VIH orienté vers le couple dans les pays à faible et moyenne prévalence du VIH	François DABIS Patrice TCHENDJOU	Cameroun Géorgie Inde République Dominicaine	Evaluation d'interventions en santé publique VIH
2010	ANRS 12225 PEDICAM II	Devenir à 5 ans des enfants infectés par le VIH traités précocement par HAART au Cameroun dans le cadre du projet Pediacam ANRS 12140 (Pediacam II)	Albert FAYE Mathurin Cyrille TEJIOKEM	Cameroun	Suivi long terme post essai clinique
2010	ANRS 12229 PAANTHER01	Amélioration du diagnostic de la tuberculose chez les enfants infectés par le VIH en Asie (Cambodge, Vietnam) et en Afrique (Burkina Faso, Cameroun) PAANTHER 01 (Réseau pédiatrique afro-africain de recherche sur la tuberculose et le VIH).	Olivier MARCY Vibol UNG	Burkina Faso Cambodge Cameroun Vietnam	Etude diagnostique VIH/Tuberculose
2010	ANRS 12231 2LADY-SHS	Evaluation médico-économique de trois stratégies de traitement antirétroviral de 2éme Ligne en Afrique : projet associé à l'essai clinique 2LADY (ANRS 12169)	Bruno SPIRE Papa Salif SOW	Burkina Faso Cameroun Sénégal	Economie de la santé

2011	ANRS 12255	Identification et prévalences des SIVs chez les primates non-humains sauvages afin d'estimer les risques de nouvelles transmissions inter-espèces et d'étudier plus en détails les réservoirs des ancêtres du HIV-1 chez les grands singes en Afrique Centrale	Martine PEETERS Cheik MPOUDI-NGOLE	Cameroun Gabon RDC	Etude fondamentale VIH
2011	ANRS 12110 STRATALL B61	Impact des traitements ARV sur la prévention du VIH en Afrique subsaharienne : le cas du Cameroun	Gilbert NDZIESSI	Cameroun	Etude de sciences sociales et santé publique VIH
2011	ANRS 12251 CI	Gouvernance et sida en Afrique : accès universel, différentiels nationaux. Limites, obstacles et perspectives	Fred EBOKO Maurice ENGUELEGUELE	Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Sénégal	Etude de sciences sociales et santé publique VIH
2011	ANRS 12266 B63	Les CCM et le Fonds mondial. Appropriation et fonctionnements d'un instrument de la gouvernance internationale du sida (Cameroun, Sénégal)	Elise DEMANGE	Cameroun Sénégal	Etude de sciences sociales et santé publique VIH
2011	ANRS 12264 CI	L'accès à la charge virale VIH dans les contextes de ressources limitées : analyse du marché et des politiques d'acquisition dans 3 pays (Brésil, Cameroun)	Benjamin CORIAT	Brésil Cameroun	Economie de la santé VIH
2011	ANRS 12250 METABODY	Evaluation de la lipodystrophie et des troubles métaboliques chez des patients sous traitement antirétroviral de deuxième intention en Afrique (Bobo Dioulasso, Dakar Yaoundé): étude associée à l'essai clinique 2LADY (ANRS 12169).	Laura CIAFFI Assane DIOUF	Burkina Faso Cameroun Sénégal	Etude diagnostique VIH
2011	ANRS 12256 RECAMO	Caractérisation virologique des doubles infections VIH-1 M+O et des formes recombinantes	Jean-Christophe PLANTIER Anfumbom Jude KFUTWAH	Cameroun	Epidémiologie moléculaire descriptive VIH

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

		VIH-1 M/O associées ou non à une double infection, circulant au Cameroun.			
2012	ANRS 12169 B67	Observance aux antirétroviraux en Afrique subsaharienne, l'expérience Camerounaise	Mégane MERESSE	Cameroun	Etude de sciences sociales et santé publique VIH
2012	ANRS 12275 ACTA	Essai de phase III randomisé et contrôlé sur la méningite à cryptocoque associée au VIH: fluconazole oral / flucytosine ou traitement à base d'amphotéricine B d'une semaine vs traitement à base d'amphotéricine b de deux semaines.	Thomas S HARRISON Olivier LORTHOLARY Charles KOUANFACK	Cameroun Malawi Zambie	Essai clinique VIH/Cryptococose
2013	ANRS 12275 B72	Epidémiologie et prise en charge optimale de la méningite à cryptococcus néoformans associée au sida au Cameroun	Elvis TEMFACK	Cameroun	Epdémiologie clinique VIH
2013	ANRS 12298 OPTIMOSWITCH	Un essai randomisé de stratégie évaluant la place de la charge virale en fonction de l'observance et de la surveillance immuno-clinique pour la prise en charge précoce de l'échec virologique dans un contexte de ressources limitéeS	Pierre DE BEAUDRAP Charles KOUANFACK	Cameroun Ouganda RDC	Etude clinique VIH
2013	ANRS 12302 HANDIVIH	Handicap et VIH : un état des lieux sur la vulnérabilité des personnes handicapées à l'infection par le VIH dans deux capitales d'Afrique sub-saharienne	Pierre DE BEAUDRAP Gervais BENINGUISSE	Cameroun	Etude de sciences sociales et santé publique VIH
2013	ANRS 12309 B76	Comparaison de 2 méthodes d'estimation de l'incidence de l'infection de l'infection par le VIH en Afrique subsaharienne	Jacques Deval NDAWINZ	Cameroun	Modélisation VIH

2013	ANRS 12289	Epidémiologie des hépatites virales B, C, et delta au Cameroun : analyse des échantillons de l'Enquête Démographique de Santé 2011	Arnaud FONTANET Richard NJOUOM	Cameroun	Epidémiologie moléculaire descriptive hépatite
2013	ANRS 12303 TOK	Étude observationnelle de l'efficacité de la vaccination contre l'hépatite B (HB) chez les enfants nés de mère AgHBs positives commencée dès la naissance et suivie du programme élargi de vaccination comprenant la valence PEV-HB, dans le district de Tokombéré, Cameroun.	Françoise LUNEL-FABIANI Richard NJOUOM	Cameroun	Etude de prévention hépatite
2013	ANRS 12286 MOBIDIP	Evaluation d'une stratégie de maintenance d'inhibiteurs de la protéase avec ou sans lamivudine chez des patients ayant une charge virale contrôlée sous deuxième ligne d'antirétroviraux en Afrique (Yaoundé, Bobo Dioulasso, Dakar)	Laura CIAFFI Sinata KOULLA SHIRO	Burkina Faso Cameroun Sénégal	Essai clinique VIH
2013	ANRS 12288 EVOLCAM	Analyse de l'évolution du programme d'accès aux ARV du Cameroun dans les régions du Centre et du Littoral face aux défis actuels en matière de gestion du VIH et des principales co-infections	Laurent VIDAL Christopher KUABAN	Cameroun	Etude de sciences sociales et santé publique VIH
2013	ANRS 12301 VIH-2 VIRO	Diagnostic moléculaire des infections mono-VIH-2 et des infections doubles VIH-1 + 2 en Afrique de l'Ouest.	Jean-Christophe PLANTIER Thomas d'Aquin TONI	Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Mali Sénégal Togo	Etude diagnostique VIH
2014	ANRS 12325	SIV à l'interface entre les humains et les primates non humains (PNH) et	Martine PEETERS Cheik MPOUDI-NGOLE	Cameroun RDC	Etude fondamentale VIH

		impact de l'infection SIV sur la santé et la survie des grands singes infectés par les ancêtres simiens du VIH-1			
2014	ANRS 12319 OPP-ERA	Open Polyvalent Platform for sustainaible access to quality and affordable viral load testing in resource limited settings	Christine Rouzioux	Burundi Cameroun Côted'Ivoire Guinée	Etude diagnostique VIH
2014	ANRS 12322 PEDIACAM-DEV	Evaluation transversale du développement des enfants âgés de 4 à 7 ans infectés ou exposés à l'infection par le VIH de la cohorte ANRS 12140	Albert FAYE Mathurin Cyrille TEJIOKEM	Cameroun	Etude neurologique VIH
2014	ANRS 12315	Gouvernance et sida en Afrique : comprendre et renforcer l'action concertée des instances de coordination nationale (CCM). Une approche comparée Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun	Fred EBOKO Maurice ENGUELEGUELE	Cameroun Côte d'Ivoire Sénégal	Etude de sciences sociales et santé publique VIH
2014	ANRS 12327 Viro HBV	Validation d'un test moléculaire automatisé de faible coût pour le suivi de l'infection par le virus de l'hépatite B en Afrique et en Asie du Sud-Est	Edouard TUAILLON Dramane KANIA	Burkina Faso Cambodge Cameroun Côte d'Ivoire Mali Mauritanie Sénégal Thailande Togo Vietnam	Etude diagnostique hépatite
2014	ANRS 12311 TAC	Faisabilité, tolérance et efficacité d'un traitement antiviral sans interféron associant sofosbuvir, ribavirine dans le traitement de l'hépatite C chronique de génotype 2 et sofosbuvir, ledipasvir dans le traitement de l'hépatite C chronique de génotype 1 et 4 en Afrique Centrale et de l'Ouest.	Karine LACOMBE Alain ATTIA	Cameroun Côte d'Ivoire Sénégal	Essai clinique hépatite

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

2014	ANRS 12312 PreCASA	« Pre-Antiretroviral therapy (ART) Cryptococcal Antigen Screening in AIDS (PreCASA) » : Implémentation et évaluation du dépistage de l'antigène du cryptocoque comme stratégie visant à diminuer la morbi-mortalité de la cryptococcose neuromeningée chez des patients infectés par le VIH débutant le traitement antirétroviral à moins de 100 CD4 à l'Hôpital du Jour de l'Hôpital Central de Yaoundé, Cameroun.	Olivier LORTHOLARY Elvis TEMFACK	Cameroun	Etude diagnostique VIH/Cryptococcose
2014	ANRS 12313 NAMSAL	Essai de phase III multicentrique randomisé, ouvert, visant à évaluer le dolutégravir versus 400 mg d'éfavirenz, tous deux associés à Fumarate + Emtricitabine + ténofovir disoproxil ou à la lamivudine pour la prise en charge initiale d'adultes infectés par le VIH dans des environnements dotés de ressources limitées	Eric DELAPORTE Charles KOUANFACK	Cameroun	Essai clinique VIH
2014	ANRS 12333 Viro Résistance	Etude de la résistance du VIH aux antirétroviraux chez les personnes initiant un premier traitement antirétroviral au Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Togo, Thaïlande et Vietnam.	Avelin AGHOKENG FOBANG	Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Mali Sénégal Togo Thaïlande Vietnam	Etude transversale sur la résistance VIH
2015	ANRS 12346 AIMA CI	VIH et cancer dans les pays à ressources limitées : état des lieux et faisabilité d'un projet de suivi prospectif des cancers chez les personnes vivant avec le VIH	Pierre DE BEAUDRAP Pierre-Marie TEBEU	Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire	Epidémiologie descriptive VIH

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

2015	ANRS 12336 AgCore VHC TAC	Evaluation de la performance de l'Antigène core du VHC comme marqueur diagnostique et de suivi sous traitement par antiviraux directs de l'hépatite C chronique	Karine LACOMBE Richard NJOUOM	Cameroun	Etude diagnostique hépatite
2015	ANRS 12342 Eco-TAC	Evaluation économique du traitement de l'hépatite C au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal - Etude associée à l'essai clinique ANRS 12311 TAC	Sylvie BOYER	Cameroun Côte d'Ivoire Sénégal	Economie de la santé hépatite
2016	ANRS 12302 B93	Handicap et Risques sexuels et reproductifs à Yaoundé : une approche par les parcours de vie	Charles Emmanuel MOUTE NYOKON	Cameroun	Etude de sciences sociales et santé publique VIH
2016	ANRS 12350 MOVIHCAM	Risque et prévention du VIH chez les conducteurs de moto-taxi au Cameroun : une étude transversale intégrée	Pierre DE BEAUDRAP Gervais BENINGUISSE	Cameroun	Etude de sciences sociales et santé publique VIH
2016	ANRS 12362 DREAMM	Optimisation de la prise en charge des infections du système nerveux central chez les patients infectés par le VIH hospitalisés en Afrique sub-saharienne	Olivier LORTHOLARY Charles KOUANFACK	Cameroun Tanzanie Malawi	Evaluation d'intervention thérapeutique VIH/Cryptococcose
2017	ANRS 12367 MOTYCCIC	Corrélation de la diversité moléculaire de Cryptococcus spp avec les déterminants clinico-biologiques de gravité et d'évolution des patients infectés par le VIH atteint de cryptococcose neuromeningée au Cameroun.	Olivier LORTHOLARY Elvis TEMFACK	Cameroun	Epidémiologie clinique VIH/Cryptococcose
2017	ANRS 12375 AIMA-CC	Evaluation d'algorithmes de dépistage basés sur le test Genexpert HPV pour la prévention du cancer du col chez les femmes infectées par le VIH dans les pays à ressources limitées (AIMA-CC)	Pierre DE BEAUDRAP Apollinaire HORO	Burkina Faso Cambodge Cameroun Côte d'Ivoire	Evaluation multidisciplinaire de programmes d'intervention et de prévention VIH/HPV

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

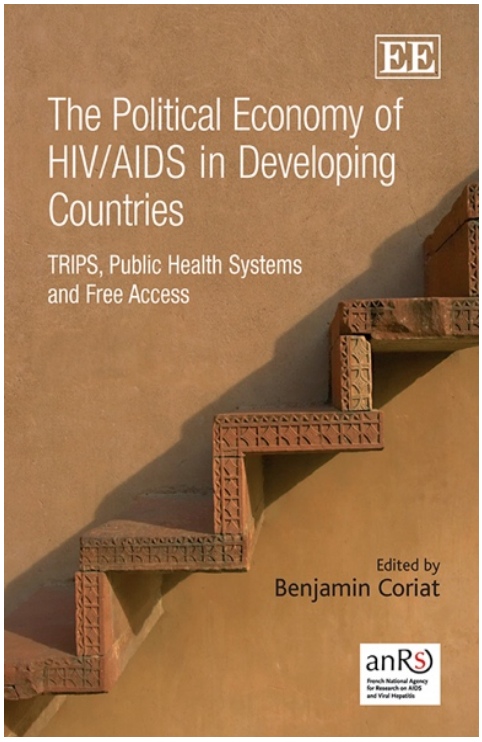
2017	ANRS 12366	Le virus de l'hépatite Delta : validation et implantation en Afrique Centrale d'une technique générique de quantification de la charge virale ARN et données de prévalence.	Emmanuel GORDIEN Richard NJOUOM	Cameroun RDC	Etude fondamentale hépatite
2017	ANRS 12379 TROD	Evaluation des performances des tests de diagnostic rapides pour la détection des anticorps anti-VHC et de l'AghBs	Stéphane CHEVALIEZ Richard NJOUOM	Cameroun France	Etude diagnotique hépatite
2017	ANRS 12225 PEDICAM III	Devenir à long terme des enfants infectés par le VIH traités précocement par les multithérapies antirétrovirales et des enfants exposés au VIH non infectés au Cameroun	Albert FAYE Mathurin Cyrille TEJIOKEM	Cameroun	Cohorte
2017	ANRS 12372 MODERATO	Essai clinique randomisé de non infériorité comparant une bithérapie de maintenance par dolutegravir + lamivudine (DTG+3TC) ou atazanavir/ritonavir + lamivudine (ATV/r+3TC) à la trithérapie de référence OMS par ténofovir + lamivudine + efavirenz (TDF+3TC+EFV) en Afrique de l'ouest et centrale	Roland LANDMAN Serge EHOLIE	Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Sénégal	Essai clinique VIH
2018	ANRS 12169 B98	Analyse épidémio-génétique des complications rénales et cardio-métaboliques chez les personnes d'Afrique sub-Saharienne vivant avec le VIH - Cohorte 2LADY (ANRS 12169) (Cameroun, Burkina Faso, Sénégal) et Cohorte HDJ Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).	Firmin KABORE	Burkina Faso Cameroun Sénégal	Epidémiologie clinique VIH

2018	ANRS 12386 CI	Vieillir avec le VIH au Cameroun et au Sénégal: aspects médicaux et anthropologiques	Laura CIAFFI Sinata KOULLA SHIRO	Cameroun Sénégal	Epidémiologie descriptive VIH
2019	ANRS 1242 IMMU-HEU	Impact de l'exposition in utero au VIH/ARV sur le dysfonctionnement immunitaire et susceptibilité aux infections durant la première année de vie chez les enfants exposés, non infectés au VIH: l'étude IMMU-HEU nichée dans la cohorte PREVENT-IT	Valériane LEROY Gabriel LONI EKALI	Cameroun	Epidémiologie clinique VIH
2019	ANRS 12406 EvvA CI	Echec Virologique et Pharmacorésistance du VIH chez les Adolescents sous Traitement ARV au Cameroun	Avelin AGHOKENG FOBANG Ida Calixte PENDA	Cameroun	Etude résistance virologique VIH
2019	ANRS 12408 B103	Minorités sexuelles et de genre face au VIH/sida au Cameroun : vers une autonomie des transgenres ?	Brenda Masanga NGUM	Cameroun	Etude de sciences sociales et santé publique VIH
2020	ANRS 12411	Expliquer la complexité de l'épidémie à VIH 1 groupe M dans le bassin Congo : région où plusieurs lignées virales co-circulent	Martine Peeters et Aplha Keita	Cameroun et RDC	Etude virologique
2020	ANRS 12414	la sérologie négative par le test immunoenzymatiques (EIA) chez les enfants infectés par le VIH traités précocement par les ARV dans l'étude PEDIACAM : Mécanismes physiopathologiques	Mathurin Tejiokem	Cameroun	
2020	ANRS 12416	une étude interventionnelle de l'efficacité du TDF, chez les femmes enceintes infectés par l'hépatite B avec une charge virale élevée, associé au vaccin à la naissance, sur la transmission Mère-Enfant	Pr. Françoise lunel-fabiani M JP adoukara	Cameroun	

		du VHB à Tokombéré au Cameroun.		
2020	ANRSCOV02	ANRSCOV02 : Prévalence du Covid-19 chez les jeunes enfants hospitalisés avec une pneumonie sévère ou malnutrition aiguë sévère en Afrique sub-saharienne et Asie du Sud Est.	Marilyne Bonnet et Wobudeya Eric.	Cameroun
2020	ANRSCOV06	ANRSCOV06 : AFRCoV-Veille génomique des virus SRAS-CoV-2 sur les marchés de viande de brousse africains, et perceptions des risques sanitaire liés au COVID-19 et à la consommation de viande de brousse.	Gaubert Philippe et Gonedele Bi Ernest.	Cameroun
2020	ANRSCOV10	ANRSCOV10 : Prévalence, diversité génétique et distribution géographique des coronavirus chez les chauves-souris sauvages afin d'évaluer le risque pour de futur transmission.	Martine Peeters et Alpha Keita	Cameroun
2020	ANRSCOV24	ANRSCOV24 : MEDIACAM- Tracking trust and suspicion : Analyzing social media to sharpen COVID-19 public health responses in Cameroon.	Laëticia Atlani-Duault et Marie-Thérèse Mengué	Cameroun
2020	ANRSCOV25	ANRSCOV25 : Négocier ses mouvements et adapter son quotidien. Recueil participatif « sur le vif » des expériences camerounaise face au risque sanitaire, par l'utilisation de l'outil numérique	Lucia Candelise et Julienne Ngo Likeng	
2020	COHIVE	COHIVE: Le projet COHIVE a été conçu dans l'optique de comprendre l'impact de la maladie COVID-19, qui est	Institut Kirby. L'unité TransVIHmi	

		provoquée par le virus SARS-CoV-2 (acronyme anglais de severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 et le sigle officiel du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère), chez les personnes vivant avec le VIH. (UNITAID/ANRS	
2020	ARIACOV	Guider les autorités nationales dans l'élaboration et le renforcement des stratégies nationales de riposte à l'épidémie de COVID-19 dans 4 ou 5 pays d'Afrique francophone	Pr Eric Delaporte
2021	ANRS DATURA	Détermination d'un traitement adéquat pour la tuberculose chez les adultes et adolescents hospitalisé avec une suppression immunitaire sévère associée au VIH	
2022	Eldorado		
2022	Access +		

Annexes 7 : Ouvrages collectifs du site ANRS/MIE Cameroun



1 publication Camerounaise



20 publications Camerounaises



2 publications Camerounaises

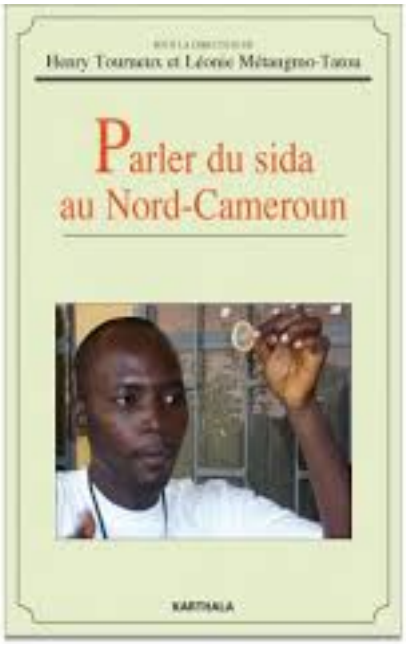


1 publication Camerounaise

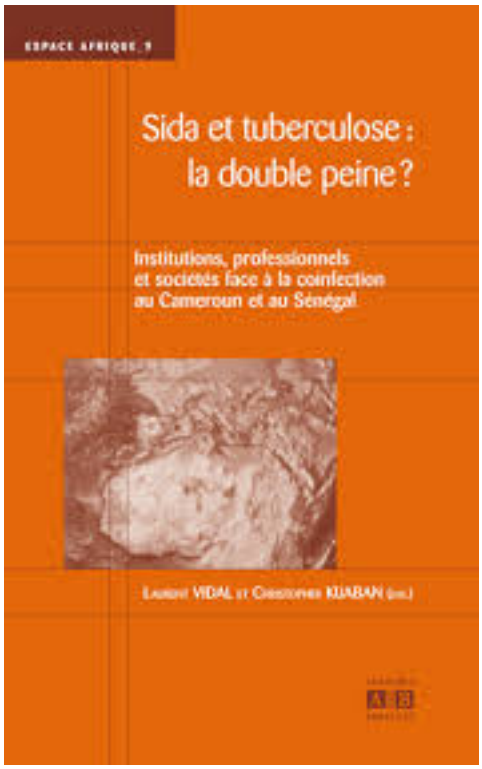
Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande



3 publications Camerounaises



18 publications Camerounaises



9 publications Camerounaises

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande

Annexe 8 : Iconographie



Figure 16 : Site ANRS/MIE Cameroun (Hôpital Central de Yaoundé)



Figure 17 : Bibliothèque site ANRS/MIE Cameroun



Figure 18 : Salle de conférence ANRS/MIE Cameroun



Figure 19 : Salle de convivialité



Figure 20 : Salle d'archivage ANRS/MIE Cameroun

Rédigé par Dr MINLO NYANGON Eliane Fernande